PHYSIQ-ASSESSMENT · CUADERNO DE CONSULTA

Todas las regiones

Cribado, árbol de decisión y confirmación de las 7 regiones · hojas generales

Qué reimprimir

Para imprimir **a doble cara**: cada hoja empieza en la cara delantera de su propio papel (hay páginas en blanco a propósito) y numera sus páginas por sí misma, abajo en la esquina exterior («Cribado · Lumbar 1/2»). Cada hoja lleva su versión («v.») y su QR a la guía de consulta. Escanea el QR: la guía compara este cuaderno con el actual y dice qué hojas han cambiado y qué páginas del PDF imprimir para sustituirlas, junto con esta portada; las demás no cambian aunque ocupe más o menos papel. Si se añadió, quitó o movió una hoja, dice cuál y dónde va.
Último cambio de contenido: **7/11/2026** · orden de hojas desde: **7/11/2026** · cuaderno v. ed503116

ÍNDICE

HOJAS GENERALES		
Fase 1: inicio, cirugía, banderas rojas y riesgo psicosocial	v. 10a4cb10	1 pág.
Condiciones especiales	v. c252801d	1 pág.
Irritabilidad (fase 3)	v. 708321f5	1 pág.
Síntomas (fase 3)	v. 939bcabb	1 pág.
Dermatomas, miotomas y reflejos	v. f659a09c	2 pág.
Plan de tratamiento (fase 6)	v. 6a14a639	3 pág.
Fármacos: qué vigilar en el plan	v. 83bcafb2	2 pág.
Tiempos de recuperación · Partes blandas	v. 7279a518	1 pág.
Tiempos de recuperación · Hueso, articulación y columna	v. de168e4c	1 pág.
CERVICAL		
Cribado (fase 2) · Cervical	v. b1da49ad	3 pág.
Árbol de decisión (fase 4) · Cervical	v. ee88b18c	2 pág.
Confirmación (fase 4b) · Cervical	v. be369a47	1 pág.
HOMBRO		
Cribado (fase 2) · Hombro	v. 9746d799	3 pág.
Árbol de decisión (fase 4) · Hombro	v. 5ab4de71	1 pág.
Confirmación (fase 4b) · Hombro	v. 8ba9eaa3	1 pág.
CODO		
Cribado (fase 2) · Codo	v. d02e73b1	3 pág.
Árbol de decisión (fase 4) · Codo	v. 041e8ec9	2 pág.
Confirmación (fase 4b) · Codo	v. 9a5d7042	1 pág.
LUMBAR		
Cribado (fase 2) · Lumbar	v. 061d53f7	3 pág.
Árbol de decisión (fase 4) · Lumbar	v. a028246f	1 pág.
Confirmación (fase 4b) · Lumbar	v. 53e2dc69	1 pág.
CADERA		
Cribado (fase 2) · Cadera	v. 4d0aa1b6	3 pág.
Árbol de decisión (fase 4) · Cadera	v. b835303d	2 pág.
Confirmación (fase 4b) · Cadera	v. 868c847b	1 pág.
RODILLA		
Cribado (fase 2) · Rodilla	v. c26ecbfc	3 pág.
Árbol de decisión (fase 4) · Rodilla	v. 8d812e7c	2 pág.
Confirmación (fase 4b) · Rodilla	v. a235a5fc	2 pág.
TOBILLO Y PIE		
Cribado (fase 2) · Tobillo y pie	v. e7880e01	3 pág.
Árbol de decisión (fase 4) · Tobillo y pie	v. 0bb9973b	2 pág.
Confirmación (fase 4b) · Tobillo y pie	v. 7beddce2	2 pág.

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

Fase 1

Qué se registra en la fase 1 de la app: mecanismo, cronología, la tarjeta «Cirugía», banderas rojas y riesgo psicosocial. Se marca en la app, o en la calculadora de la guía (QR). Las banderas de cada sistema van con el cribado de la región (en la guía, QR de su hoja de cribado); el motivo y lo que cuenta el paciente, en el formulario del paciente.

Calculadora e IA
v. 10a4cb10

Mecanismo de inicio: Traumático · Insidioso · Post-quirúrgico

Cronología: Agudo (<6 semanas) · Subagudo · Crónico (>3 meses)

🏥 Cirugía (con mecanismo «Post-quirúrgico»)

- **Intervención** y **fecha** (o semanas aproximadas).
- **Protocolo del cirujano:** Escrito · Verbal · No hay.
- **Restricciones** que pone el protocolo.
- **Complicaciones:** Ninguna · Infección · TVP / TEP · Lesión nerviosa · SDRC · Reintervención · otra.

Añade: las preguntas de complicaciones del cribado (fase 2) y la hipótesis «Rehabilitación posquirúrgica», siempre la primera y sin tests: Seguir el protocolo del cirujano; sin protocolo, «Restricciones pendientes de confirmar con el cirujano». Cada pauta de las demás hipótesis: Solo si es compatible con el protocolo del cirujano; donde difieran, prevalece el protocolo.

🚩 Banderas rojas

Marque SI si el paciente presenta cualquiera de los siguientes signos. La presencia de una bandera roja no exige derivación inmediata excepto emergencias claras — interpretar en contexto clínico. Respuesta: Sí · No.

1. Sudor nocturno / Pérdida de peso inexplicada
2. Trauma mayor reciente
3. Déficit neurológico progresivo
4. Dolor no mecánico (no cambia con postura ni movimiento)

Con alguna «Sí»: Se recomienda watchful waiting y/o derivación médica. Puede continuar la evaluación manteniendo monitorización estrecha.

🧠 Riesgo psicosocial

Estratifique según su valoración clínica inicial (Örebro): 🟢 Bajo · 🟠 Medio · 🔴 Alto.

Herramienta recomendada: **Örebro (OMPSQ, 21 ítems)** — validada en castellano de España para dolor musculoesquelético de cualquier región (Cuesta-Vargas 2014).

Con riesgo alto

Riesgo alto detectado. Dedique 2 minutos a clarificar con preguntas abiertas y valore cuestionario unidimensional específico. Respuesta: Sí · No · Dudoso.

Pregunta	Si «Sí» o «Dudoso»
¿El paciente muestra miedo al movimiento o catastrofización?	FABQ (Cuestionario de Creencias de Miedo-Evitación), TSK-11 (Escala de Kinesiofobia de Tampa), PCS (Escala de Catastrofización del Dolor)
¿Hay signos de baja autoeficacia o desesperanza?	CADC (Cuestionario de Autoeficacia en Dolor Crónico)
¿Detecta componente emocional significativo (ansiedad, depresión)?	PHQ-2 → PHQ-9 (Cuestionario de Salud del Paciente)

Un SÍ en una bandera roja no exige derivación inmediata salvo emergencia clara: interpretar en el contexto clínico.

Generado desde los datos de la app (data/fase1.js) el 7/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

Condiciones especiales

Situaciones que cambian el cribado y el plan. Si una encaja, pregunta su bloque de la página 2 de la hoja de cribado (en la app, márcala y añade lo que necesita). Si el paciente ya tiene el diagnóstico, cuenta siempre con ella.

Qué es, fuentes e IA
v. c252801d

Paciente posquirúrgico

Le han operado de la zona que consulta.

Piensa en ello si:

- el problema empezó o sigue tras una operación de esta zona.

Si la tiene, añade: la tarjeta «Cirugía» con el protocolo del cirujano, preguntas de complicaciones en la fase 2 (herida, trombosis, embolia…), la hipótesis «Postoperatorio» y el plan supeditado al protocolo.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; la tarjeta «Cirugía», en la hoja de fase 1 · En la app: fase 1, tarjeta «Mecanismo de Inicio» → Post-quirúrgico · Plan (fase 6): el plan supeditado al protocolo, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

Hipermovilidad / Ehlers-Danlos

Articulaciones mucho más flexibles de lo normal; a veces, una enfermedad del tejido conectivo.

Piensa en ella si:

- se considera una persona «de goma» o muy flexible;
- se le salió el hombro o la rótula más de una vez de niño o adolescente;
- llega con las palmas al suelo sin doblar las rodillas, o con el pulgar al antebrazo.

Si la tiene, añade: su cribado en la fase 2 (cuestionario, escala de Beighton, sospecha del subtipo vascular), un aviso en los tests de laxitud y consideraciones para el plan.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; la calculadora, las líneas de la exploración y las recomendaciones, en la guía (QR) · En la app: fase 1, tarjeta «Hipermovilidad / Ehlers-Danlos» · Plan (fase 6): sus avisos, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

Disautonomía / POTS

El cuerpo no se adapta bien a estar de pie: el corazón se acelera o baja la tensión.

Piensa en ella si:

- desde hace 3 meses o más, estar de pie le da mareo, palpitaciones o cansancio que se pasan al tumbarse;
- le empeora con el calor, después de comer o al levantarse de golpe.

Si la tiene, añade: las preguntas del desmayo de alto riesgo y la prueba de bipedestación en la fase 2, y consideraciones para el ejercicio y el plan.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; sus otras preguntas, la calculadora, las líneas de la exploración y las recomendaciones, en la guía (QR) · En la app: fase 1, tarjeta «Disautonomía / POTS» · Plan (fase 6): sus avisos y su red de seguridad, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

Lupus (LES)

Enfermedad autoinmune que puede dar dolor en varias articulaciones, problemas de piel y fiebre.

Piensa en él si:

- tiene dolor e hinchazón, o rigidez por la mañana de 30 minutos o más, en 2 o más articulaciones, sobre todo de las manos;
- le sale una erupción en la cara que empeora con el sol;
- tiene llagas en la boca que vuelven, se le cae el pelo o tiene fiebre sin infección.

Si la tiene, añade: con «Diagnosticado», sus urgencias y derivaciones en la fase 2 y consideraciones para el ejercicio y el plan; con «Sospecha», los rasgos que justifican una valoración médica.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; sus otras preguntas, las líneas de la exploración y las recomendaciones, en la guía (QR) · En la app: fase 1, tarjeta «Lupus (LES)» · Plan (fase 6): sus avisos y su red de seguridad, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

Trastorno mastocitario o anafilaxia

Los mastocitos liberan sustancias que pueden dar reacciones alérgicas graves (anafilaxia), a veces sin causa clara. Incluye la mastocitosis y el síndrome de activación mastocitaria.

Márcala si:

- un médico le ha diagnosticado una mastocitosis o un trastorno o síndrome de activación mastocitaria;
- ha tenido una anafilaxia (una reacción brusca con falta de aire, mareo o desmayo, con o sin ronchas), también con el ejercicio.

Si la tiene, añade: qué hacer ante una anafilaxia en la sesión, sus desencadenantes, una derivación si tiene episodios nuevos sin valorar y la red de seguridad del plan. Los síntomas crónicos (cansancio, dolor) no bastan para marcarla.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; las líneas de la exploración y las recomendaciones, en la guía (QR) · En la app: fase 1, tarjeta «Trastorno mastocitario o anafilaxia» · Plan (fase 6): su aviso y su red de seguridad, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

Osteoporosis o fragilidad ósea

Hueso con menos masa y peor estructura, que se rompe con un golpe pequeño o sin golpe.

Piensa en ella si:

- tiene 50 años o más y se rompió algo con una caída desde su altura o menos;
- toma corticoides por boca desde hace 3 meses o más;
- está embarazada o dando el pecho y tiene un dolor de espalda nuevo, intenso y que no se pasa.

Si la tiene, añade: su urgencia y sus derivaciones en la fase 2, las caídas, una línea en los tests que cargan el hueso, y el ejercicio, el tope sin thrust y la red de seguridad del plan; con «Sospecha», los factores que piden valorar el riesgo de fractura.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; sus otras preguntas, las líneas de la exploración y las recomendaciones, en la guía (QR) · En la app: fase 1, tarjeta «Osteoporosis o fragilidad ósea» · Plan (fase 6): sus avisos, el tope sin thrust y su red de seguridad, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

Embarazo o posparto

El embarazo y el primer año tras el parto cambian las banderas rojas, la posición en la camilla y el ejercicio.

Márcala si:

- está embarazada (las preguntas dependen de las semanas);
- ha dado a luz en el último año, con cualquier tipo de parto.

Si la tiene, añade: sus urgencias y derivaciones en la fase 2 según las semanas, la regla de la tensión, el ánimo y el suelo pélvico, una línea sobre estar boca arriba en la 4b, y el ejercicio, la terapia manual y la red de seguridad del plan.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; sus otras preguntas, la calculadora, las líneas de la exploración y las recomendaciones, en la guía (QR) · En la app: fase 1, tarjeta «Embarazo o posparto» · Plan (fase 6): sus avisos y su red de seguridad, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

Paciente anticoagulado o antiagregado

Quien toma fármacos para que la sangre no coagule o las plaquetas no se peguen: sangra con más facilidad, y un golpe o una técnica pueden dar un hematoma que no se ve.

Márcala si:

- toma acenocumarol, warfarina, apixabán, rivaroxabán, edoxabán, dabigatrán o heparina;
- toma aspirina, clopidogrel, prasugrel o ticagrelor;
- le han puesto inyecciones de heparina tras una operación o una trombosis.

Si la tiene, añade: la pregunta del golpe en la cabeza y las de los hematomas en la fase 2, una línea de técnica en la 4b, un recuadro en la fase 5, y los avisos, el tope sin thrust (solo con anticoagulante) y la red de seguridad del plan.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; las líneas de la exploración y las recomendaciones, en la guía (QR) · En la app: fase 1, tarjeta «Paciente anticoagulado o antiagregado» · Plan (fase 6): sus avisos, el tope sin thrust y su red de seguridad, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

Parkinson

Enfermedad neurológica que da lentitud, rigidez, temblor y problemas de equilibrio, y que se trata con medicación que hay que tomar a sus horas.

Piensa en ella si:

- tiene temblor, rigidez, lentitud o problemas de marcha sin diagnóstico;
- un dolor de hombro o brazo de un lado con rigidez o menos braceo;
- ya tiene el diagnóstico y viene por otro dolor.

Si la tiene, añade: las preguntas de la fase 2, la medida de la tensión de pie, la línea del estimulador, el recuadro de la fase 5 y los avisos de la fase 6.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; sus otras preguntas, la calculadora, las líneas de la exploración y las recomendaciones, en la guía (QR) · En la app: fase 1, tarjeta «Parkinson» · Plan (fase 6): sus avisos (ejercicio, estimulador y vibración) y su red de seguridad, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

Implantes con electrodos

Aparatos implantados con cables que llevan corriente al corazón, la médula, el cerebro, un nervio o el oído. La onda corta y las microondas pueden calentar los cables y lesionar el tejido de alrededor; la electroterapia puede engañar a un marcapasos o un desfibrilador.

Piensa en ella si:

- lleva marcapasos o desfibrilador;
- le pusieron un estimulador para el dolor de espalda o de piernas, o lleva un implante coclear;
- le quitaron un aparato y no sabe si quedan cables.

Si la tiene, añade: las líneas rojas de la tarjeta, el recuadro de la fase 5 y el aviso de la fase 6.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; las líneas de la exploración y las recomendaciones, en la guía (QR) · En la app: fase 1, tarjeta «Implantes con electrodos» · Plan (fase 6): el aviso de los agentes físicos que limita cada implante, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

SOLO EN UNA REGIÓN

LUMBAR Quiste de Tarlov

Quiste de una raíz nerviosa del sacro; a menudo no da síntomas.

Piensa en él si:

- desde hace meses le duele el sacro, el cóccix o el periné, peor sentado y mejor tumbado,
- con molestias de orina, de heces o sexuales que ya tenía.

Si la tiene, añade: una derivación médica preferente, no urgente. Si algo de vejiga, intestino o silla de montar es nuevo o empeora, no es esto: es la pregunta de la cola de caballo, urgente.

En papel: su pregunta en la hoja de cribado de lumbar · En la app: fase 2, la misma pregunta

LUMBAR Síndrome del cascanueces

Una vena del riñón izquierdo queda pinzada entre dos arterias.

Piensa en él si:

- desde hace meses tiene un dolor sordo en el costado o la zona lumbar izquierda, peor de pie y mejor tumbado,
- y le han encontrado sangre en la orina, o tiene varices en el escroto izquierdo, o (en mujeres) dolor de pelvis que empeora de pie.

Si la tiene, añade: una derivación médica preferente, no urgente, para descartar otras causas.

En papel: su pregunta en la hoja de cribado de lumbar · En la app: fase 2, la misma pregunta

CADERA Síndrome de congestión pélvica

Venas de la pelvis dilatadas que se llenan al estar de pie; el dolor puede notarse en la ingle o la cadera.

Piensa en él si:

- en una mujer, desde hace meses, hay un dolor sordo o de peso en la pelvis, la ingle o la cadera, peor de pie o al final del día y mejor tumbada,
- y varices en la vulva, el periné, el muslo o la nalga, o un dolor que dura horas después de las relaciones sexuales.

Si la tiene, añade: una derivación médica preferente, no urgente, para descartar otras causas. Un dolor pélvico nuevo con retraso de la regla no es esto: es la pregunta del embarazo ectópico, urgente.

En papel: su pregunta en la hoja de cribado de cadera · En la app: fase 2, la misma pregunta

Esta lista orienta: no diagnostica ni marca nada por ti. Las fuentes de cada condición, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app (data/condiciones.js) el 6/11/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

Irritabilidad (fase 3)

La misma matriz y la misma regla que la app (fases 3 y 6): en cada fila, la columna que describe al paciente. Pregunta clave: cuánto tarda en calmarse tras la actividad que lo provoca (minutos → baja; horas → moderada; hasta el día siguiente → alta).

Calculadora e IA
v. 708321f5

	0	1	2
Dolor en reposo	0 Ausente	1 Intermitente	2 Presente
Dolor con movimiento	0 Al final del rango con SP	1 Al final del rango	2 Antes del final del rango
Tolerancia al estrés físico	0 Alta	1 Moderada	2 Baja
Tiempo en calmarse Tras la actividad que lo provoca, hasta volver a su nivel previo. Si le despierta: vuelve a dormirse en menos de 30 min → horas; más de 30 min o con medicación → día siguiente (Petersen 2021).	0 Cede en minutos	1 Tarda horas	2 No cede hasta tras una noche

Cómo se calcula

El **tiempo en calmarse** marca el suelo: minutos → baja, horas → moderada, día siguiente → alta (Maitland 2005, cap. 6, p. 117; Petersen 2021).

Reposo + movimiento + tolerancia (0–2 cada uno, el número de cada opción) solo pueden subirlo: 0–1 baja, 2–4 moderada, 5–6 alta (criterio propio de PhysiQ, inclinado a lo prudente; no hay cortes publicados).

El nivel es el más alto de los dos. Se calcula con lo contestado y avisa si falta alguna fila, porque quedarse corto es el error peligroso. El impacto en las actividades es gravedad y no cuenta aquí.

Qué implica cada nivel

Baja

Puede explorarse «hasta el límite», con sobrepresión, si el dolor no es severo (no obliga a interrumpir la actividad) y la naturaleza del cuadro no pide prudencia (Maitland 2005, cap. 6, pp. 101 y 127–128; Hengeveld y Banks 2005, cap. 6, p. 148).

Moderada

Explorar «hasta el dolor»: solo hasta donde empieza o aumenta, y quizá un poco más para ver cómo se comporta (Maitland 2005, cap. 6, pp. 101 y 127–128; Hengeveld y Banks 2005, cap. 6, p. 148).

Alta

Explorar «hasta el dolor»: solo hasta donde empieza o aumenta, y quizá un poco más para ver cómo se comporta (Maitland 2005, cap. 6, pp. 101 y 127–128; Hengeveld y Banks 2005, cap. 6, p. 148).

Exploración y tratamiento adaptados para no exacerbarlo; la irritabilidad se confirma en la 2.ª visita, por la reacción a la primera (Maitland 2005, cap. 6, p. 117; Hengeveld y Banks 2005, cap. 8, pp. 191–192).

Es un juicio con margen entre fisioterapeutas (acuerdo del 71 %, kappa 0,39–0,44; Barakatt 2009). Matriz incompleta: el nivel puede quedarse corto.

El impacto en las actividades (mínima · moderada · alta) es gravedad: se anota aparte, junto al NRS.

Generado desde los datos de la app (data/irritabilidad.js, lib/irritabilidad.js) el 7/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

Síntomas (fase 3)

Qué registrar de cada síntoma, como en la tarjeta «Síntomas» de la app: el principal (P1) y hasta tres más. Las zonas de cada región y los pasos del árbol donde la app las recuerda, en la guía (QR).

Zonas y pasos
v. 939bcabb

P1 · síntoma principal

- **Zona:** una o varias de la región (en la guía, con el QR), o descrita con sus palabras.
- **Lado:** Derecho · Izquierdo · Bilateral · Central. Si no se marca, es el de la región.
- **Profundidad:** Superficial · Profunda.
- **Patrón:** Constante · Intermitente.
- **Cómo es:** Quemazón · Punzante · Sordo · Hormigueo · Adormecimiento · Calambre · Opresivo, o con las palabras del paciente.
- **NRS e irritabilidad:** las de la fase 3 (hoja de irritabilidad).

P2–P4 · hasta tres más

- **Zona:** como P1, u «otra región (no valorada hoy)», que solo lleva lado, NRS y una nota.
- **Lado, profundidad, patrón:** como P1.
- **NRS:** el suyo, de 0 a 10.
- **Irritabilidad:** Baja · Moderada · Alta, estimada directamente.
- **Con P1:**
  - **Van juntos**: aparece y desaparece con P1
  - **Si P1 empeora**: solo cuando empeora P1
  - **Independiente**: independiente de P1
  - **No lo sabe**: relación con P1 no conocida

- Un síntoma en otra región («no valorada hoy») solo lleva lado, NRS y una nota: no entra en el árbol.
- Pregunta cómo es con sus palabras y anótalas tal cual: la descripción del paciente vale más que la etiqueta.
- La zona de un síntoma recuerda, en los pasos del árbol (lista en la guía), lo que refiere el paciente: nunca contesta el paso.
- En la app, el plan de la fase 6 se dosifica por el síntoma más irritable (P1 si empatan) y avisa de un síntoma «Independiente» de P1.

⚠️ **Lumbar · Periné, ano o genitales: Si hay pérdida de sensibilidad en silla de montar o cambios al orinar o al hacer de vientre nuevos o que van a más, es la pregunta de cauda equina de la fase 2: urgencia hoy, aunque se conozca un quiste de Tarlov. Si son antiguos y el dolor empeora sentado y se alivia tumbado, repasa la del quiste de Tarlov.**

Generado desde los datos de la app (data/<región>.js, lib/sintomas.js) el 7/11/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

Dermatomas, miotomas y reflejos

Dónde explorar cada raíz: su punto sensitivo clave, su músculo clave y los reflejos que la incluyen. Es para orientar la exploración: una raíz no se diagnostica con un solo hallazgo.

Por qué, técnica e IA
v. f659a09c

Raíz	Punto sensitivo clave	Músculo clave · posición para el grado 4–5	Reflejo que la incluye
C5	Cara radial de la fosa del codo, justo por encima del pliegue	**Flexores del codo (bíceps, braquial)** Codo a 90°, brazo junto al cuerpo, antebrazo en supinación	Bicipital, Braquiorradial
C6	Pulgar, cara dorsal de la falange proximal	**Extensores de la muñeca (radiales largo y corto)** Muñeca en extensión completa	Bicipital, Braquiorradial
C7	Dedo medio, cara dorsal de la falange proximal	**Extensores del codo (tríceps)** Hombro en rotación neutra, en aducción y a 90° de flexión; codo a 45°	Tricipital
C8	Meñique, cara dorsal de la falange proximal	**Flexor profundo del dedo medio** Falange distal en flexión completa, con las articulaciones proximales sujetas en extensión	Tricipital
T1	Cara cubital de la fosa del codo, justo por encima del epicóndilo medial	**Abductor del meñique** Dedos en abducción completa	—
L2	Cara anteromedial del muslo, a medio camino entre el punto medio del ligamento inguinal y el cóndilo femoral medial	**Flexores de la cadera (iliopsoas)** Cadera a 90° de flexión	Rotuliano
L3	Cóndilo femoral medial, por encima de la rodilla	**Extensores de la rodilla (cuádriceps)** Rodilla a 15° de flexión	Rotuliano
L4	Maléolo medial	**Flexores dorsales del tobillo (tibial anterior)** Tobillo en flexión dorsal completa	Rotuliano
L5	Dorso del pie, a la altura de la tercera articulación metatarsofalángica	**Extensor largo del dedo gordo** Dedo gordo en extensión completa	—
S1	Cara lateral del talón (calcáneo)	**Flexores plantares del tobillo (gemelos, sóleo)** Cadera neutra, rodilla en extensión completa, tobillo en flexión plantar completa	Aquíleo

Raíces sin músculo clave: solo su punto sensitivo

C2	Al menos 1 cm lateral a la protuberancia occipital (o 3 cm detrás de la oreja)
C3	Fosa supraclavicular, en la línea medioclavicular
C4	Sobre la articulación acromioclavicular
T2	Vértice de la axila
T3–T11	Línea medioclavicular, en el espacio intercostal del mismo número (T4 a la altura del pezón, T6 de la apófisis xifoides, T10 del ombligo)
T12	Punto medio del ligamento inguinal
L1	A medio camino entre los puntos de T12 y L2
S2	Punto medio de la fosa poplítea
S3	Tuberosidad isquiática o pliegue infraglúteo
S4-5	Alrededor del ano, a menos de 1 cm de la unión mucocutánea (un solo nivel)

Fuerza (0–5)

- 0: no hay contracción.
- 1: contracción que se ve o se palpa, sin movimiento.
- 2: movimiento activo de todo el recorrido sin la gravedad.
- 3: movimiento activo de todo el recorrido contra la gravedad.
- 4: todo el recorrido contra una resistencia moderada, en la posición del músculo.
- 5: todo el recorrido contra la resistencia completa que se esperaría en esa persona sin lesión.
- NT: no valorable (inmovilización, dolor que impide puntuar, amputación, contractura de más de la mitad del recorrido).

Las posiciones de la tabla son para distinguir 4 de 5. Explora en decúbito supino, de arriba abajo, cada lado por separado y en isométrico (Rupp 2021).

Sensibilidad (0–2)

- 0: ausente.
- 1: alterada (menos o más que en la mejilla).
- 2: normal, como en la mejilla.
- NT: no valorable.

Compara siempre con la mejilla. Tacto ligero con una mota de algodón, en menos de 1 cm de piel y con los ojos cerrados; pinchazo con la punta y la parte roma de un imperdible, y si hay dudas, ocho aciertos de diez (Rupp 2021).

Reflejos osteotendinosos

Reflejo	Raíces	Nervio	Dónde golpear
Bicipital	C5–C6	musculocutáneo	sobre el tendón del bíceps, justo por delante del codo
Braquiorradial	C5–C6	radial	en la cara radial del antebrazo, unos 10 cm por encima de la muñeca
Tricipital	C7–C8, sobre todo C7	radial	sobre el tendón del tríceps, justo por detrás del codo
Rotuliano	L2–L4, sobre todo L4	femoral	sobre el tendón rotuliano, justo por debajo de la rótula
Aquíleo	S1	tibial	sobre el tendón de Aquiles, por detrás del tobillo

Escala, técnica e interpretación de los reflejos: en la página 2. La exploración de la ISNCSCI no incluye los reflejos: los de esta hoja vienen de otra fuente (Rupp 2021; Zimmerman y Hubbard 2023).

Datos de la ISNCSCI (Rupp 2021, © ASIA) escritos con nuestras palabras; sin su tabla ni su figura. Fuentes: Rupp 2021 · Lee 2008 · Downs y Laporte 2011 · Zimmerman y Hubbard 2023 · Margetis y Hall 2026 · Assir y Das 2022. Generado desde los datos de la app (data/neuro.js) el 7/11/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Ilustraciones: con el móvil sobre la hoja

Recomendada: hoja oficial de ASIA
La hoja oficial de exploración de ASIA (ISNCSCI, en español), con el dibujo de los puntos clave, se puede copiar libremente pero no modificar; en la página de ASIA, elige «Spanish». Gratuita y sin cuenta.

Dermatomas (Kenhub)
Los puntos de la tabla y las bandas de los libros, dibujados. Se ve sin cuenta (puede pedir registrarse, gratis); con cuenta, también las tablas.

Miotomas (Kenhub)
Los puntos de la tabla y las bandas de los libros, dibujados. Se ve sin cuenta (puede pedir registrarse, gratis); con cuenta, también las tablas.

Reflejos: escala y técnica

Escala (0–4)

- 0: ausente.
- 1: menor de lo normal, o solo con refuerzo.
- 2: en la mitad baja de lo normal.
- 3: en la mitad alta de lo normal.
- 4: aumentado; incluye el clono.

Los niveles del rotuliano y del aquíleo varían entre fuentes, e incluso dentro del mismo capítulo (Zimmerman y Hubbard 2023).

Con el músculo relajado y la articulación hacia los 90°, mira la contracción del músculo más que el movimiento, y compara enseguida con el otro lado. Si no sale, usa el refuerzo: apretar los dientes o la maniobra de Jendrassik, que es para el miembro inferior (Zimmerman y Hubbard 2023).

Lo que más pesa es la asimetría. Unos reflejos simétricos entre 1 y 3 se consideran normales sin otros signos, y un reflejo aislado más vivo o más débil, sin más hallazgos, no suele ser patológico; incluso ausente en los dos lados puede ser normal. Aumentado apunta a neurona motora superior y disminuido a neurona motora inferior (Zimmerman y Hubbard 2023).

Signos de neurona motora superior: no son de una raíz

- Hoffmann: sujeta la base del dedo medio y golpea rápido su falange distal; es positivo si flexionan los dedos y el pulgar (Margetis y Hall 2026).
- Babinski: pasa un estímulo firme pero no doloroso por el borde externo de la planta, del talón a los dedos; es positivo si el dedo gordo se extiende y los demás se abren en abanico (Margetis y Hall 2026).
- Clono: estira rápido el músculo y mantén el estiramiento; son contracciones rítmicas, sobre todo en el tobillo y la rótula. La fuente no da un número de batidas en el adulto (Margetis y Hall 2026).
- Espasticidad: el tono aumenta con la velocidad del estiramiento; despacio no se nota (Margetis y Hall 2026).
- Con trofismo normal, hipertonía, hiperreflexia, clono o Babinski, piensa en neurona motora superior; con atrofia, fasciculaciones, hipotonía e hiporreflexia, en neurona motora inferior (Assir y Das 2022).

Un Hoffmann aislado, sin síntomas ni otros hallazgos, no cambió el manejo ni justificó una prueba de imagen (Margetis y Hall 2026). Con síntomas o más signos, valoración médica: la exploración sola no basta para decidir (Assir y Das 2022). Si encajan con una mielopatía cervical o una cola de caballo, usa sus preguntas de urgencia del cribado.

Por qué puntos y no bandas

- Los mapas de dermatomas de los libros no coinciden entre sí y casi ninguno muestra que los dermatomas vecinos se solapan (Lee 2008; Downs y Laporte 2011).
- Casi toda la piel la inervan dos o más raíces, y en el miembro superior se espera más variación que en el resto; los dermatomas son mayores de lo que dibujan los libros (Lee 2008).
- Por eso la tabla da puntos y no bandas: explora el punto clave y compara con el otro lado (Rupp 2021).
- La mayoría de las raíces inervan más de un músculo y la mayoría de los músculos reciben más de una raíz: un músculo por raíz es una simplificación (Rupp 2021).

Raíz o nervio periférico

- Si la alteración sensitiva sigue el territorio de un nervio cutáneo, lo más probable es el nervio periférico; si sigue un dermatoma, la raíz o lo que hay por encima del plexo (Downs y Laporte 2011).
- La sensibilidad sola no da el diagnóstico, pero es una herramienta importante (Downs y Laporte 2011).
- La debilidad de neurona motora superior afecta a grupos de músculos; la de una lesión de neurona motora inferior puede paralizar músculos sueltos (Margetis y Hall 2026).

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Plan de tratamiento (fase 6)

El contenido fijo del que la app elige el plan (data/plan-tratamiento.js), con su fuente. La propuesta para un paciente concreto (escalón, avisos de sus hipótesis y condiciones, red de seguridad), en la guía (QR). Es una propuesta: decide el fisioterapeuta.

Calcular el plan
v. 6a14a639

Cómo se elige el escalón (B)

Se cruzan la gravedad (por la NRS) y la irritabilidad (la de la hoja de irritabilidad; sin registrar, alta).

Escalón B	Gravedad mínima (NRS 0–3)	Moderada (4–7)	Máxima (8–10) o sin NRS
Irritabilidad alta	1	1	1
Moderada	2	2	1
Baja	3	3	3

A: un escalón por debajo de B (no hay A por debajo del 1). **C**: un escalón por encima de B, solo con irritabilidad baja y síntomas que no empeoran. Sin propuesta C: la irritabilidad no es baja (Petersen 2021; Maitland 2005, cap. 6, p. 117).

Familia: columna (lumbar, cervical, y las hipótesis h6, ca10) o periférica (las demás regiones).

La propuesta completa para un paciente, con sus hipótesis y condiciones: guía (QR).

Escalones · columna (Maitland 2005)

1 · Muy suave (Manda el dolor) Sin provocar dolor: posición cómoda y sin molestias, la mayor amplitud posible sin molestia, movimiento lento y suave (grados I y II). Corta al principio, hasta conocer la respuesta a las 48 h. Explorar solo hasta el límite activo. (Maitland 2005, cap. 8, p. 203; cap. 9, p. 218; Petersen 2021, tabla 2 y apartado de irritabilidad)

2 · Suave (Manda el dolor) Hasta donde empieza el dolor, sin sobrepasarlo (grado II); cuando el dolor baje, grado III. Con prudencia al acercarse al dolor, por el riesgo de que tarde en ceder. (Maitland 2005, cap. 6, p. 101; cap. 9, p. 218; Petersen 2021, apartado de irritabilidad)

3 · Moderada (Molestia controlada) Hasta una molestia controlada que no aumente mientras se aplica la técnica (grado III); si lo que se provoca cede enseguida, hasta el límite pasivo. Primero la misma técnica a la misma velocidad hacia la molestia; después, la posición hacia la dirección dolorosa. (Maitland 2005, cap. 8, pp. 206–208; Petersen 2021, apartado de irritabilidad)

4 · Firme (Manda la rigidez) Solo si domina la rigidez y las estructuras no están debilitadas por un traumatismo o una enfermedad: al final del recorrido, técnica firme (grado IV), amplitud sobre todo pequeña con alguna grande, intercalando movimientos activos. Respetar la molestia, sobre todo si se va sumando; un grado III suave alivia la que deje. (Maitland 2005, cap. 8, p. 203; cap. 9, p. 218)

Escalones · periféricas (Hengeveld y Banks 2005)

1 · Muy suave (Manda el dolor) Sin provocar dolor: un accesorio en posición indolora y apoyada antes que un fisiológico, con la mayor amplitud posible sin molestia y oscilaciones lentas y suaves (grados I y II). Mejor quedarse corto al principio, hasta conocer la irritabilidad. Explorar solo hasta el límite activo. (Hengeveld y Banks 2005, cap. 7, p. 176; cap. 8, p. 192; Petersen 2021, tabla 2 y apartado de irritabilidad)

2 · Suave (Manda el dolor) Hasta donde empieza el dolor, sin sobrepasarlo: con dolor a lo largo del recorrido, de grado II− a III+. Con prudencia al acercarse al dolor, por el riesgo de que tarde en ceder. (Hengeveld y Banks 2005, cap. 6, p. 148; cap. 7, tabla 7.2, p. 176; Petersen 2021, apartado de irritabilidad)

3 · Moderada (Molestia controlada) Entrar en una molestia controlada, de un 10–20 % de su intensidad máxima, que no aumente mientras se aplica la técnica (grado III); si lo que se provoca cede enseguida, hasta el límite pasivo. (Hengeveld y Banks 2005, cap. 8, pp. 192–194; Petersen 2021, apartado de irritabilidad)

4 · Firme (Manda la rigidez) Solo si domina la rigidez: al límite del recorrido, estiramiento oscilatorio de grado IV que progresa a IV+ y IV++, con ritmo «staccato», alternando fisiológicos y accesorios. Nunca técnicas firmes con ligamentos debilitados por una enfermedad (p. ej., artritis reumatoide), ni empujar a través de un espasmo. (Hengeveld y Banks 2005, cap. 7, pp. 174–176; cap. 8, pp. 197, 203 y 224–225)

Sesión de 50 min

Reevaluación 5′ · Educación 7′ · Intervención principal 23′ · Programa domiciliario 10′ · Cierre 5′ (organización de la sesión, no evidencia)

Reevaluación: Signo comparable y la actividad que el paciente refiere como control (Maitland 2005, cap. 6, pp. 100–101 y 128). En las siguientes: cómo reaccionó a la sesión anterior, en sus palabras y comparado con antes («D más 1», Maitland 2005, cap. 6, p. 156; cap. 9, tabla 9.3; Hengeveld y Banks 2005, cap. 9, p. 246).

Educación: Explicar la hipótesis y el plan, y lo que puede notar. Avisar de un posible aumento temporal de los síntomas tras esta primera sesión (Maitland 2005, cap. 9, p. 219; Hengeveld y Banks 2005, cap. 9, p. 243).

Primera sesión: Primera sesión: menos tratamiento que en las siguientes, porque el primer estiramiento provoca más reacción (Maitland 2005, cap. 9, p. 219).

Cantidad (columna): Evaluar antes, durante y después de cada técnica; unas 3–4 movilizaciones de unos 30 s por articulación, la mitad si duele mucho (Maitland 2005, cap. 9, pp. 213, 216 y 219).

Cantidad (periféricas): Evaluar antes, durante y después de cada técnica. Con dolor: técnicas de 30 s a 2 min, una o dos veces, lentas y suaves. Con rigidez: unos 2 min de estiramiento oscilatorio, alternando fisiológicos y accesorios al límite, 3–4 veces en la sesión inicial; de media, 4–5 min por articulación cada vez. Con dolor y rigidez, estirar 3 o más veces, 1–2 min cada una (Hengeveld y Banks 2005, cap. 5, pp. 97–102; cap. 7, p. 175; cap. 8, pp. 192, 197–198 y 201).

Domiciliario: Enseñar y comprobar lo que hará en casa. **Cierre:** Reevaluar el signo comparable y explicar qué vigilar hasta la próxima sesión: al levantarse, en el trabajo o la actividad, por la noche y tras los ejercicios (Maitland 2005, cap. 9, p. 213 y tabla 9.3, «Después»; Hengeveld y Banks 2005, cap. 9, p. 243).

Generado desde los datos de la app (data/plan-tratamiento.js) el 6/11/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Plan de tratamiento (continuación)

Plan del mes

Plan A · 1 sesión por semana: 4 sesiones; reevaluación intermedia sesión 2 (semana 2), final sesión 4; programa domiciliario: alto: es la mayor parte de la carga del mes.

- Maitland evalúa la respuesta a las 24–48 h y pide sesiones lo bastante frecuentes para valorar el efecto; con una por semana la comparación es semanal (Maitland 2005, cap. 9, p. 219 y tabla 9.3). Pedir al paciente que anote cómo estuvo a las 24 h de cada sesión y, si las molestias aumentan, qué estaba haciendo y qué le ayudó (Hengeveld y Banks 2005, cap. 9, p. 247).

Plan B · 2 sesiones por semana: 8 sesiones; reevaluación intermedia sesión 4 (semana 2), final sesión 8; programa domiciliario: medio.

- Con movilización neural vigorosa, dejar al menos 2–3 días entre sesiones y reevaluar a las 24 h (Maitland 2005, cap. 6, p. 149).

Progresión

Si la pauta trae su propio criterio de progresión, ese manda. Si no: al principio lo mínimo que no provoque recaída; reintroducir lo que agravaba cuando baje la irritabilidad; progresar al ritmo de la curación y de los síntomas; reevaluar dentro de la sesión y entre sesiones (Petersen 2021; Zusman 1998).

Periféricas: Terapia manual en una articulación periférica: empezar con un accesorio en posición indolora y apoyada; pasar a movimientos fisiológicos cuando el recorrido activo supere el 60 % del normal (con dolor y rigidez, el 60 % del recorrido rígido disponible) y, hasta el 75 %, quedarse antes del punto donde empieza el dolor; después, entrar en una molestia controlada (un 10–20 % de su intensidad máxima), y movimientos fisiológicos amplios cuando el dolor solo aparezca en el último 40 % del recorrido. Si no está claro si domina el dolor o la rigidez, tratar primero el dolor; con dudas al pasar a fisiológicos, repetir unas sesiones más los accesorios, y si empeora, volver a ellos (Hengeveld y Banks 2005, cap. 8, pp. 192–196 y 200).

Seguir o cambiar · columna

- Si una técnica no cambia nada, repetirla más firme; si sigue sin cambio, descartarla. Si mejora, repetirla; si empeora, no repetirla (Maitland 2005, cap. 9, pp. 213–214).
- Si se espera una mejora lenta, no cambiar una técnica antes de usarla dos sesiones o más (Maitland 2005, cap. 9, pp. 214 y 216).
- Con una mejora del 75 % o más en una sesión, no subir la dosis: esperar 48 h o repetir igual o menos (Maitland 2005, cap. 9, p. 216).
- La movilización que funciona debería mostrar una mejora marcada en 4–5 días (Maitland 2005, cap. 9, p. 220).
- Sin cambio en 10–14 días, pausa y reevaluación a los 7–14 días; devolver al médico si los signos no siguen los patrones habituales o el paciente no mejora (Maitland 2005, cap. 9, pp. 219–220 y 223).

Seguir o cambiar · periféricas

- Si mejora o no cambia, repetir la misma técnica; si empeora, la misma con menos amplitud y más lejos del dolor (Hengeveld y Banks 2005, cap. 8, p. 192).
- No cambiar una técnica demasiado pronto: puede hacer falta repetirla hasta la 2.ª visita, y a veces aplicarla dos veces antes de juzgarla (Hengeveld y Banks 2005, cap. 8, pp. 191 y 206).
- Revisión retrospectiva cada 4 sesiones, y entre la 3.ª y la 4.ª sesión, un pronóstico explícito (Hengeveld y Banks 2005, cap. 5, p. 106; cap. 8, p. 233).
- Si se estanca, pausa de unas 2 semanas; si mejoró, 2–3 semanas más sin tratamiento o el alta; si sigue igual, 4–5 sesiones más y otra pausa (Hengeveld y Banks 2005, cap. 5, pp. 106–108; Maitland 2005, cap. 9, pp. 219–220). Devolver al médico si los signos no siguen los patrones habituales o el paciente no mejora (Maitland 2005, cap. 9, p. 223).

Generado desde los datos de la app (data/plan-tratamiento.js) el 6/11/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Red de seguridad por región (cierre de la sesión)

Cervical

- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir a urgencias (dolor de cabeza o de cuello de golpe y distinto a cualquier otro, visión doble, dificultad para hablar o tragar, inestabilidad al caminar o caídas súbitas) y comprobar que lo ha entendido; los de una disección pueden llegar días después (Rushton 2023, tablas 1–2 y 6, pp. 9–12).
- *Con hipótesis neurológica:* Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir a urgencias (torpeza nueva en las manos, inestabilidad o piernas «pesadas» al caminar, cambios al orinar o al hacer de vientre) y comprobar que lo ha entendido (Margetis y Donnally 2025, anamnesis y exploración).

Hombro

- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen llamar al 112 (dolor u opresión en el pecho, el hombro, el brazo, el cuello, la mandíbula o la espalda que no se pasa al parar en unos 20 minutos, o que viene con sudor frío, náuseas, vómitos o falta de aire) y comprobar que lo ha entendido (Goodman 2018, cap. 6, pp. 236 y 260, como en el razonamiento de h_c4).

Codo

- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir hoy mismo al médico o a urgencias (el codo se pone rojo, caliente e hinchado, aunque no haya fiebre) y comprobar que lo ha entendido (Momodu y Savaliya 2023; Pangia 2025, como en el razonamiento de co1).

Lumbar

- *Con hipótesis neurológica:* Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir a urgencias (adormecimiento entre las piernas o alrededor del ano, cambios al orinar o al hacer de vientre) y comprobar que lo ha entendido (Finucane 2020, sección 2, pp. 9–17).

Cadera

- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen dejar la actividad que lo empeora e ir hoy mismo al médico (dolor de ingle o de cadera que va a más al apoyar el peso o con la actividad y aparece también de noche: posible fractura de estrés del cuello del fémur, que una radiografía negativa no descarta) y comprobar que lo ha entendido (Lluch 2020; Goodman 2018; May y Marappa-Ganeshan 2023, como en el razonamiento de ca_os1).
- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir hoy mismo a urgencias (la cadera duele mucho, hasta no poder apoyar la pierna, con fiebre o malestar general) y, con una prótesis, cuáles piden ir al médico (un dolor nuevo que no cede en reposo y sigue de noche, sobre todo tras una infección), y comprobar que lo ha entendido (Momodu y Savaliya 2023; Goodman 2018, como en el razonamiento de ca_in1 y ca_in3).
- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir hoy mismo al médico o a urgencias (la pantorrilla hinchada, caliente, más roja o dolorida que la otra) y cuáles, llamar al 112 (falta de aire de repente o dolor en el pecho al respirar), y comprobar que lo ha entendido (Waheed 2023; NICE NG158; Vyas 2024, como en el razonamiento de r_v2 y pq_tep).

Rodilla

- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir hoy mismo al médico o a urgencias (la rodilla, o la zona de delante de la rótula, se pone roja, caliente e hinchada, aunque no haya fiebre) y comprobar que lo ha entendido (Momodu y Savaliya 2023; Truong 2023, como en el razonamiento de r1 y r_i3).
- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir hoy mismo al médico o a urgencias (la pantorrilla hinchada, caliente, más roja o dolorida que la otra) y cuáles, llamar al 112 (falta de aire de repente o dolor en el pecho al respirar), y comprobar que lo ha entendido (Waheed 2023; NICE NG158; Vyas 2024, como en el razonamiento de r_v2 y pq_tep).

Tobillo y pie

- Red de seguridad: explicar qué síntomas piden dejar la actividad que lo empeora e ir al médico (un dolor del pie o del tobillo que empieza poco a poco, va a más con la carga o la actividad, no mejora al calentar y molesta por la noche: posible fractura de estrés, que la radiografía tarda 2–3 semanas en mostrar) y comprobar que lo ha entendido (May y Marappa-Ganeshan 2023; Lluch 2020, como en el razonamiento de tp_o1).
- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir hoy mismo a urgencias (el tobillo o una articulación del pie hinchada, caliente y muy dolorosa, con fiebre o malestar general) y cuáles, hoy mismo al médico (lo mismo de golpe, aunque no haya fiebre), y comprobar que lo ha entendido (Momodu y Savaliya 2023; Goodman 2018, como en el razonamiento de tp_i1).
- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir hoy mismo al médico o a urgencias (la pantorrilla hinchada, caliente, más roja o dolorida que la otra) y cuáles, llamar al 112 (falta de aire de repente o dolor en el pecho al respirar), y comprobar que lo ha entendido (Waheed 2023; NICE NG158; Vyas 2024, como en el razonamiento de r_v2 y pq_tep).

Red de seguridad por condición especial

Lupus

- Red de seguridad (lupus): explicar que la fiebre, los escalofríos o un malestar general nuevos piden ir hoy mismo al médico, y que con su tratamiento una infección puede dar poca fiebre; comprobar que lo ha entendido (Rao y Mikdashi 2023; Yasir 2023).
- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir hoy mismo al médico o a urgencias (la pantorrilla hinchada, caliente, más roja o dolorida que la otra) y cuáles, llamar al 112 (falta de aire de repente o dolor en el pecho al respirar), y comprobar que lo ha entendido (Waheed 2023; NICE NG158; Vyas 2024, como en el razonamiento de r_v2 y pq_tep).
- Red de seguridad (lupus): explicar que la debilidad o el adormecimiento de un lado, la dificultad para hablar o la pérdida de visión de golpe piden llamar al 112, aunque se pasen (Goodman 2018, cap. 12, p. 445; Drosos 2022, p. 773).

Disautonomía

- Red de seguridad (disautonomía): explicar que, si se desmaya mientras hace ejercicio, debe parar y no volver a hacer ejercicio hasta que le vea el médico, y comprobar que lo ha entendido (NICE CG109, 1.3.2.2 y 1.5.4.3; Brignole 2018, p. 1911).

Trastorno mastocitario o anafilaxia

- Red de seguridad (trastorno mastocitario o anafilaxia): explicar que, si le salen ronchas, se le hincha la boca, le falta el aire, se marea o se desmaya, debe parar, ponerse el autoinyector y llamar al 112, tumbado y sin levantarse de golpe aunque mejore, y comprobar que lo ha entendido (RCUK 2021, apartados 4.4 y 5.1.1; NICE NG258, 1.1.14).

Osteoporosis

- Red de seguridad (osteoporosis): explicar que un dolor de espalda fuerte que empieza de golpe tras un esfuerzo pequeño pide parar y que le vea el médico, y que si además nota debilidad u hormigueo en las piernas, o cambios al orinar, debe ir a urgencias (Gregson 2025; Finucane 2020, sección 3).

Embarazo

- Red de seguridad (embarazo): explicar que el dolor de cabeza fuerte, la visión borrosa, el dolor fuerte bajo las costillas o la hinchazón brusca de la cara o las manos piden que la vea un profesional hoy; que si nota que el bebé se mueve menos llame a su maternidad a cualquier hora, y que si sangra, pierde líquido o tiene contracciones regulares y dolorosas, pare y llame (NICE NG133, 1.1.1; NICE NG201, 1.2.34; Mottola 2018, recuadro 2).

Posparto

- Red de seguridad (posparto): explicar que un sangrado brusco o muy abundante, la fiebre o los escalofríos, el flujo maloliente, la pierna hinchada y dolorosa, la falta de aire, el dolor en el pecho o un dolor de cabeza fuerte piden consulta médica sin demora, y comprobar que lo ha entendido (NICE NG194, 1.2.4).

Anticoagulado o antiagregado

- Red de seguridad (anticoagulado o antiagregado): explicar que un golpe en la cabeza, aunque se encuentre bien, pide ir a urgencias, y que un dolor de cabeza fuerte, vómitos, somnolencia o confusión en los días siguientes piden llamar al 112; que un dolor fuerte de cuello o espalda con debilidad u hormigueo, un dolor muy fuerte en la ingle, la cadera o la barriga con mareo, o un brazo o una pierna muy hinchados y tensos con un dolor desproporcionado piden urgencias; si lo toma por una trombosis, que la falta de aire brusca, el dolor en el pecho al respirar o la tos con sangre piden llamar al 112, y que la pierna que se hincha más, se calienta o duele más pide que le vea un médico hoy; y que no deje ni se salte el fármaco sin hablarlo con su médico (NICE NG232, 1.2.4 y 1.10.9; Peng 2022; Lukies 2023; Brooker 2020; Vyas 2024; NICE NG158; Steffel 2021).

Parkinson

- Red de seguridad (Parkinson): explicar que si en los próximos días está mucho más rígido o inmóvil con fiebre, confusión o mucho sudor, o no puede tomar su medicación, debe ir a urgencias (Pötter-Nerger 2024; NICE NG71, 1.3.2).
- Red de seguridad (Parkinson): explicar que pare el ejercicio y consulte si nota náuseas, dolor u opresión en el pecho que dura más de unos minutos, falta de aire fuera de lo normal, mareo, palpitaciones o sudor frío (Keus 2014, 6.7.5).

Generado desde los datos de la app (data/plan-tratamiento.js) el 6/11/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

Fármacos: qué vigilar en el plan

No le digas que deje ni cambie la medicación: las dudas, a quien la prescribe. Aquí, lo que cambia el plan de tratamiento; cómo afecta cada familia al dolor, los síntomas viscerales, el ejercicio y el sueño, y su ficha técnica (CIMA), en la guía (QR).

Guía completa e IA
v. 83bcafb2

AINE (antiinflamatorios no esteroideos)

Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, dexketoprofeno, celecoxib, etoricoxib

- Deshidratación y calor: el efecto de los AINE sobre el riñón empeora con deshidratación, poca perfusión renal o daño renal previo (Lucas 2019), y la deshidratación y el ejercicio intenso con calor reducen además el riego intestinal (Papantoniou 2023). Vigila la hidratación en sesiones largas o con calor.
- Anota si tomó una dosis antes de la sesión.

Corticoides

Prednisona, metilprednisolona, dexametasona; infiltraciones (triamcinolona, betametasona)

- Fractura: el riesgo sube a los 3–6 meses de empezar y depende de la dosis (Compston 2018), incluso desde 2,5 mg/día; es mayor en los primeros meses, baja alrededor de un 30 % a los 6 meses de dejarlos y se normaliza a los 12 (Pofi 2023).
- Infección: quien toma corticoides puede no dar los signos y síntomas habituales de una infección, porque frenan la respuesta inflamatoria y la fiebre, y eso retrasa reconocerla (Yasir 2023; Liu 2013).
- Miopatía: el ejercicio puede atenuarla según los estudios que cita una cohorte, en la que los síntomas mejoraron tras una mediana de 107 días; recomienda cribar las caídas en mayores de 50 años (He 2025).
- Terapia manual: una revisión de casos de efectos adversos del thrust torácico pone la medicación con corticoides a largo plazo, sin definir la dosis ni la duración, entre las contraindicaciones absolutas del thrust en la columna torácica; su tabla sale de un trabajo de una escuela de osteopatía, no de una guía (Puentedura 2015). En el plan de tratamiento, la app quita el thrust con la tarjeta «Osteoporosis o fragilidad ósea» y cuando la tarjeta «Lupus (LES)» registra corticoides o dosis altas previas. Las fuentes leídas no dan normas para la carga ni para el resto de la terapia manual: tenlo en cuenta al elegir carga axial intensa.

Anticoagulantes y antiagregantes

Acenocumarol, warfarina, apixabán, rivaroxabán, edoxabán, dabigatrán, heparinas; ácido acetilsalicílico, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor

Se marcan en su propia tarjeta de la fase 1, «Paciente anticoagulado o antiagregado», que añade su cribado, sus avisos y su red de seguridad (ver también la hoja de condiciones especiales).

Opioides

Tramadol, tapentadol, codeína, morfina, oxicodona, fentanilo, buprenorfina

- Mareo, somnolencia y caídas: frente a placebo dan más mareo y somnolencia (Dowell 2022). En mayores producen sedación, falta de coordinación, mareo y caídas, con más fracturas de cadera y no vertebrales (Dufort y Samaan 2021).
- El ejercicio terapéutico reduce el dolor y mejora la función en la lumbalgia, la fibromialgia y la artrosis de cadera o rodilla, con beneficios que se mantienen 2–6 meses, y puede sumarse a la medicación (Dowell 2022).
- Con el tramadol, el riesgo de depresión respiratoria es mayor al empezar o al subir la dosis, en las 24–72 h siguientes (Dhesi 2024).
- Mantener o aumentar la actividad física, junto con el agua y la fibra, ayuda a prevenir el estreñimiento; durante una retirada pautada, la guía pide aprovechar al máximo los tratamientos del dolor sin fármacos (Dowell 2022).
- Las fuentes leídas no dan normas de terapia manual en estos pacientes ni sobre el ejercicio en las horas siguientes a la toma.

Gabapentinoides

Gabapentina, pregabalina

- Mareo, somnolencia y marcha: son las reacciones más frecuentes y las que más llevaron a abandonar la pregabalina; la mayoría fueron leves o moderadas, dependientes de la dosis y aparecieron en las 2 primeras semanas (Cross 2024).
- Mayores y función renal: ambos fármacos se eliminan por vía renal y el aclaramiento baja en los mayores y con disfunción renal, con más riesgo de reacciones adversas (Yasaei 2024; Cross 2024).
- Caídas y fracturas: en mayores, la fractura de cadera fue un 30 % más probable en los 60 días siguientes a dispensarlos, y más en personas frágiles o con enfermedad renal crónica (Leung 2024). En pacientes ingresados, las caídas fueron más frecuentes con ellos (OR 1,88) (Moon 2026).
- Las fuentes leídas no dan normas de terapia manual en estos pacientes ni sobre el ejercicio en las horas siguientes a la toma.

Antidepresivos (ISRS, IRSN, tricíclicos)

Sertralina, escitalopram, duloxetina, venlafaxina, amitriptilina

- Mareo, ortostatismo y caídas: los tricíclicos se asociaron a mucha más hipotensión ortostática que el placebo (OR 6,30), y los ISRS no (Bhanu 2021). La amitriptilina da hipotensión ortostática, mareo y sedación (Thour 2026). La duloxetina puede dar hipotensión ortostática, caídas y síncope, sobre todo al empezar o al subir la dosis (Biswas 2026).
- Con venlafaxina, uno de cada cinco mayores sin hipotensión ortostática al empezar la tuvo durante el tratamiento, y quienes la tuvieron se cayeron más (Wathra 2020). En mayores de 60 años, la hipotensión al ponerse de pie fue más frecuente en los 28 primeros días tras empezar un antidepresivo (ISRS, IRR 4,22; duloxetina, venlafaxina o mirtazapina, 2,17; tricíclicos, 2,12), y con duloxetina, venlafaxina o mirtazapina no siguió elevada después (Bhanu 2025).
- Las fuentes leídas no dan normas de terapia manual ni de ejercicio con estos fármacos. El sangrado que estudian es el grave, digestivo o intracraneal, no los hematomas de las técnicas manuales.

Benzodiacepinas y relajantes musculares

Diazepam, lorazepam, alprazolam, ciclobenzaprina, metocarbamol, tizanidina, baclofeno, tiocolchicósido

- Caídas y fracturas: las benzodiacepinas aumentan las caídas (OR 1,39–1,57) y se asocian con fuerza a la fractura de cadera; los hipnóticos Z, como el zolpidem, también aumentan las fracturas (OR 1,63). El riesgo es mayor las primeras semanas tras empezar y con el uso prolongado, por sedación, hipotensión ortostática, mareo, debilidad muscular, ataxia y problemas visuales (Capiau 2023).
- Equilibrio: el efecto depende de la dosis y es máximo en las primeras horas tras la toma; es mayor con dosis altas, con poco tiempo entre la toma y el despertar o con alcohol u otros sedantes, y la inestabilidad es más marcada en mayores (Capiau 2023).
- Rendimiento: en adultos sanos y activos, las benzodiacepinas no cambiaron la fuerza ni la resistencia, y una dosis de lorazepam solo bajó la potencia máxima de un esfuerzo anaeróbico breve; son 10 estudios pequeños, con las pruebas hechas entre 3 y 16 h después de la toma y sin medir el equilibrio (Holgado 2022). En un análisis secundario de un ensayo con mayores con peor función física, el programa de actividad física protegió de la pérdida de movilidad a quienes no tomaban benzodiacepinas, pero no a quienes las tomaban; en el conjunto de participantes la diferencia no fue significativa (Levati 2026).
- Las fuentes leídas no dan normas de terapia manual ni de dosificación del ejercicio con estos fármacos.

Estatinas

Atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina

- Al empezar un programa de ejercicio, las molestias pueden deberse al propio ejercicio y no a la estatina, y llevar a dejarla por error; ese pequeño aumento de riesgo no es motivo para abandonar el ejercicio ni la estatina sin valoración médica (Mangone 2024). Desaconsejar el ejercicio por tomar estatina puede aumentar el riesgo cardiovascular: el ejercicio moderado no debe desaconsejarse, mientras que el esfuerzo intenso y no habitual puede subir la CK e interactuar con la estatina (Epelde 2026).
- Rabdomiólisis por esfuerzo: el ejercicio extenuante, sobre todo sin entrenamiento, levantar mucho peso o hacerlo con mucho calor, y la deshidratación pueden causarla, igual que la inmovilización prolongada (Rout 2025).
- Mayores: por encima de 65 años la concentración de atorvastatina es mayor y el riesgo de miopatía también (McIver y Siddique 2025). Las fuentes leídas no tratan la terapia manual.
- Caídas: en una cohorte de 12 156 mayores de 60 años tras un infarto, las estatinas se asociaron a más caídas con ingreso en los 2 primeros años (subHR 1,36), solo a partir de los 80 años (1,82); es un estudio observacional (Ble 2017).
- Entrenamiento: una revisión sistemática no encontró pruebas consistentes de que las estatinas frenen la mejora con el entrenamiento, aunque solo dos estudios lo midieron (Noyes 2017). En uno, con simvastatina, el consumo máximo de oxígeno subió un 10 % con el ejercicio solo y un 1,5 % con la estatina (Noyes 2017); en otro, en mayores, la mejora del consumo pico tras 12 semanas de caminar en cinta fue parecida con y sin estatina (Slade 2021).

No es una guía para cambiar la medicación: cualquier duda sobre dosis, suspensión o interacciones entre fármacos se consulta con el médico o el farmacéutico.

Generado desde los datos de la app (data/farmacos.js, data/farmacos-paciente.js) el 7/11/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Fármacos: qué vigilar en el plan (continuación)

Fluoroquinolonas

Ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino

- Cuándo: puede empezar en las primeras horas o los 2 primeros días de tratamiento y hasta varios meses después de terminarlo (EMA 2018).
- Ante dolor o hinchazón de un tendón, durante el tratamiento o después, la EMA pide reposo de la zona y contacto inmediato con el médico (EMA 2018); otras revisiones piden reducir la carga del tendón y no ejercitar la zona afectada (Rusu 2023), con analgesia y fisioterapia (Baggio y Ananda-Rajah 2021).
- Rehabilitación: puede responder mal a los programas excéntricos habituales, al menos al principio. Se propone en dos fases: primero soporte y protección, para que el tendón se recupere de la lesión química, y después carga progresiva (Lewis y Cook 2014). Una revisión cita proteger el tendón el primer mes (alza de talón, ortesis, muletas) y reducir la carga del Aquiles de 6 semanas a 6 meses (Rusu 2023).

Betabloqueantes

Bisoprolol, atenolol, metoprolol, propranolol

- La frecuencia cardíaca no sirve para dosificar el ejercicio: la bajan en todo el rango de intensidades, la frecuencia máxima ya no se puede estimar y las zonas de frecuencia dejan de corresponder al esfuerzo real; un cambio de dosis o de cumplimiento la vuelve a cambiar (Mitchell 2025). Con 100 mg de metoprolol, la frecuencia fue unos 40 latidos por minuto más baja al mismo esfuerzo percibido (Mitchell 2025).
- Usa el esfuerzo percibido (escala de Borg de 6 a 20): en un ensayo, su relación con el consumo de oxígeno se mantuvo con el fármaco (Mitchell 2025), y una guía europea recoge que sirve cuando la frecuencia cardíaca no se puede usar. Como referencia, 12–13 es intensidad moderada y 14–16 alta (Hansen 2022).
- Las fuentes no coinciden en cuánto fiarse del Borg: la guía europea lo quiere solo como complemento de un método objetivo, como la prueba de esfuerzo, y advierte que los betabloqueantes pueden dificultar su interpretación (Hansen 2022); el ensayo que lo apoya es de 13 jóvenes sanos con una sola dosis (Mitchell 2025). Si su cardiólogo le ha dado una intensidad a partir de una prueba de esfuerzo, esa manda.
- Por el mareo y la hipotensión (Ez Eddin 2025; Farzam y Jan 2023), cuida los cambios de postura y el final de la sesión. Las fuentes leídas no tratan la terapia manual.
- Calor: en un metaanálisis, los betabloqueantes no cambiaron la temperatura central ni el sudor en el ejercicio con calor; con los no selectivos, como el propranolol, subió algo más (0,11 °C). Casi todos los estudios eran de hombres jóvenes y sanos (Hospers 2024). Ante un golpe de calor clásico se revisa la medicación, en especial los betabloqueantes (Morris y Patel 2023).
- Caídas: en mayores de 55 años, los no selectivos, como el propranolol, se asociaron a más caídas (HR 1,22; IC 95 % 1,01–1,48) y los selectivos no (HR 0,92; 0,83–1,01). Ese estudio miró el uso mantenido, no el comienzo, cuando otros estudios vieron más caídas por hipotensión (Ham 2017).

Diuréticos y otros antihipertensivos

Hidroclorotiazida, furosemida, enalapril, losartán, amlodipino

- Caídas: en mayores con salud compleja, el riesgo de caer subió un 35–50 % en los 30 días siguientes a empezar un antihipertensivo, y otros estudios lo vieron también al añadir otro o al subir la dosis (Jödicke 2023). Los ensayos no hallaron más caídas, pero sí más hipotensión y síncope (Albasri 2021), y excluyen a los más frágiles (McEvoy 2024). En esas semanas, cuida los cambios de postura y el equilibrio.
- Hipotensión ortostática: una caída de 20 mmHg de la sistólica o de 10 de la diastólica al ponerse de pie, medida al minuto y a los 3 minutos tras 5 minutos sentado o tumbado (McEvoy 2024). Los diuréticos la provocan más; los IECA, los ARA II y los dihidropiridínicos, menos, y sobre todo en las 2 primeras semanas tras empezar o subir la dosis (McEvoy 2024). Empeora al levantarse, tras el ejercicio y con calor (Ringer 2025).
- Para prevenirla: levantarse por fases (tumbado, sentado, de pie), beber lo suficiente, y cruzar las piernas o tensar los músculos de piernas y caderas al ponerse de pie (Ringer 2025; McEvoy 2024). Si hay riesgo de caer, ejercicio supervisado, como la bicicleta reclinada o la natación (Ringer 2025).
- Calor: en mayores, los diuréticos de asa, los IECA y los ARA II se asociaron a más ingresos por golpe de calor o deshidratación, también sin ola de calor (Layton 2020).

Insulina y antidiabéticos

Insulina, metformina, sulfonilureas, gliflozinas (SGLT2), agonistas de GLP-1, gliptinas (DPP-4), pioglitazona

- Riesgo de hipoglucemia con el ejercicio: lo tiene quien usa insulina o sulfonilureas. Con metformina, gliptinas, GLP-1, gliflozinas o pioglitazona solos no hace falta tomar hidratos por el ejercicio; combinados con insulina o sulfonilureas, sí hay riesgo (Kanaley 2022; Colberg 2016). Con insulina o sulfonilureas, que traiga hidratos de absorción rápida y su medidor de glucosa, y glucagón si tiende a hipoglucemias graves (Kanaley 2022; Riddell 2017).
- Glucemia antes de empezar: el objetivo es 90–250 mg/dL (5,0–13,9 mmol/L) (Colberg 2016). Por debajo de 90 mg/dL, hidratos antes de empezar (Colberg 2016; Riddell 2017). Por encima de 250 mg/dL hay que mirar las cetonas: con cetonas moderadas o altas no se hace ejercicio; sin ellas, ejercicio ligero o moderado si se encuentra bien e hidratado, y el intenso cuando baje de 250 (Colberg 2016; Kanaley 2022). Una hipoglucemia grave en las 24 horas previas contraindica el ejercicio (Riddell 2017).
- Durante: en la diabetes tipo 1, la hipoglucemia aparece en la mayoría dentro de los 45 minutos de ejercicio aeróbico (Riddell 2017). Después: aparece sobre todo 6–15 horas más tarde, aunque el riesgo dura hasta 48 horas (Colberg 2016), y el ejercicio largo e intenso lo aumenta con insulina o sulfonilureas (Kanaley 2022).
- Lugar de inyección: la insulina se pone en una zona que no vaya a trabajar, porque el ejercicio acelera su absorción, y el calor ambiente también (Adolfsson 2022). Frotar o masajear con fuerza la zona acelera la absorción, igual que el calor de una sauna, una ducha o un baño caliente poco después de inyectarse (Bahendeka 2019); calentar la zona a 40 °C adelantó el efecto de la insulina rápida (Gradel 2018; Pitt 2020). Por eso, evita el masaje y el calor local sobre una zona recién inyectada. Las fuentes leídas no tratan otras técnicas de terapia manual.
- Gliflozinas: el ejercicio, solo si se encuentra bien, aunque la glucosa no esté muy alta, por la cetoacidosis con glucosa normal (Kanaley 2022); por la pérdida de volumen y el mareo (Tentolouris 2019), cuida la hidratación y los cambios de postura.
- Hipoglucemia en la sesión: para el ejercicio y que se mida la glucosa (Moser 2020; Costello 2023). Con 70 mg/dL (3,9 mmol/L) o menos, 15 g de hidratos de absorción rápida, mejor glucosa (tabletas, zumo, refresco), sin grasa ni proteína; volver a medir a los 15 minutos y repetir si sigue baja, la regla «15-15»; cuando se recupere, que coma algo, porque con insulina o sulfonilureas puede repetirse (ADA 2025; Costello 2023). Si bajó de 54 mg/dL, no se reanuda el ejercicio (Moser 2020).

Fármacos que tocan el hueso

Alendronato, risedronato, ibandronato, zoledronato, denosumab; inhibidores de la aromatasa (anastrozol, letrozol, exemestano)

- Pronto, con imagen del fémur: un dolor de muslo, ingle o cadera sin explicación con bifosfonato o denosumab. La guía británica pide imagen del fémur (radiografía del fémur entero, gammagrafía o resonancia) y, si hay fractura atípica, también del otro (Gregson 2025). Hasta entonces, sin impacto ni carga de esa pierna.
- Tras una infusión de zoledronato, los 3 primeros días pueden traer fiebre y dolor muscular (Alaranji y Reilly 2025): si la sesión cae en esos días, tenlo en cuenta al dosificar y al interpretar los síntomas.
- Inhibidores de la aromatasa: en un ensayo con 121 mujeres inactivas con dolor articular, fuerza supervisada 2 días por semana (6 ejercicios, 3 series de 8–12 repeticiones, subiendo el peso tras dos sesiones haciendo 12 repeticiones en cada serie) y 150 minutos semanales de aeróbico, del 50 % al 60–80 % de la frecuencia cardíaca máxima en el primer mes, durante 12 meses, bajaron el peor dolor 1,6 puntos (29 %), frente a una subida del 3 % con los cuidados habituales, sin efectos adversos (Irwin 2015). El beneficio más claro llegó a los 12 meses (Irwin 2015).

Antiparkinsonianos y agonistas dopaminérgicos

Levodopa (con carbidopa o benserazida); agonistas dopaminérgicos (pramipexol, ropinirol, rotigotina, apomorfina); inhibidores de la MAO-B (rasagilina, safinamida, selegilina); inhibidores de la COMT (entacapona, opicapona); amantadina; anticolinérgicos (trihexifenidilo, biperideno)

- En la sesión: cambios lentos de tumbado a de pie, con una pausa sentado; si se marea y no puede sentarse o tumbarse enseguida, que cruce las piernas y apriete piernas, glúteos y abdomen, o que se ponga de puntillas (Fanciulli 2026; Fanciulli 2025).
- Caídas: las que ocurren sin tropiezo ni resbalón pueden ser por hipotensión ortostática (Fanciulli 2026).
- Comidas y levodopa: una comida rica en proteína reduce su absorción, y una comida grasa la retrasa unas 2 horas (Gandhi y Saadabadi 2023).
- Si se duerme en la sesión o en situaciones monótonas, que lo sepa su médico; mientras dure, no debe conducir (Fanciulli 2025).

No es una guía para cambiar la medicación: cualquier duda sobre dosis, suspensión o interacciones entre fármacos se consulta con el médico o el farmacéutico.

Generado desde los datos de la app (data/farmacos.js, data/farmacos-paciente.js) el 7/11/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Tiempos de recuperación · Partes blandas

Referencia general, no un plazo para este paciente: cada barra dice qué mide (vuelta al deporte, protección, programa…), y con cirugía manda el protocolo del cirujano. La nota y las fuentes de cada barra, en la guía (QR).

Notas, fuentes e IA

v. 7279a518



TENDÓN

Tendinopatía	*Sin barra general: ver los subtipos*
Rotuliana	
Aquílea, porción media	
Aquílea, insercional	
Isquiotibiales, proximal	
Glútea	
Epicondilalgia lateral	
Epicondilalgia medial	
Tibial posterior (estadios I–II)	
Síndrome de la banda iliotibial (corredores)	
Rotura / reparación de tendón	
Aquiles, sin cirugía	
Aquiles, reparado	
Manguito rotador reparado, protección	
Manguito rotador reparado, rehabilitación	
Bíceps distal reparado, vuelta al trabajo	
Bíceps distal reparado, vuelta al deporte	

MÚSCULO

Dolor muscular tardío (DOMS)	
Isquiotibiales (clasificación BAMIC)	
Grado 0 (RM normal)	
Grado 1a/1b (pequeña)	
Grado 2a/2b (moderada, sin tendón)	
Grado 2c (moderada, dentro del tendón)	
Grado 3c (extensa, dentro del tendón)	
Gemelo y sóleo (por la lesión del tejido conectivo)	
Grado 0 (edema, sin rotura de fibras)	
Grado 1 (rotura de fibras, tejido conectivo intacto)	
Grado 2 (lesión del tendón o la aponeurosis, sin retracción)	
Grado 3 (con retracción)	
Recto femoral, rotura completa o avulsión proximal	
Sin cirugía	
Operado	
Aductores (lesión aguda, futbolistas)	
Discinesia escapular con dolor de hombro	
Aductores, dolor de ingle de larga evolución	

Sin barra general por grados I–III: el plazo depende del músculo, de la zona de la lesión y del deporte. Ver las filas de cada músculo.

LIGAMENTO

Esguince grado I	*Sin barra general: ver los subtipos*
Tobillo, ligamento lateral	
Rodilla, ligamento colateral medial	
Esguince grado II	*Sin barra general: ver los subtipos*
Tobillo, ligamento lateral	
Esguince grado III	*Sin barra general: ver los subtipos*
Tobillo, ligamento lateral	
Tobillo, reparación quirúrgica	
Rodilla, LCA sin cirugía	
Injerto (reconstrucción)	*Sin barra general: ver los subtipos*
Rodilla, LCA reconstruido	
Esguince de la sindesmosis (alto de tobillo)	
Sin cirugía	
Operada (tornillo o sutura dinámica)	
Ligamento colateral cubital del codo, sin cirugía	
Inestabilidad crónica de tobillo	

MENISCO

Rotura traumática, sin cirugía	
Lesión degenerativa, sin cirugía	
Meniscectomía parcial	
Sutura (reparación)	

NERVIO PERIFÉRICO

Neuropraxia (Sunderland I)	

Axonotmesis (Sunderland II–IV), sin barra: el plazo depende de la distancia que tiene que crecer el nervio. El axón cruza la lesión en 1–2 semanas y luego avanza unos 1 mm al día (unos 3 cm al mes; de 0,5 a 3 mm según la fuente, más rápido en segmentos proximales, en jóvenes y tras un aplastamiento). Días hasta la reinervación ≈ milímetros desde la lesión hasta el primer músculo. El músculo admite reinervación durante 1–2 años y la recuperación motora se estanca a los 18–24 meses. Sin signos de recuperación (Tinel que no avanza, fuerza que no mejora) a los 3 meses: derivar para valorar cirugía. Neurotmesis (Sunderland V): no se recupera sin cirugía.

Color = gravedad: Mínima · Leve · Moderada · Grave / reconstrucción

Relleno = qué mide: Vuelta al deporte o a la función · Protección (inmovilización o descarga) · Duración del programa de tratamiento · Biología de la reparación · Evolución natural (hasta que se resuelve)

Fases de reparación: Inflamatoria · Proliferativa · Remodelación · Remodelación (tendón) · Eje no lineal: cada columna ocupa lo mismo.

Generado desde los datos de la app (data/tejidos.js) el 31/10/2026. La otra hoja: Hueso, articulación y columna.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

Tiempos de recuperación · Hueso, articulación y columna

Referencia general, no un plazo para este paciente: cada barra dice qué mide (vuelta al deporte, protección, programa…), y con cirugía manda el protocolo del cirujano. La nota y las fuentes de cada barra, en la guía (QR).

Notas, fuentes e IA
v. de168e4c



Color = gravedad: Mínima · Leve · Moderada · Grave / reconstrucción

Relleno = qué mide: Vuelta al deporte o a la función · Protección (inmovilización o descarga) · Duración del programa de tratamiento · Biología de la reparación · Evolución natural (hasta que se resuelve)

Fases de reparación: Inflamatoria · Proliferativa · Remodelación · Remodelación (tendón) · Eje no lineal: cada columna ocupa lo mismo.

Generado desde los datos de la app (data/tejidos.js) el 31/10/2026. La otra hoja: Partes blandas.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

Cribado sistémico · Cervical

PhysiQ-Assessment · fase 2. Lo que se pregunta siempre en cervical. Las condiciones especiales, en la página siguiente. El porqué de cada pregunta, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. b1da49ad

URGENCIAS HOY · disfunción arterial · lesión tras traumatismo · cefalea con signos de alarma
· Disección arterial (<55 a): cefalea o dolor cervical súbito, DESCONOCIDO PARA EL PACIENTE, moderado o grave y a menudo progresivo. Alteración del equilibrio o la marcha, Horner, déficit de pares craneales. Puede imitar una cefalea cervicogénica.
· Insuficiencia vertebrobasilar (suele ser >65 a, posible en jóvenes) · 5 D y 3 N: mareo o inestabilidad, diplopía o pérdida de campo visual, disartria o disfasia, disfagia o ronquera, caídas súbitas sin pérdida de conciencia; nistagmo espontáneo, náuseas o vómitos, entumecimiento peribucal.
· Fractura, subluxación o luxación: traumatismo importante en persona mayor o mecanismo peligroso (flexión con compresión en deporte de colisión). Se sujeta la cabeza, espasmo defensivo, movilidad muy limitada, posibles signos neurológicos. Incluye la inestabilidad cervical alta traumática.
· Cefalea con signos de alarma: cambio súbito de calidad, intensidad o frecuencia; síntomas neurológicos nuevos; inicio súbito y grave; fiebre u otros síntomas sistémicos.

🔬 Cáncer / Oncológico

1. ¿Alguna vez ha tenido cáncer de algún tipo, o ha recibido quimioterapia, terapia hormonal o radioterapia?
2. ¿El dolor lo despierta por la noche desde un sueño profundo y le resulta imposible encontrar una posición que lo alivie?
3. ¿Ha notado pérdida de peso reciente, rápida y sin proponérselo?

❤️ Cardiovascular

1. ¿Tiene síntomas como sudores, náuseas, o dolor en el pecho/mandíbula al mismo tiempo que el dolor de cuello/espalda?
2. ¿El dolor de espalda o cuello empeora al subir escaleras o hacer esfuerzo físico general (no al mover el cuello)?
3. **¿Tiene ahora mismo dolor u opresión en el pecho, el cuello, la mandíbula, la espalda o el brazo que dura más de 20 minutos o no se le pasa al parar, o que le viene con sudor frío, náuseas, vómitos o falta de aire?** URGENCIA
4. **Si se ha desmayado alguna vez: ¿fue mientras hacía un esfuerzo, estando tumbado, justo después de notar de golpe el corazón muy rápido, o con dolor en el pecho o falta de aire nuevos? ¿O algún familiar suyo murió de forma súbita antes de los 40 años?** URGENCIA

🫁 Pulmonar

1. ¿El dolor de cuello o espalda empeora al toser, reír, estornudar o respirar profundo?
2. ¿Siente falta de aire en reposo o al acostarse?

🫘 Renal / Urológico

1. ¿Ha notado algún cambio en su control de esfínteres (vejiga o intestino)?
2. ¿Ha notado cambios en la orina (color, olor, cantidad) o dificultad para orinar?

🫃 Gastrointestinal

1. ¿El dolor de espalda empeora o mejora al comer, o cambia tras una evacuación intestinal?
2. ¿Ha notado heces negras/alquitranadas, sangre en las heces, o dolor nocturno entre medianoche y las 3 am que cede con antiácidos?

🧠 Arterial / Traumatismo / Cefalea de alarma

1. **¿Le empezó de golpe un dolor de cabeza o de cuello distinto a cualquiera que haya tenido antes, con desequilibrio o torpeza al caminar, un párpado caído o una pupila más pequeña, o dificultad para mover la cara, la lengua o los ojos?** URGENCIA
2. **¿Tiene mareo o inestabilidad junto con visión doble o pérdida de parte de la vista, dificultad para hablar o tragar, ronquera, caídas súbitas sin perder el conocimiento, náuseas o vómitos, o adormecimiento alrededor de la boca?** URGENCIA
3. **¿El dolor empezó tras un traumatismo importante (sobre todo si es mayor) o un golpe peligroso, como una flexión con compresión en un deporte de colisión, y necesita sujetarse la cabeza o apenas puede mover el cuello?** URGENCIA
4. **¿Su dolor de cabeza ha cambiado de golpe de forma, intensidad o frecuencia, empezó de forma súbita y muy fuerte, o viene con síntomas neurológicos nuevos, fiebre u otros síntomas generales?** URGENCIA

⚡ Médula / Estructural

1. ¿Tiene artritis reumatoide, síndrome de Down o síndrome de Klippel-Feil (cuello corto)?
2. ¿Nota contracciones que no controla y que le giran o inclinan la cabeza, o le dejan la cabeza en una postura anómala?
3. (Menores de 18 años) ¿Tiene tortícolis con el giro de la cabeza muy limitado, que apareció tras una amigdalitis o una operación de amígdalas o vegetaciones?
4. ¿Ha notado torpeza en las manos (para abotonarse, escribir o coger monedas), que le ha cambiado la letra, o que camina con menos equilibrio, con las piernas pesadas o agarrándose a la barandilla?

🔥 Inflamatoria / Infecciosa

1. ¿Tiene febrícula, sudores por la noche o se encuentra mal en general, con un dolor de cuello continuo que no se alivia con el reposo ni cambiando de postura?
2. ¿Tiene el cuello rígido mucho rato, sobre todo por la mañana, o le duelen o se le hinchan otras articulaciones?

⚗️ Endocrino / Metabólico

1. ¿Siente fatiga inusual o debilidad muscular, especialmente al subir escaleras o levantarse de una silla?
2. ¿Ha notado aumento anormal de sed, apetito o frecuencia urinaria (incluso despertándose por la noche)?
3. ¿Ha experimentado cambios recientes en su peso o tolerancia a la temperatura (mucho frío o calor cuando otros no)?
4. ¿Nota que sus heridas sanan muy lentamente o le aparecen moretones con excesiva facilidad?
5. (Si tiene diabetes) ¿Suele tener episodios de bajadas de azúcar, o siente ardor, entumecimiento o pérdida de sensibilidad en manos y pies?

🩸 Hematológico

1. ¿Sangra o se le forman moretones fácilmente después de un traumatismo menor, cirugía o procedimiento dental?
2. ¿Experimenta falta de aire, palpitaciones o dolor en el pecho con esfuerzos leves (subir escaleras) o en reposo?
3. ¿Padece infecciones recurrentes o fiebre baja frecuente (resfriados, gripe, infecciones respiratorias)?
4. **¿Está recibiendo tratamiento contra el cáncer (quimioterapia o radioterapia) y se encuentra mal o tiene fiebre?** URGENCIA
5. **(Si tiene hemofilia u otro trastorno hereditario de la coagulación) ¿Tiene un dolor nuevo en una articulación o un músculo, con hormigueo o tirantez, hinchazón, calor o dificultad para moverla?** URGENCIA
6. ¿Ha notado heces negras/alquitranadas, sangre en orina, o ha tosido o vomitado sangre?

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Condiciones especiales · Cervical

Solo se preguntan si el paciente tiene la condición (en la app, su tarjeta de la fase 1 marcada, o el mecanismo «Post-quirúrgico»). La escala de Beighton, la sospecha del subtipo vascular, la prueba de bipedestación, la regla de la tensión en el embarazo y la tensión tumbado y de pie del Parkinson se calculan en la guía (QR).

🏥 Posquirúrgico

Solo con mecanismo «Post-quirúrgico» en la fase 1

1. **¿Desde la operación, la herida está más roja, caliente, hinchada o dolorosa, supura o se ha abierto, o ha tenido fiebre, escalofríos o malestar general?** URGENCIA
2. **¿Desde la operación tiene una pantorrilla o una pierna hinchada, caliente o dolorosa? (Posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.)** URGENCIA
3. **¿Le falta el aire de repente, le duele el pecho al respirar, ha tosido sangre o se ha mareado o desmayado?** URGENCIA
4. **¿Desde la operación de columna nota en los brazos o las piernas un dolor, hormigueo, adormecimiento o pérdida de fuerza nuevos o que van a más, torpeza al caminar, o cambios al orinar o al hacer de vientre?** URGENCIA

🧬 Hipermovilidad

Solo con tarjeta «Hipermovilidad / Ehlers-Danlos» marcada

1. **¿Ha tenido de forma brusca un dolor intenso, que va a más, en el abdomen, el flanco, la espalda, el pecho o un brazo o una pierna?** URGENCIA
   con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida
2. **¿Ha notado de repente un zumbido en la sien, con el ojo rojo, dolorido o más saltón?** URGENCIA
   con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida
3. **¿Le ha faltado el aire de forma brusca, o le duele el pecho al respirar?** URGENCIA
   con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida
4. ¿Algún familiar de primer grado con SED vascular, o con una rotura o disección arterial antes de los 40 años?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
5. ¿Ha tenido una rotura arterial o una rotura de intestino sin causa conocida?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
6. ¿Ha tenido algún neumotórax espontáneo?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
7. ¿Le salen hematomas sin golpes, en sitios poco habituales (mejillas, espalda), o tiene la piel fina y translúcida, con las venas muy visibles?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
8. ¿Tuvo varices antes de los 30 años (y, si es mujer, sin haber estado embarazada)?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)

🫀 Disautonomía

Solo con tarjeta «Disautonomía / POTS» marcada

1. **¿Se ha desmayado alguna vez mientras hacía un esfuerzo (no justo al pararlo)?** URGENCIA
2. **¿Se ha desmayado estando tumbado, o justo después de notar de golpe el corazón muy rápido?** URGENCIA
3. **Si se ha desmayado: ¿tenía a la vez dolor en el pecho o falta de aire nuevos, o le han dicho que tiene un soplo, insuficiencia cardiaca u otra enfermedad del corazón?** URGENCIA
4. **Si se ha desmayado: ¿algún familiar murió de forma súbita antes de los 40 años, o tiene una enfermedad del corazón hereditaria?** URGENCIA
5. ¿Le dan episodios en que el corazón se le dispara de golpe y se le para también de golpe, aunque esté sentado o tumbado, sin llegar a desmayarse? DERIVACIÓN

🦋 Lupus

Solo con tarjeta «Lupus (LES)» marcada · solo «Diagnosticado»

1. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o se encuentra mal en general de una forma nueva? (Con corticoides o inmunosupresores puede haber una infección sin fiebre.)** URGENCIA
2. **¿Tiene una pantorrilla o una pierna (o un brazo) hinchada, caliente o dolorosa de forma nueva? (Posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.)** URGENCIA
3. **¿Le ha faltado el aire de repente o le duele el pecho al respirar? ¿O ha tenido de golpe debilidad o adormecimiento de un lado, dificultad para hablar o pérdida de visión, aunque se le haya pasado?** URGENCIA
4. **¿Tiene un dolor en el pecho punzante que empeora al respirar hondo y mejora inclinándose hacia delante?** URGENCIA
5. **¿Tiene en algún dedo de la mano o del pie una herida o úlcera en la yema, o un dedo que se queda blanco o morado y no recupera el color?** URGENCIA
6. **¿Ha tenido una convulsión o confusión nueva; debilidad u hormigueo en las dos piernas que va a más, con cambios al orinar; de golpe, el pie o la mano caídos; o pérdida de visión?** URGENCIA
7. ¿Tiene un dolor profundo y persistente en la ingle, la rodilla, el hombro o el tobillo, que empeora al cargar o al andar y no se explica por un golpe? DERIVACIÓN
8. ¿Le cuesta cada vez más levantarse de una silla, subir escaleras o levantar los brazos por encima de la cabeza? DERIVACIÓN
9. Desde la última vez que le vio su reumatólogo, ¿tiene articulaciones hinchadas nuevas, una erupción, llagas en la boca o más caída de pelo? DERIVACIÓN
10. ¿Se le hinchan las piernas o los tobillos de forma nueva, le han dicho que tiene la tensión alta desde hace poco, o en un análisis que tiene proteínas o sangre en la orina? DERIVACIÓN

💉 Trastorno mastocitario o anafilaxia

Solo con tarjeta «Trastorno mastocitario o anafilaxia» marcada

1. Desde su última revisión médica, ¿ha tenido episodios bruscos con ronchas, hinchazón, falta de aire, mareo o desmayo que su médico aún no conoce? DERIVACIÓN

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

🦴 Osteoporosis

Solo con tarjeta «Osteoporosis o fragilidad ósea» marcada

1. **¿Tiene un dolor de espalda nuevo con debilidad, hormigueo o torpeza en las piernas que va a más, o cambios al orinar o al hacer de vientre?** URGENCIA
2. ¿Le empezó de golpe un dolor de espalda, sobre todo en la zona dorsal, tras un esfuerzo pequeño (levantar algo agachado, toser, estornudar, resbalar), y no se le ha ido? DERIVACIÓN
3. ¿Ha perdido 4 cm o más de altura respecto a cuando era joven (o 2 cm desde la última vez que se la midieron), o se le ha curvado más la espalda? DERIVACIÓN *sin fractura vertebral conocida*
4. ¿Tiene un dolor de muslo, ingle o cadera sin explicación? DERIVACIÓN *con bifosfonato o denosumab*

🤰 Embarazo y posparto

Solo con tarjeta «Embarazo o posparto» marcada

1. **¿Tiene dolor de cabeza fuerte o que no se le pasa, ve borroso o destellos, dolor fuerte justo debajo de las costillas, vómitos, o se le han hinchado de golpe la cara, las manos o los pies?** URGENCIA *embarazo desde la semana 20 o posparto*
2. **¿Ha tenido un sangrado vaginal que no le han explicado?** URGENCIA *solo embarazo desde la semana 13*
3. **¿Nota que el bebé se mueve menos de lo habitual?** URGENCIA *solo embarazo desde la semana 24*
4. **¿Tiene contracciones regulares y dolorosas, o le sale líquido por la vagina?** URGENCIA *solo embarazo*
5. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o se encuentra muy mal?** URGENCIA *solo embarazo*
6. **¿Tiene un sangrado vaginal brusco o muy abundante, que va a más, o expulsa coágulos o restos? ¿O se le ha hinchado mucho el vientre?** URGENCIA *solo posparto*
7. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o dolor de vientre, pelvis o periné, o un flujo que huele mal?** URGENCIA *solo posparto hasta la semana 8 tras el parto*
8. **¿Tiene dolor e hinchazón nuevos en una pierna, sobre todo en una sola; o dolor de espalda o de nalga con toda la pierna hinchada; o le falta el aire de forma nueva, le duele el pecho o ha tosido sangre?** URGENCIA
9. **¿Tiene dolor en el pecho, palpitaciones, o le falta el aire en reposo o al tumbarse?** URGENCIA
10. **¿Se le ha abierto la herida del periné o la de la cesárea, o tiene más dolor, rojez o supuración en ella?** URGENCIA *solo posparto*
11. **¿Desde el parto se le escapa la orina o las heces de forma continua, sin poder controlarlo nada?** URGENCIA *solo posparto*
12. **(Si hace falta, al acompañante) ¿Ha notado cambios bruscos desde el parto: confusión, ideas extrañas, euforia o mucha agitación?** URGENCIA *solo posparto*
13. **¿Ha pensado en hacerse daño o en quitarse la vida?** URGENCIA
14. ¿Tiene un dolor de espalda intenso y que no se le pasa, dorsal o lumbar, en el embarazo o desde el parto, o ha perdido 3 cm o más de altura? DERIVACIÓN
15. ¿Desde el parto tiene un dolor intenso o que empezó de golpe en la sacroilíaca, la nalga, la zona lumbar o el pubis, le cuesta apoyar o cojea, o se le alivia tumbada? DERIVACIÓN *solo posparto hasta la semana 2 tras el parto*
16. ¿Tiene un pecho rojo e hinchado desde hace más de 24 horas, aunque se lo haya tratado? DERIVACIÓN *solo posparto*

🩸 Anticoagulado o antiagregado

Solo con tarjeta «Paciente anticoagulado o antiagregado» marcada

1. **¿Se ha dado un golpe en la cabeza en los últimos días, aunque pareciera leve?** URGENCIA *no con aspirina sola*
2. **Desde un golpe en la cabeza (de hace días o semanas), ¿tiene un dolor de cabeza fuerte o que va a más, vómitos repetidos, somnolencia, confusión o cambios de conducta, o debilidad, dificultad para hablar o cambios de visión nuevos?** URGENCIA
3. **¿Le ha empezado de golpe un dolor fuerte de cuello o de espalda con debilidad, hormigueo o adormecimiento en brazos o piernas, o cambios al orinar o al hacer de vientre? (Puede empezar por la debilidad, sin dolor fuerte.)** URGENCIA
4. **¿Le ha empezado un dolor fuerte en la ingle, la cadera, el costado o la zona lumbar baja, con el muslo débil o adormecido, o con mareo, palidez o sudor frío? (Con un golpe pequeño o sin golpe.)** URGENCIA *solo con anticoagulante*
5. **¿Le ha salido de golpe, tras toser, un esfuerzo o una inyección de heparina, un dolor fuerte en la pared de la barriga con un bulto, que empeora al moverse o al tensar el abdomen?** URGENCIA *solo con anticoagulante*
6. **¿Tiene un brazo, un antebrazo, una mano, un muslo o una pierna muy hinchados y tensos, con un dolor desproporcionado que va a más y que empeora al estirarle pasivamente los dedos de la mano o del pie? (Tras un golpe pequeño, un esfuerzo o sin causa.)** URGENCIA
7. ¿Tiene un hematoma grande o que va a más, un bulto nuevo en un músculo, o una articulación hinchada tras un golpe pequeño o sin golpe? DERIVACIÓN

🧠 Parkinson

Solo con tarjeta «Parkinson» marcada

1. **En los últimos días, ¿está mucho más rígido o inmóvil que de costumbre y además tiene fiebre, está confuso, suda mucho o le cuesta tragar?** URGENCIA *solo «Diagnosticado»*
2. ¿Ha dejado de tomar su medicación del Parkinson, o no puede tomarla o retenerla (vómitos, diarrea, no puede tragar, una cirugía)? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
3. ¿Han vuelto de golpe el temblor, la rigidez o la lentitud, o tiene movimientos involuntarios fuertes o cambios de conducta nuevos? DERIVACIÓN *con estimulador cerebral profundo*
4. ¿Tiene periodos off que no sabe prever, movimientos involuntarios fuertes o calambres dolorosos cuando está en off? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
5. ¿Ve cosas que no están, o tiene conductas nuevas que no puede controlar (tomar medicación de más, juego, compras, comida)? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
6. ¿Se marea, ve borroso, nota las piernas flojas o le duele el cuello y los hombros al estar de pie, y se le pasa al sentarse o tumbarse? DERIVACIÓN
7. ¿Tose o se atraganta al comer o beber, o ha tenido infecciones respiratorias seguidas? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
8. ¿Se queda dormido de repente durante el día, sin poder evitarlo? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
9. Temblor, rigidez, lentitud, problemas de equilibrio o de la marcha, sin diagnóstico DERIVACIÓN *solo «Sospecha»*

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

Árbol de decisión — Cervical

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Cervical. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b. El porqué de cada paso, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. ee88b18c

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

1 ¿Existen signos de compromiso medular (mielopatía)?

- **SÍ** — Alteración de marcha, hiperreflexia, signo de Hoffmann o Clonus positivos → **8 Mielopatía Espondilótica Cervical**
- **NO** — Sin signos de mielopatía → sin hipótesis

todas →

2 ¿Hubo un mecanismo de aceleración-desaceleración reciente (latigazo cervical)?

📝 G2, G3 · R1

- **SÍ** — ROM cervical significativamente reducido y síntomas de hiperalerta → **5 Trastornos Asociados a Latigazo Cervical (WAD)**
- **NO** — Sin mecanismo traumático → sin hipótesis

Todas → sigue en el paso 3 ↓

↓ Paso 3: viene del paso 2

Desvío desde el paso 3 si «SÍ»

3b ¿Rasgos neuropáticos, déficit de conducción o ninguno? Pueden coexistir; si el inicio fue traumático, el paso 2 ya añade el latigazo.

📝 R3, R5, R12

- **DOLOR RADICULAR** → 12 Dolor Radicular Cervical
- **RADICULOPATÍA** → 3 Radiculopatía Cervical
- **AMBOS** → 12 Dolor Radicular Cervical + 3 Radiculopatía Cervical
- **AURA MIGRAÑOSA** → sin hipótesis
- **FALLA LA MÉDULA** → 8 Mielopatía Espondilótica Cervical

3 ¿El dolor baja por el brazo y es peor que el del cuello?

📝 R2, R3, R4, R5

SÍ ↑

- **SÍ** — Test de Spurling positivo, ULNT1 positivo o alivio con abducción del hombro → → desvío 3b
- **NO** — Sin irradiación predominante al brazo → sin hipótesis

NO →

4 ¿El síntoma principal es cefalea unilateral o dolor en base del cuello/hombro?

📝 R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13

- **Cefalea unilateral** — Test de Flexión-Rotación Cervical <30° y síntomas C1-C2 → **4 Cefalea Cervicogénica**
- **Cefalea primaria** — Criterios de migraña o tensional (el cuello puede contribuir) → sin hipótesis
- **Dolor en hombro/escápula** — Restricción de movilidad de 1ª costilla → **10 Disfunción de 1ª Costilla (Articulación Costo-Vertebral Superior)**
- **Dolor local/inespecífico** — Sin cefalea ni irradiación dominante → sin hipótesis

Todas → sigue en el paso 4b, en la página siguiente →

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor cervical inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

↓ Paso 4b: viene del paso 4

4b ¿Hay mareo o inestabilidad como queja principal o acompañante? Descartar antes lo vascular (5 D y 3 N, disección).

📝 R14, R15, R16, R17, R20

MAREO CERVICOGÉNICO
Aturdimiento o inestabilidad ligados al cuello + error de reposición >4–5°
→ 13 Mareo Cervicogénico

VESTIBULAR
Vértigo rotatorio; tras golpe en cabeza o cuello, pensar también en conmoción
→ sin hipótesis

NO
Sin mareo
→ sin hipótesis

todas →

5 ¿Cuál es la función más alterada en este paciente?

Déficit de Movilidad
ROM activo reducido y PAIVMs C0-C3 hipomóviles
→ 1 Disfunción Articular Cervical

Déficit de Coordinación
CCFT alterado o test de reposicionamiento alterado
→ 2 Disfunción Neuromuscular Cervical

Déficit de Fuerza
Reducción de fuerza de flexión o extensión cervical
→ 6 Debilidad Muscular Cérvico-Escapular

Déficit de Resistencia
Fatiga muscular en actividades funcionales
→ 11 Fatiga Muscular Cérvico-Escapular

Déficit Postural
Lordosis reducida o cabeza adelantada evidente
→ 9 Disfunción Postural Cérvico-Torácica

Dolor crónico inespecífico sin patrón dominante claro
→ 7 Dolor Mecánico Cervical Inespecífico Crónico

Todas → sigue en el paso 6 ↓

↓ Paso 6: viene del paso 5

6 ¿Dónde está la disfunción? En todos: tarea provocadora, postura, control motor y región torácica.

📝 R1, R18, R19

CRANEOCERVICAL (C1–2)
Dolor en los primeros grados de rotación, restricción precoz, FRT <30° o 10° de asimetría
→ 14 Dolor Cervical Idiopático

FACETA CERVICAL
Extensión-rotación positiva + disfunción segmentaria palpable y dolorosa
→ 14 Dolor Cervical Idiopático

CERVICAL BAJA Y CERVICOTORÁCICA
Giro libre al inicio pero excursión final limitada
→ 14 Dolor Cervical Idiopático

NINGUNO
No es idiopático o no se localiza
→ sin hipótesis

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor cervical inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Confirmación de hipótesis · Cervical

PhysiQ-Assessment · fase 4b. Los tests de cada hipótesis, sus LR y si puntúan. El criterio de cada test, por qué se hace, sus fuentes, «Ampliar con IA» y una calculadora que puntúa cada hipótesis con los tests que marques, en la guía de consulta (QR).

Porqués, IA y calculadora
v. be369a47

1 Disfunción Articular Cervical

Test	LR+	LR−	Papel
PAIVM (Movilidad Intervertebral Pasiva Accesoria) C0-C3	—	—	hallazgo
ROM Cervical Activo con CROM	—	—	hallazgo

2 Disfunción Neuromuscular Cervical

Test	LR+	LR−	Papel
Test de Flexión Craneocervical (CCFT) con biofeedback de presión	—	—	hallazgo
Test de Reposicionamiento Cabeza-Neutro	—	—	hallazgo

3 Radiculopatía Cervical

Test	LR+	LR−	Papel
Test de Spurling (Compresión Foraminal)	—	—	hallazgo
Upper Limb Neurodynamic Test (ULNT) 1	**2.5**	**0.42**	**puntúa**
Shoulder Abduction Relief Test	—	—	hallazgo
Reflejos tendinosos (bíceps C6, tríceps C7)	—	—	hallazgo
Exploración neurológica: sensibilidad, fuerza y reflejos del miembro superior	—	—	hallazgo
Fuerza del grupo débil con dinamómetro de mano (② medida objetiva)	—	—	hallazgo
Combinación de 4 ULNT (ULNT1 y ULNT2a mediano, ULNT2b radial, ULNT3 cubital)	2.0	**0.06**	**puntúa**

4 Cefalea Cervicogénica

Test	LR+	LR−	Papel
Test de Flexión-Rotación Cervical (CFRT)	**5.0**	—	**puntúa**
PAIVM C0-C3 (segmento C1-C2 más sintomático)	—	—	hallazgo
Cluster: ROM cervical + PAIVM + CCFT	—	—	hallazgo
Examen manual cervical alto	—	—	hallazgo
Rasgos de cervicogénica frente a migraña y tensional (tabla orientativa)	—	—	hallazgo

5 Trastornos Asociados a Latigazo Cervical (WAD)

Test	LR+	LR−	Papel
ROM Cervical Activo (reducción significativa)	—	—	hallazgo
Factores de riesgo de evolución persistente (WAD agudo o subagudo)	—	—	pronóstico
Síntomas de hiperalerta / PTSD	—	—	pronóstico
Hielo sobre la nuca (hiperalgesia al frío)	8.4	—	pronóstico
Reposición articular (si hay mareo o inestabilidad)	—	—	hallazgo
Rotación cervical activa sentado (② medida objetiva)	—	—	hallazgo

6 Debilidad Muscular Cérvico-Escapular

Test	LR+	LR−	Papel
Fuerza de Flexión Cervical (dinamometría)	—	—	hallazgo
Fuerza de Extensión Cervical (dinamometría)	—	—	hallazgo

7 Dolor Mecánico Cervical Inespecífico Crónico

Test	LR+	LR−	Papel
ROM Cervical Activo (reducción en todas las direcciones)	—	—	hallazgo
Test de reposicionamiento cabeza-neutro	—	—	hallazgo

8 Mielopatía Espondilótica Cervical

Test	LR+	LR−	Papel
Signo de Hoffmann	—	—	hallazgo
Clonus de tobillo/muñeca	—	—	hallazgo
Evaluación de marcha (alteración)	—	—	hallazgo
Hiperreflexia (ROT aumentados)	—	—	hallazgo

9 Disfunción Postural Cérvico-Torácica

Test	LR+	LR−	Papel
Evaluación postural de cabeza adelantada (Forward Head Posture)	—	—	hallazgo
Evaluación de cifosis torácica	—	—	hallazgo

10 Disfunción de 1ª Costilla (Articulación Costo-Vertebral Superior)

Test	LR+	LR−	Papel
Palpación de 1ª costilla (sensibilidad y restricción)	—	—	hallazgo
Restricción de rotación cervical ipsilateral	—	—	hallazgo

11 Fatiga Muscular Cérvico-Escapular

Test	LR+	LR−	Papel
Test de resistencia de flexores cervicales profundos	—	—	hallazgo
Evaluación de fatiga en actividades funcionales prolongadas	—	—	hallazgo

12 Dolor Radicular Cervical

Test	LR+	LR−	Papel
ULNT1 (sesgo mediano) con diferenciación estructural	—	—	hallazgo
Movilidad cervical que dispara el dolor de brazo	—	—	hallazgo
Grados de extensión de codo en el ULNT1 (② medida objetiva)	—	—	hallazgo
Rasgos neuropáticos (quemazón o descargas)	—	—	hallazgo

13 Mareo Cervicogénico

Test	LR+	LR−	Papel
Descartar lo vascular (5 D y 3 N, disección)	—	—	hallazgo
Sentido de posición articular (error de reposición)	—	—	hallazgo
Movimiento o postura que desencadena el mareo (① gesto testigo)	—	—	hallazgo

14 Dolor Cervical Idiopático

Test	LR+	LR−	Papel
Tarea provocadora (① gesto testigo)	—	—	hallazgo
Movilidad activa en los tres planos y las tres regiones	—	—	hallazgo
Test de flexión-rotación (FRT) si es craneocervical	—	—	hallazgo
Extensión-rotación	—	—	hallazgo
Examen manual segmentario	—	—	hallazgo

LR en **verde**: multiplica la puntuación (LR+ ≥ 2 o LR− ≤ 0,5); en gris: no informativa, cuenta como hallazgo. «≈» = calculada de S y E. **puntúa**: puede mover la puntuación · hallazgo: sin LR aplicable · en clúster: solo cuenta con su clúster 🧩 · pronóstico: no entra en la puntuación. Criterio completo de cada test, fuentes y calculadora de la puntuación, en la guía (QR).

PhysiQ-Assessment · fase 4b · Cervical. Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

Cribado sistémico · Hombro

PhysiQ-Assessment · fase 2. Lo que se pregunta siempre en hombro. Las condiciones especiales, en la página siguiente. El porqué de cada pregunta, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. 9746d799

🔬 Cáncer / Oncológico

1. ¿Tiene antecedentes de cáncer de cualquier tipo, o ha recibido quimioterapia, radioterapia o terapia hormonal?
2. ¿El dolor nocturno lo despierta desde un sueño profundo y le es imposible encontrar una posición que lo alivie para volver a dormir?
3. ¿Ha notado pérdida de peso reciente, rápida y sin proponérselo?

❤️ Cardiovascular

1. ¿El dolor de hombro aumenta con el esfuerzo físico general (subir escaleras, caminar) aunque no mueva los brazos?
2. ¿El dolor se acompaña de sudores repentinos, náuseas o sensación opresiva en mandíbula/pecho?
3. ¿El dolor cambia o empeora al acostarse, o siente falta de aire en reposo?
4. **¿Tiene ahora mismo dolor u opresión en el pecho, el hombro, el brazo, el cuello, la mandíbula o la espalda que dura más de 20 minutos o no se le pasa al parar, o que le viene con sudor frío, náuseas, vómitos o falta de aire?** URGENCIA
5. **Si se ha desmayado alguna vez: ¿fue mientras hacía un esfuerzo, estando tumbado, justo después de notar de golpe el corazón muy rápido, o con dolor en el pecho o falta de aire nuevos? ¿O algún familiar suyo murió de forma súbita antes de los 40 años?** URGENCIA

🫁 Pulmonar

1. ¿El dolor de hombro o espalda empeora al toser, reír, estornudar o tomar una respiración profunda?
2. ¿Siente falta de aire en reposo, al acostarse, o con mínimo esfuerzo?
3. ¿Ha notado sangre o mucosidad de color inusual (verde/oxidado) al toser, o tiene tos persistente de reciente aparición?

🫘 Renal / Urológico

1. ¿Ha notado cambios en la orina (color rojo, marrón, turbio, olor fuerte) o tiene fiebre/escalofríos junto con el dolor?
2. ¿El dolor de hombro es constante y no cambia al mover el brazo ni al cambiar de postura?

🌸 Ginecológico

1. **¿El dolor de hombro apareció de forma súbita y se acompaña de dolor pélvico, sangrado vaginal inusual o mareos intensos?** URGENCIA
2. ¿El dolor de hombro tiene alguna relación con su ciclo menstrual o ha tenido alguna infección pélvica reciente?

🫃 GI / Hepático

1. ¿El dolor de hombro aumenta o aparece 1-2 horas después de comer, especialmente comidas grasas?
2. ¿Ha notado cambios en el color de la orina (más oscura, como té o cola) o en las heces (muy claras, como arcilla)?
3. Si toma antiinflamatorios (AINEs), ¿el dolor de hombro aumenta en las horas siguientes en vez de mejorar?
4. **¿Ha empezado el dolor de hombro izquierdo después de un golpe o una caída sobre el costado o el abdomen (también un golpe leve, como el del volante en un accidente), y es constante o se acompaña de mareo o sensación de desmayo?** URGENCIA

🦴 Traumático (Fractura o Luxación)

1. **¿Tras una caída sobre el hombro o el codo, perdió de golpe movilidad del brazo o nota el hombro deformado? (Tener en cuenta la osteoporosis.)** URGENCIA

🌡️ Infección / Sistémico

1. ¿Ha tenido fiebre o se ha sentido enfermo últimamente, o ha notado cambios en la piel (aspecto, erupciones, sudoración), hematomas sin motivo o dolor en otras partes del cuerpo?

🧠 Neurológico

1. ¿Ha perdido fuerza o sensibilidad de forma importante en el brazo o la mano, o nota algún músculo del hombro o del brazo más delgado que el del otro lado?

⚗️ Endocrino / Metabólico

1. ¿Siente fatiga inusual o debilidad muscular, especialmente al subir escaleras o levantarse de una silla?
2. ¿Ha notado aumento anormal de sed, apetito o frecuencia urinaria (incluso despertándose por la noche)?
3. ¿Ha experimentado cambios recientes en su peso o tolerancia a la temperatura (mucho frío o calor cuando otros no)?
4. ¿Nota que sus heridas sanan muy lentamente o le aparecen moretones con excesiva facilidad?
5. (Si tiene diabetes) ¿Suele tener episodios de bajadas de azúcar, o siente ardor, entumecimiento o pérdida de sensibilidad en manos y pies?

🩸 Hematológico

1. ¿Sangra o se le forman moretones fácilmente después de un traumatismo menor, cirugía o procedimiento dental?
2. ¿Experimenta falta de aire, palpitaciones o dolor en el pecho con esfuerzos leves (subir escaleras) o en reposo?
3. ¿Padece infecciones recurrentes o fiebre baja frecuente (resfriados, gripe, infecciones respiratorias)?
4. **¿Está recibiendo tratamiento contra el cáncer (quimioterapia o radioterapia) y se encuentra mal o tiene fiebre?** URGENCIA
5. **(Si tiene hemofilia u otro trastorno hereditario de la coagulación) ¿Tiene un dolor nuevo en una articulación o un músculo, con hormigueo o tirantez, hinchazón, calor o dificultad para moverla?** URGENCIA
6. ¿Ha notado heces negras/alquitranadas, sangre en orina, o ha tosido o vomitado sangre?

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Condiciones especiales · Hombro

Solo se preguntan si el paciente tiene la condición (en la app, su tarjeta de la fase 1 marcada, o el mecanismo «Post-quirúrgico»). La escala de Beighton, la sospecha del subtipo vascular, la prueba de bipedestación, la regla de la tensión en el embarazo y la tensión tumbado y de pie del Parkinson se calculan en la guía (QR).

🏥 Posquirúrgico

Solo con mecanismo «Post-quirúrgico» en la fase 1

1. **¿Desde la operación, la herida está más roja, caliente, hinchada o dolorosa, supura o se ha abierto, o ha tenido fiebre, escalofríos o malestar general?** URGENCIA
2. **¿Desde la operación tiene una pantorrilla, una pierna o el brazo operado hinchados, calientes o dolorosos? (En la pierna, posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.)** URGENCIA
3. **¿Le falta el aire de repente, le duele el pecho al respirar, ha tosido sangre o se ha mareado o desmayado?** URGENCIA
4. ¿Tiene un dolor continuo y desproporcionado para la operación, con cambios de color, temperatura, sudoración o hinchazón en la zona, o le duele incluso el roce de la ropa?
5. **¿Desde la operación nota un dolor quemante, hormigueo, adormecimiento o pérdida de fuerza nuevos en la zona de un nervio (por ejemplo, en la mano o el pie del lado operado)?** URGENCIA

🧬 Hipermovilidad

Solo con tarjeta «Hipermovilidad / Ehlers-Danlos» marcada

1. **¿Ha tenido de forma brusca un dolor intenso, que va a más, en el abdomen, el flanco, la espalda, el pecho o un brazo o una pierna?** URGENCIA
   con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida
2. **¿Ha notado de repente un zumbido en la sien, con el ojo rojo, dolorido o más saltón?** URGENCIA
   con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida
3. **¿Le ha faltado el aire de forma brusca, o le duele el pecho al respirar?** URGENCIA
   con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida
4. ¿Algún familiar de primer grado con SED vascular, o con una rotura o disección arterial antes de los 40 años?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
5. ¿Ha tenido una rotura arterial o una rotura de intestino sin causa conocida?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
6. ¿Ha tenido algún neumotórax espontáneo?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
7. ¿Le salen hematomas sin golpes, en sitios poco habituales (mejillas, espalda), o tiene la piel fina y translúcida, con las venas muy visibles?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
8. ¿Tuvo varices antes de los 30 años (y, si es mujer, sin haber estado embarazada)?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)

🫀 Disautonomía

Solo con tarjeta «Disautonomía / POTS» marcada

1. **¿Se ha desmayado alguna vez mientras hacía un esfuerzo (no justo al pararlo)?** URGENCIA
2. **¿Se ha desmayado estando tumbado, o justo después de notar de golpe el corazón muy rápido?** URGENCIA
3. **Si se ha desmayado: ¿tenía a la vez dolor en el pecho o falta de aire nuevos, o le han dicho que tiene un soplo, insuficiencia cardiaca u otra enfermedad del corazón?** URGENCIA
4. **Si se ha desmayado: ¿algún familiar murió de forma súbita antes de los 40 años, o tiene una enfermedad del corazón hereditaria?** URGENCIA
5. ¿Le dan episodios en que el corazón se le dispara de golpe y se le para también de golpe, aunque esté sentado o tumbado, sin llegar a desmayarse? DERIVACIÓN

🦋 Lupus

Solo con tarjeta «Lupus (LES)» marcada · solo «Diagnosticado»

1. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o se encuentra mal en general de una forma nueva? (Con corticoides o inmunosupresores puede haber una infección sin fiebre.)** URGENCIA
2. **¿Tiene una pantorrilla o una pierna (o un brazo) hinchada, caliente o dolorosa de forma nueva? (Posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.)** URGENCIA
3. **¿Le ha faltado el aire de repente o le duele el pecho al respirar? ¿O ha tenido de golpe debilidad o adormecimiento de un lado, dificultad para hablar o pérdida de visión, aunque se le haya pasado?** URGENCIA
4. **¿Tiene un dolor en el pecho punzante que empeora al respirar hondo y mejora inclinándose hacia delante?** URGENCIA
5. **¿Tiene en algún dedo de la mano o del pie una herida o úlcera en la yema, o un dedo que se queda blanco o morado y no recupera el color?** URGENCIA
6. **¿Ha tenido una convulsión o confusión nueva; debilidad u hormigueo en las dos piernas que va a más, con cambios al orinar; de golpe, el pie o la mano caídos; o pérdida de visión?** URGENCIA
7. ¿Tiene un dolor profundo y persistente en la ingle, la rodilla, el hombro o el tobillo, que empeora al cargar o al andar y no se explica por un golpe? DERIVACIÓN
8. ¿Le cuesta cada vez más levantarse de una silla, subir escaleras o levantar los brazos por encima de la cabeza? DERIVACIÓN
9. Desde la última vez que le vio su reumatólogo, ¿tiene articulaciones hinchadas nuevas, una erupción, llagas en la boca o más caída de pelo? DERIVACIÓN
10. ¿Se le hinchan las piernas o los tobillos de forma nueva, le han dicho que tiene la tensión alta desde hace poco, o en un análisis que tiene proteínas o sangre en la orina? DERIVACIÓN

💉 Trastorno mastocitario o anafilaxia

Solo con tarjeta «Trastorno mastocitario o anafilaxia» marcada

1. Desde su última revisión médica, ¿ha tenido episodios bruscos con ronchas, hinchazón, falta de aire, mareo o desmayo que su médico aún no conoce? DERIVACIÓN

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

🦴 Osteoporosis

Solo con tarjeta «Osteoporosis o fragilidad ósea» marcada

1. **¿Tiene un dolor de espalda nuevo con debilidad, hormigueo o torpeza en las piernas que va a más, o cambios al orinar o al hacer de vientre?** URGENCIA
2. ¿Le empezó de golpe un dolor de espalda, sobre todo en la zona dorsal, tras un esfuerzo pequeño (levantar algo agachado, toser, estornudar, resbalar), y no se le ha ido? DERIVACIÓN
3. ¿Ha perdido 4 cm o más de altura respecto a cuando era joven (o 2 cm desde la última vez que se la midieron), o se le ha curvado más la espalda? DERIVACIÓN *sin fractura vertebral conocida*
4. ¿Tiene un dolor de muslo, ingle o cadera sin explicación? DERIVACIÓN *con bifosfonato o denosumab*

🤰 Embarazo y posparto

Solo con tarjeta «Embarazo o posparto» marcada

1. **¿Tiene dolor de cabeza fuerte o que no se le pasa, ve borroso o destellos, dolor fuerte justo debajo de las costillas, vómitos, o se le han hinchado de golpe la cara, las manos o los pies?** URGENCIA *embarazo desde la semana 20 o posparto*
2. **¿Ha tenido un sangrado vaginal que no le han explicado?** URGENCIA *solo embarazo desde la semana 13*
3. **¿Nota que el bebé se mueve menos de lo habitual?** URGENCIA *solo embarazo desde la semana 24*
4. **¿Tiene contracciones regulares y dolorosas, o le sale líquido por la vagina?** URGENCIA *solo embarazo*
5. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o se encuentra muy mal?** URGENCIA *solo embarazo*
6. **¿Tiene un sangrado vaginal brusco o muy abundante, que va a más, o expulsa coágulos o restos? ¿O se le ha hinchado mucho el vientre?** URGENCIA *solo posparto*
7. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o dolor de vientre, pelvis o periné, o un flujo que huele mal?** URGENCIA *solo posparto hasta la semana 8 tras el parto*
8. **¿Tiene dolor e hinchazón nuevos en una pierna, sobre todo en una sola; o dolor de espalda o de nalga con toda la pierna hinchada; o le falta el aire de forma nueva, le duele el pecho o ha tosido sangre?** URGENCIA
9. **¿Tiene dolor en el pecho, palpitaciones, o le falta el aire en reposo o al tumbarse?** URGENCIA
10. **¿Se le ha abierto la herida del periné o la de la cesárea, o tiene más dolor, rojez o supuración en ella?** URGENCIA *solo posparto*
11. **¿Desde el parto se le escapa la orina o las heces de forma continua, sin poder controlarlo nada?** URGENCIA *solo posparto*
12. **(Si hace falta, al acompañante) ¿Ha notado cambios bruscos desde el parto: confusión, ideas extrañas, euforia o mucha agitación?** URGENCIA *solo posparto*
13. **¿Ha pensado en hacerse daño o en quitarse la vida?** URGENCIA
14. ¿Tiene un dolor de espalda intenso y que no se le pasa, dorsal o lumbar, en el embarazo o desde el parto, o ha perdido 3 cm o más de altura? DERIVACIÓN
15. ¿Desde el parto tiene un dolor intenso o que empezó de golpe en la sacroilíaca, la nalga, la zona lumbar o el pubis, le cuesta apoyar o cojea, o se le alivia tumbada? DERIVACIÓN *solo posparto hasta la semana 2 tras el parto*
16. ¿Tiene un pecho rojo e hinchado desde hace más de 24 horas, aunque se lo haya tratado? DERIVACIÓN *solo posparto*

🩸 Anticoagulado o antiagregado

Solo con tarjeta «Paciente anticoagulado o antiagregado» marcada

1. **¿Se ha dado un golpe en la cabeza en los últimos días, aunque pareciera leve?** URGENCIA *no con aspirina sola*
2. **Desde un golpe en la cabeza (de hace días o semanas), ¿tiene un dolor de cabeza fuerte o que va a más, vómitos repetidos, somnolencia, confusión o cambios de conducta, o debilidad, dificultad para hablar o cambios de visión nuevos?** URGENCIA
3. **¿Le ha empezado de golpe un dolor fuerte de cuello o de espalda con debilidad, hormigueo o adormecimiento en brazos o piernas, o cambios al orinar o al hacer de vientre? (Puede empezar por la debilidad, sin dolor fuerte.)** URGENCIA
4. **¿Le ha empezado un dolor fuerte en la ingle, la cadera, el costado o la zona lumbar baja, con el muslo débil o adormecido, o con mareo, palidez o sudor frío? (Con un golpe pequeño o sin golpe.)** URGENCIA *solo con anticoagulante*
5. **¿Le ha salido de golpe, tras toser, un esfuerzo o una inyección de heparina, un dolor fuerte en la pared de la barriga con un bulto, que empeora al moverse o al tensar el abdomen?** URGENCIA *solo con anticoagulante*
6. **¿Tiene un brazo, un antebrazo, una mano, un muslo o una pierna muy hinchados y tensos, con un dolor desproporcionado que va a más y que empeora al estirarle pasivamente los dedos de la mano o del pie? (Tras un golpe pequeño, un esfuerzo o sin causa.)** URGENCIA
7. ¿Tiene un hematoma grande o que va a más, un bulto nuevo en un músculo, o una articulación hinchada tras un golpe pequeño o sin golpe? DERIVACIÓN

🧠 Parkinson

Solo con tarjeta «Parkinson» marcada

1. **En los últimos días, ¿está mucho más rígido o inmóvil que de costumbre y además tiene fiebre, está confuso, suda mucho o le cuesta tragar?** URGENCIA *solo «Diagnosticado»*
2. ¿Ha dejado de tomar su medicación del Parkinson, o no puede tomarla o retenerla (vómitos, diarrea, no puede tragar, una cirugía)? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
3. ¿Han vuelto de golpe el temblor, la rigidez o la lentitud, o tiene movimientos involuntarios fuertes o cambios de conducta nuevos? DERIVACIÓN *con estimulador cerebral profundo*
4. ¿Tiene periodos off que no sabe prever, movimientos involuntarios fuertes o calambres dolorosos cuando está en off? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
5. ¿Ve cosas que no están, o tiene conductas nuevas que no puede controlar (tomar medicación de más, juego, compras, comida)? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
6. ¿Se marea, ve borroso, nota las piernas flojas o le duele el cuello y los hombros al estar de pie, y se le pasa al sentarse o tumbarse? DERIVACIÓN
7. ¿Tose o se atraganta al comer o beber, o ha tenido infecciones respiratorias seguidas? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
8. ¿Se queda dormido de repente durante el día, sin poder evitarlo? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
9. Temblor, rigidez, lentitud, problemas de equilibrio o de la marcha, sin diagnóstico DERIVACIÓN *solo «Sospecha»*

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

Árbol de decisión — Hombro

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Hombro. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b. El porqué de cada paso, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. 5ab4de71

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

Desvío desde el paso 2 si «SÍ»

2b La movilidad pasiva GH (sobre todo la RE) está limitada igual que la activa. ¿Hubo traumatismo previo? 📝 G2 · R3

- SÍ → **11** Luxación Bloqueada o Fractura (→ Rx)
- NO → **10** Artrosis Glenohumeral
- NO → **1** Capsulitis Adhesiva

SÍ

1 ¿El dolor se reproduce con movimientos cervicales, compresión axial o palpación de la primera costilla? 📝 R3, R4

todas

2 ¿Existe una restricción GLOBAL de la movilidad pasiva, especialmente en rotación externa? 📝 R1, R2, R9

NO

3 ¿El dolor está localizado en la parte superior (AC) o hubo un evento traumático con sensación de inestabilidad? 📝 R1, R3, R5, R6, R7, R8, R9, R13

SÍ Reproducción con movimientos cervicales (test de Spurling o similar)	→	**6** Disfunción Cervical con Dolor Referido a Hombro
SÍ Restricción de movilidad en 1ª costilla y dolor en zona de transición	→	**9** Disfunción de Primera Costilla (Zona Cervicotorácica)
NO No se reproduce con cervical ni 1ª costilla	→	sin hipótesis

SÍ Restricción global de la movilidad pasiva, con pérdida marcada de rotación externa	→	→ desvío 2b
NO Movilidad pasiva mayormente preservada	→	sin hipótesis

Dolor en articulación acromioclavicular (parte superior)	→	**7** Artropatía Acromioclavicular
Evento traumático / "Pop" con sensación de inestabilidad anterior	→	**4** Inestabilidad Glenohumeral (Anterior o Posterior)
Evento traumático / dolor profundo, síntomas de labrum (chasquidos)	→	**5** Lesión Labral Superior (SLAP)
Episodio concreto o aprensión (inestabilidad anterior o posterior, también sin «pop» traumático)	→	**4** Inestabilidad Glenohumeral (Anterior o Posterior)
Ninguno de los anteriores	→	sin hipótesis

Todas → sigue en el paso 4 ↓

↓ Paso 4: viene del paso 3

4 ¿Hay dolor durante la elevación y/o déficits de fuerza? 📝 R1, R3, R10, R12

todas

5 ¿Se observa asimetría o "winging" escapular durante el movimiento activo?

Dolor al elevar el brazo o con los test resistidos, sin debilidad marcada ni signos de déficit	→	**2** Síndrome de Pinzamiento Subacromial (Impingement)
Debilidad evidente caída del brazo (drop arm) o signos de déficit (lag signs)	→	**3** Rotura del Manguito Rotador
Sin dolor claro ni debilidad en elevación	→	sin hipótesis

SÍ Asimetría visual en la elevación o test de asistencia escapular positivo	→	**8** Discinesia Escapular
NO Sin alteración escapular evidente	→	sin hipótesis

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor de hombro inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 3/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

Confirmación de hipótesis · Hombro

PhysiQ-Assessment · fase 4b. Los tests de cada hipótesis, sus LR y si puntúan. El criterio de cada test, por qué se hace, sus fuentes, «Ampliar con IA» y una calculadora que puntúa cada hipótesis con los tests que marques, en la guía de consulta (QR).

Porqués, IA y calculadora
v. 8ba9eaa3

1 Capsulitis Adhesiva

Test	LR+	LR−	Papel
Abducción pasiva glenohumeral <80°	—	—	hallazgo
Test de Rotación Externa (brazo neutro al lado, codo 90°)	—	—	hallazgo
Restricción equivalente activa y pasiva (criterio de Bunker)	—	—	hallazgo
Gesto testigo ((1)) y medida objetiva ((2))	—	—	hallazgo
Test del dolor en la coracoides	—	—	hallazgo
Identificadores clínicos de fase precoz (Walmsley)	—	—	hallazgo

2 Síndrome de Pinzamiento Subacromial (Impingement)

Test	LR+	LR−	Papel
Arco doloroso	**2.3**	0.62	**puntúa**
Test de Hawkins-Kennedy	1.8	**0.35**	**puntúa**
Test de Neer	1.8	**0.47**	**puntúa**
Test de Resistencia a Rotación Externa	**2.6**	**0.49**	**puntúa**
Regla clínica de SAPS	—	—	hallazgo
Gesto testigo ((1)) y medida objetiva ((2))	—	—	hallazgo

3 Rotura del Manguito Rotador

Test	LR+	LR−	Papel
Test de Lata Vacía (Empty Can)	1.3	0.64	hallazgo
Test de Lata Llena (Full Can)	—	—	hallazgo
External Rotation Lag Sign	**7.2**	0.57	**puntúa**
Internal Rotation Lag Sign	**5.6**	—	**puntúa**
Drop Arm Test	—	—	hallazgo
Inspección	—	—	hallazgo
Cluster A, confirmar: arco doloroso + drop arm + debilidad en RE, los tres positivos	**16**	—	**puntúa**
Cluster A, descartar: arco doloroso, drop arm y debilidad en RE, los tres negativos (si se cumple, marcar «Negativo»)	—	**0.16**	**puntúa**
Cluster B: debilidad en RE + edad ≥65 (puntuación de Litaker ≥4)	**5.0**	—	**puntúa**
Gesto testigo ((1)) y medida objetiva ((2))	—	—	hallazgo
Signo de Hornblower	—	—	hallazgo

4 Inestabilidad Glenohumeral (Anterior o Posterior)

Test	LR+	LR−	Papel
Test de Aprehensión	**17**	**0.39**	**puntúa**
Test de Recolocación (Jobe)	—	—	hallazgo
Test de Liberación/Release/Surprise	—	**0.25**	**puntúa**
Anterior: aprensión, recolocación y sorpresa en conjunto	—	—	hallazgo
Posterior: Jerk, Kim y signo de pinzamiento posterior agrupados	—	—	hallazgo
Gesto testigo ((1)) y medida objetiva ((2))	—	—	hallazgo
Inestabilidad multidireccional: surco + tests en una dirección	—	—	hallazgo

5 Lesión Labral Superior (SLAP)

Test	LR+	LR−	Papel
Test de O'Brien (Active Compression)	—	—	hallazgo
Biceps Load Test II	—	—	hallazgo
Test de Resistencia a Rotación Interna	—	—	hallazgo
Gesto testigo ((1)) y medida objetiva ((2))	—	—	hallazgo

6 Disfunción Cervical con Dolor Referido a Hombro

Test	LR+	LR−	Papel
Test de Spurling (Compresión Foraminal)	—	—	hallazgo
Movilidad Glenohumeral Pasiva (PROM)	—	—	hallazgo

7 Artropatía Acromioclavicular

Test	LR+	LR−	Papel
Test de Aducción Cruzada (Cross-body Adduction)	—	—	hallazgo
Palpación directa de la articulación AC	—	—	hallazgo
Paxinos + gammagrafía ósea combinados	—	—	hallazgo
Movilidad pasiva sin restricción; posible escalón	—	—	hallazgo
Compresión activa (O'Brien) para la AC	—	—	hallazgo
Gesto testigo ((1)) y medida objetiva ((2))	—	—	hallazgo
Test de Paxinos	—	—	hallazgo

8 Discinesia Escapular

Test	LR+	LR−	Papel
Observación visual de asimetría escapular (winging, tilting)	—	—	hallazgo
Test de Asistencia Escapular	—	—	hallazgo

9 Disfunción de Primera Costilla (Zona Cervicotorácica)

Test	LR+	LR−	Papel
Palpación posteroanterior de 1ª costilla	—	—	hallazgo
Test de elevación del brazo post-movilización	—	—	hallazgo

10 Artrosis Glenohumeral

Test	LR+	LR−	Papel
Mayor edad + crepitación con rigidez activa = pasiva	—	—	hallazgo

11 Luxación Bloqueada o Fractura (→ Rx)

Test	LR+	LR−	Papel
Test de aprensión ósea y percusión olécranon-manubrio	—	—	hallazgo

LR en **verde**: multiplica la puntuación (LR+ ≥ 2 o LR− ≤ 0,5); en gris: no informativa, cuenta como hallazgo. «≈» = calculada de S y E. **puntúa**: puede mover la puntuación · hallazgo: sin LR aplicable · en clúster: solo cuenta con su clúster 🧩 · pronóstico: no entra en la puntuación. Criterio completo de cada test, fuentes y calculadora de la puntuación, en la guía (QR).

PhysiQ-Assessment · fase 4b · Hombro. Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

Cribado sistémico · Codo

PhysiQ-Assessment · fase 2. Lo que se pregunta siempre en codo. Las condiciones especiales, en la página siguiente. El porqué de cada pregunta, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. d02e73b1

🦴 Traumático (Fractura o Luxación)

1. **¿Se ha caído o se ha dado un golpe en el codo en los últimos días y no consigue estirarlo del todo? (Prueba de extensión del codo: brazos al frente con las palmas hacia arriba, comparar con el otro lado.)** URGENCIA
2. **¿Tras una caída o un golpe, el codo se ve deformado, o la mano está dormida, fría o pálida?** URGENCIA

🩸 Vascular / Neurológica

1. ¿Se le ponen los dedos blancos o azules con el frío o con los nervios?
2. Si se le ponen los dedos blancos o azules con el frío, ¿le pasa solo en una mano?
3. Si se le ponen los dedos blancos o azules con el frío, ¿empezó hace menos de 2 años o ha ido a peor?
4. ¿Tiene zonas del brazo o de la mano dormidas o con menos sensibilidad, aunque no le duelan?
5. ¿Tiene debilidad progresiva en el brazo o la mano que no se relaciona con el dolor local del codo?
6. ¿Nota que los músculos se le cansan cada vez más mientras los usa y se recuperan al descansar, o que al final del día se le caen los párpados o ve doble?
7. **Si se ha desmayado alguna vez: ¿fue mientras hacía un esfuerzo, estando tumbado, justo después de notar de golpe el corazón muy rápido, o con dolor en el pecho o falta de aire nuevos? ¿O algún familiar suyo murió de forma súbita antes de los 40 años?** URGENCIA

🦠 Infecciosa / Inflamatoria

1. **¿Hay fiebre, enrojecimiento intenso y calor local en la articulación del codo?** URGENCIA
2. ¿El dolor es constante, nocturno, intenso y no cede con ninguna posición ni reposo?

⚗️ Endocrino / Metabólico

1. ¿Tiene síndrome del túnel carpiano en ambas manos a la vez, o síntomas similares también en el codo contralateral?
2. ¿Le cuesta más que antes subir escaleras o levantarse de una silla?

🩸 Hematológico

1. ¿Sangra o se le forman moretones fácilmente después de un traumatismo menor, cirugía o procedimiento dental?
2. ¿Experimenta falta de aire, palpitaciones o dolor en el pecho con esfuerzos leves (subir escaleras) o en reposo?
3. ¿Padece infecciones recurrentes o fiebre baja frecuente (resfriados, gripe, infecciones respiratorias)?
4. **¿Está recibiendo tratamiento contra el cáncer (quimioterapia o radioterapia) y se encuentra mal o tiene fiebre?** URGENCIA
5. **(Si tiene hemofilia u otro trastorno hereditario de la coagulación) ¿Tiene un dolor nuevo en una articulación o un músculo, con hormigueo o tirantez, hinchazón, calor o dificultad para moverla?** URGENCIA
6. ¿Ha notado heces negras/alquitranadas, sangre en orina, o ha tosido o vomitado sangre?

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Solo se preguntan si el paciente tiene la condición (en la app, su tarjeta de la fase 1 marcada, o el mecanismo «Post-quirúrgico»). La escala de Beighton, la sospecha del subtipo vascular, la prueba de bipedestación, la regla de la tensión en el embarazo y la tensión tumbado y de pie del Parkinson se calculan en la guía (QR).

🏥 Posquirúrgico

Solo con mecanismo «Post-quirúrgico» en la fase 1

1. **¿Desde la operación, la herida está más roja, caliente, hinchada o dolorosa, supura o se ha abierto, o ha tenido fiebre, escalofríos o malestar general?** URGENCIA
2. **¿Desde la operación tiene una pantorrilla, una pierna o el brazo operado hinchados, calientes o dolorosos? (En la pierna, posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.)** URGENCIA
3. **¿Le falta el aire de repente, le duele el pecho al respirar, ha tosido sangre o se ha mareado o desmayado?** URGENCIA
4. **¿Desde la operación, o desde que le pusieron un yeso, una férula o un vendaje, tiene un dolor intenso y desproporcionado que va a más, sobre todo al estirar los dedos, con la zona muy tensa, hormigueo o adormecimiento?** URGENCIA
5. ¿Tiene un dolor continuo y desproporcionado para la operación, con cambios de color, temperatura, sudoración o hinchazón en la zona, o le duele incluso el roce de la ropa?
6. **¿Desde la operación nota un dolor quemante, hormigueo, adormecimiento o pérdida de fuerza nuevos en la zona de un nervio (por ejemplo, en la mano o el pie del lado operado)?** URGENCIA

🧬 Hipermovilidad

Solo con tarjeta «Hipermovilidad / Ehlers-Danlos» marcada

1. **¿Ha tenido de forma brusca un dolor intenso, que va a más, en el abdomen, el flanco, la espalda, el pecho o un brazo o una pierna?** URGENCIA
   con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida
2. **¿Ha notado de repente un zumbido en la sien, con el ojo rojo, dolorido o más saltón?** URGENCIA *con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida*
3. **¿Le ha faltado el aire de forma brusca, o le duele el pecho al respirar?** URGENCIA
   con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida
4. ¿Algún familiar de primer grado con SED vascular, o con una rotura o disección arterial antes de los 40 años? *con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)*
5. ¿Ha tenido una rotura arterial o una rotura de intestino sin causa conocida?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
6. ¿Ha tenido algún neumotórax espontáneo?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
7. ¿Le salen hematomas sin golpes, en sitios poco habituales (mejillas, espalda), o tiene la piel fina y translúcida, con las venas muy visibles?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
8. ¿Tuvo varices antes de los 30 años (y, si es mujer, sin haber estado embarazada)?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)

🫀 Disautonomía

Solo con tarjeta «Disautonomía / POTS» marcada

1. **¿Se ha desmayado alguna vez mientras hacía un esfuerzo (no justo al pararlo)?** URGENCIA
2. **¿Se ha desmayado estando tumbado, o justo después de notar de golpe el corazón muy rápido?** URGENCIA
3. **Si se ha desmayado: ¿tenía a la vez dolor en el pecho o falta de aire nuevos, o le han dicho que tiene un soplo, insuficiencia cardiaca u otra enfermedad del corazón?** URGENCIA
4. **Si se ha desmayado: ¿algún familiar murió de forma súbita antes de los 40 años, o tiene una enfermedad del corazón hereditaria?** URGENCIA
5. ¿Le dan episodios en que el corazón se le dispara de golpe y se le para también de golpe, aunque esté sentado o tumbado, sin llegar a desmayarse? DERIVACIÓN

🦋 Lupus

Solo con tarjeta «Lupus (LES)» marcada · solo «Diagnosticado»

1. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o se encuentra mal en general de una forma nueva? (Con corticoides o inmunosupresores puede haber una infección sin fiebre.)** URGENCIA
2. **¿Tiene una pantorrilla o una pierna (o un brazo) hinchada, caliente o dolorosa de forma nueva? (Posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.)** URGENCIA
3. **¿Le ha faltado el aire de repente o le duele el pecho al respirar? ¿O ha tenido de golpe debilidad o adormecimiento de un lado, dificultad para hablar o pérdida de visión, aunque se le haya pasado?** URGENCIA
4. **¿Tiene un dolor en el pecho punzante que empeora al respirar hondo y mejora inclinándose hacia delante?** URGENCIA
5. **¿Tiene en algún dedo de la mano o del pie una herida o úlcera en la yema, o un dedo que se queda blanco o morado y no recupera el color?** URGENCIA
6. **¿Ha tenido una convulsión o confusión nueva; debilidad u hormigueo en las dos piernas que va a más, con cambios al orinar; de golpe, el pie o la mano caídos; o pérdida de visión?** URGENCIA
7. ¿Tiene un dolor profundo y persistente en la ingle, la rodilla, el hombro o el tobillo, que empeora al cargar o al andar y no se explica por un golpe? DERIVACIÓN
8. ¿Le cuesta cada vez más levantarse de una silla, subir escaleras o levantar los brazos por encima de la cabeza? DERIVACIÓN
9. Desde la última vez que le vio su reumatólogo, ¿tiene articulaciones hinchadas nuevas, una erupción, llagas en la boca o más caída de pelo? DERIVACIÓN
10. ¿Se le hinchan las piernas o los tobillos de forma nueva, le han dicho que tiene la tensión alta desde hace poco, o en un análisis que tiene proteínas o sangre en la orina? DERIVACIÓN

💉 Trastorno mastocitario o anafilaxia

Solo con tarjeta «Trastorno mastocitario o anafilaxia» marcada

1. Desde su última revisión médica, ¿ha tenido episodios bruscos con ronchas, hinchazón, falta de aire, mareo o desmayo que su médico aún no conoce? DERIVACIÓN

🦴 Osteoporosis

Solo con tarjeta «Osteoporosis o fragilidad ósea» marcada

1. **¿Tiene un dolor de espalda nuevo con debilidad, hormigueo o torpeza en las piernas que va a más, o cambios al orinar o al hacer de vientre?** URGENCIA
2. ¿Le empezó de golpe un dolor de espalda, sobre todo en la zona dorsal, tras un esfuerzo pequeño (levantar algo agachado, toser, estornudar, resbalar), y no se le ha ido? DERIVACIÓN
3. ¿Ha perdido 4 cm o más de altura respecto a cuando era joven (o 2 cm desde la última vez que se la midieron), o se le ha curvado más la espalda? DERIVACIÓN
   sin fractura vertebral conocida
4. ¿Tiene un dolor de muslo, ingle o cadera sin explicación? DERIVACIÓN
   con bifosfonato o denosumab

🤰 Embarazo y posparto

Solo con tarjeta «Embarazo o posparto» marcada

1. **¿Tiene dolor de cabeza fuerte o que no se le pasa, ve borroso o destellos, dolor fuerte justo debajo de las costillas, vómitos, o se le han hinchado de golpe la cara, las manos o los pies?** URGENCIA *embarazo desde la semana 20 o posparto*
2. **¿Ha tenido un sangrado vaginal que no le han explicado?** URGENCIA
   solo embarazo desde la semana 13
3. **¿Nota que el bebé se mueve menos de lo habitual?** URGENCIA
   solo embarazo desde la semana 24
4. **¿Tiene contracciones regulares y dolorosas, o le sale líquido por la vagina?** URGENCIA *solo embarazo*
5. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o se encuentra muy mal?** URGENCIA *solo embarazo*
6. **¿Tiene un sangrado vaginal brusco o muy abundante, que va a más, o expulsa coágulos o restos? ¿O se le ha hinchado mucho el vientre?** URGENCIA *solo posparto*
7. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o dolor de vientre, pelvis o periné, o un flujo que huele mal?** URGENCIA *solo posparto hasta la semana 8 tras el parto*
8. **¿Tiene dolor e hinchazón nuevos en una pierna, sobre todo en una sola; o dolor de espalda o de nalga con toda la pierna hinchada; o le falta el aire de forma nueva, le duele el pecho o ha tosido sangre?** URGENCIA
9. **¿Tiene dolor en el pecho, palpitaciones, o le falta el aire en reposo o al tumbarse?** URGENCIA
10. **¿Se le ha abierto la herida del periné o la de la cesárea, o tiene más dolor, rojez o supuración en ella?** URGENCIA *solo posparto*
11. **¿Desde el parto se le escapa la orina o las heces de forma continua, sin poder controlarlo nada?** URGENCIA *solo posparto*
12. **(Si hace falta, al acompañante) ¿Ha notado cambios bruscos desde el parto: confusión, ideas extrañas, euforia o mucha agitación?** URGENCIA *solo posparto*
13. **¿Ha pensado en hacerse daño o en quitarse la vida?** URGENCIA
14. ¿Tiene un dolor de espalda intenso y que no se le pasa, dorsal o lumbar, en el embarazo o desde el parto, o ha perdido 3 cm o más de altura? DERIVACIÓN
15. ¿Desde el parto tiene un dolor intenso o que empezó de golpe en la sacroilíaca, la nalga, la zona lumbar o el pubis, le cuesta apoyar o cojea, o se le alivia tumbada? DERIVACIÓN
    solo posparto hasta la semana 2 tras el parto
16. ¿Tiene un pecho rojo e hinchado desde hace más de 24 horas, aunque se lo haya tratado? DERIVACIÓN *solo posparto*

🩸 Anticoagulado o antiagregado

Solo con tarjeta «Paciente anticoagulado o antiagregado» marcada

1. **¿Se ha dado un golpe en la cabeza en los últimos días, aunque pareciera leve?** URGENCIA *no con aspirina sola*
2. **Desde un golpe en la cabeza (de hace días o semanas), ¿tiene un dolor de cabeza fuerte o que va a más, vómitos repetidos, somnolencia, confusión o cambios de conducta, o debilidad, dificultad para hablar o cambios de visión nuevos?** URGENCIA
3. **¿Le ha empezado de golpe un dolor fuerte de cuello o de espalda con debilidad, hormigueo o adormecimiento en brazos o piernas, o cambios al orinar o al hacer de vientre? (Puede empezar por la debilidad, sin dolor fuerte.)** URGENCIA
4. **¿Le ha empezado un dolor fuerte en la ingle, la cadera, el costado o la zona lumbar baja, con el muslo débil o adormecido, o con mareo, palidez o sudor frío? (Con un golpe pequeño o sin golpe.)** URGENCIA *solo con anticoagulante*
5. **¿Le ha salido de golpe, tras toser, un esfuerzo o una inyección de heparina, un dolor fuerte en la pared de la barriga con un bulto, que empeora al moverse o al tensar el abdomen?** URGENCIA *solo con anticoagulante*
6. **¿Tiene un brazo, un antebrazo, una mano, un muslo o una pierna muy hinchados y tensos, con un dolor desproporcionado que va a más y que empeora al estirarle pasivamente los dedos de la mano o del pie? (Tras un golpe pequeño, un esfuerzo o sin causa.)** URGENCIA
7. ¿Tiene un hematoma grande o que va a más, un bulto nuevo en un músculo, o una articulación hinchada tras un golpe pequeño o sin golpe? DERIVACIÓN

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

🧠 Parkinson

Solo con tarjeta «Parkinson» marcada

1. **En los últimos días, ¿está mucho más rígido o inmóvil que de costumbre y además tiene fiebre, está confuso, suda mucho o le cuesta tragar?** URGENCIA
   solo «Diagnosticado»
2. ¿Ha dejado de tomar su medicación del Parkinson, o no puede tomarla o retenerla (vómitos, diarrea, no puede tragar, una cirugía)? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
3. ¿Han vuelto de golpe el temblor, la rigidez o la lentitud, o tiene movimientos involuntarios fuertes o cambios de conducta nuevos? DERIVACIÓN *con estimulador cerebral profundo*
4. ¿Tiene periodos off que no sabe prever, movimientos involuntarios fuertes o calambres dolorosos cuando está en off? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
5. ¿Ve cosas que no están, o tiene conductas nuevas que no puede controlar (tomar medicación de más, juego, compras, comida)? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
6. ¿Se marea, ve borroso, nota las piernas flojas o le duele el cuello y los hombros al estar de pie, y se le pasa al sentarse o tumbarse? DERIVACIÓN
7. ¿Tose o se atraganta al comer o beber, o ha tenido infecciones respiratorias seguidas? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
8. ¿Se queda dormido de repente durante el día, sin poder evitarlo? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
9. Temblor, rigidez, lentitud, problemas de equilibrio o de la marcha, sin diagnóstico DERIVACIÓN *solo «Sospecha»*

URGENCIA derivar hoy DERIVACIÓN valoración médica, no urgente *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

Árbol de decisión — Codo

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Codo. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b. El porqué de cada paso, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. 041e8ec9

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

1 ¿Hubo un evento traumático, hay deformidad muscular característica o es un niño o adolescente?

📝 G2 · R1, R2

SÍ — Pérdida del contorno normal del brazo (a veces sutil), hinchazón y debilidad en flexión/supinación → **7 Rotura Distal del Bíceps**

FRACTURA / LUXACIÓN — Caída o golpe con deformidad del codo, o el codo no llega a estirarse del todo: sospecha de fractura o luxación → derivación médica → **Derivación médica**: Sospecha de fractura o luxación tras un traumatismo (deformidad, o el codo no llega a estirarse del todo: casi un 50 % de fracturas en Appelboam 2008): derivación médica para radiografía; antes, explorar la sensibilidad, el color y la temperatura de la mano.

NIÑO O ADOLESCENTE — Esqueleto inmaduro: tirón del brazo extendido en un menor de 5 años, lanzador joven con dolor medial, o dolor lateral insidioso entre los 7 y los 12 años →
- **14 Pronación Dolorosa (Subluxación de la Cabeza del Radio en el Niño)**
- **15 Codo de la Liga Infantil (Apofisitis o Avulsión del Epicóndilo Medial en el Lanzador Joven)**
- **16 Enfermedad de Panner / Osteocondritis Disecante del Capítulo**

NO — Sin traumatismo significativo ni deformidad → sin hipótesis

todas →

2 ¿Existe una restricción GLOBAL y dolorosa de todos los movimientos del codo (flexión, extensión, pronación, supinación)?

📝 R3, R5, R6, R7

SÍ — Limitación activa y pasiva en todos los planos → **3 Rigidez del Codo (Contractura Postraumática o Capsular)**

NO — Movilidad mayormente preservada → sin hipótesis

todas →

3 ¿Presenta parestesias, debilidad intrínseca de la mano o dolor quemante en el antebrazo?

📝 R4, R5, R6, R7

SÍ — Zona medial: parestesias en 4º y 5º dedo, Tinel positivo en surco epitrócleo-olecraniano → **8 Neuropatía Cubital (Síndrome del Túnel Cubital)**

SÍ — Zona dorsal/lateral: dolor en el dorso del antebrazo proximal, distal al epicóndilo, o debilidad para extender los dedos → **9 Neuropatía Radial en el Codo (Síndrome del Túnel Radial / del Nervio Interóseo Posterior)**

SÍ — Zona anterior: dolor en el antebrazo anterior, parestesias del 1.º al 3.º dedo o debilidad de la flexión del pulgar y del índice → **13 Neuropatía del Mediano en el Codo (Síndrome del Pronador / del Nervio Interóseo Anterior)**

NO — Sin síntomas neurales → sin hipótesis

Todas → sigue en el paso 4, en la página siguiente →

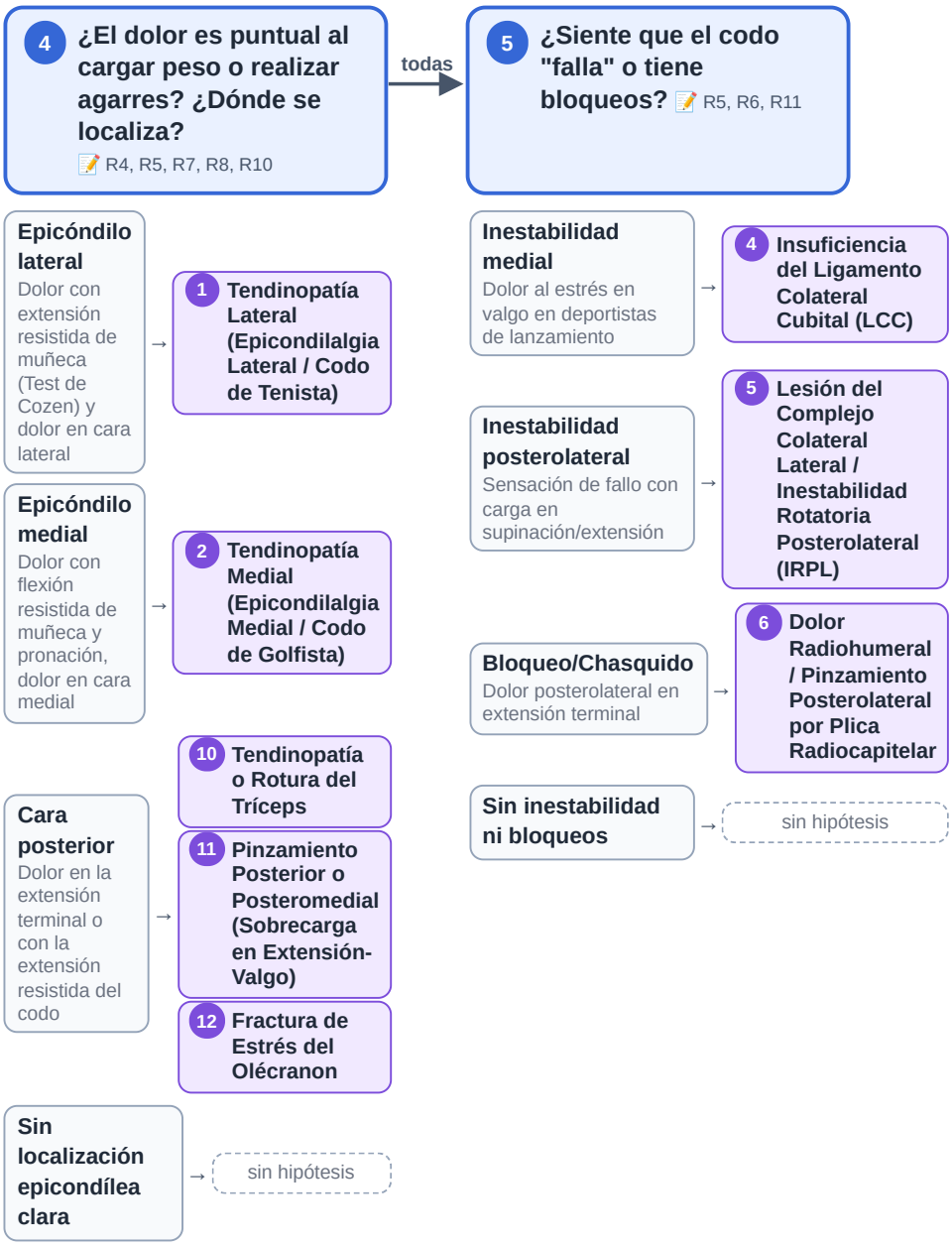
Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor de codo inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

↓ Paso 4: viene del paso 3



Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor de codo inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Confirmación de hipótesis · Codo

PhysiQ-Assessment · fase 4b. Los tests de cada hipótesis, sus LR y si puntúan. El criterio de cada test, por qué se hace, sus fuentes, «Ampliar con IA» y una calculadora que puntúa cada hipótesis con los tests que marques, en la guía de consulta (QR).

Porqués, IA y calculadora
v. 9a5d7042

1 Tendinopatía Lateral (Epicondilalgia Lateral / Codo de Tenista)

Test	LR+	LR−	Papel
Test de Cozen (extensión resistida de muñeca)	—	—	hallazgo
Reducción de fuerza de prensión (diferencia 5-10% entre posiciones)	—	—	hallazgo
Test de Thomsen (= test de Cozen)	—	—	hallazgo
Fuerza de prensión sin dolor (dinamómetro)	—	—	hallazgo

2 Tendinopatía Medial (Epicondilalgia Medial / Codo de Golfista)

Test	LR+	LR−	Papel
Dolor a la palpación del epicóndilo medial	—	—	hallazgo
Dolor con flexión resistida de antebrazo y pronación	—	—	hallazgo
Ecografía (si se dispone de informe)	—	—	hallazgo
Test de Polk (medial)	—	—	hallazgo

3 Rigidez del Codo (Contractura Postraumática o Capsular)

Test	LR+	LR−	Papel
Test de ROM activo en 4 direcciones	—	—	hallazgo
Limitación activa Y pasiva comparada con lado sano	—	—	hallazgo

4 Insuficiencia del Ligamento Colateral Cubital (LCC)

Test	LR+	LR−	Papel
Ecografía dinámica con estrés en valgo	≈5.1	≈0.05	puntúa
RM con artrograma	≈9.0	≈0.21	puntúa
Test de valgo móvil (moving valgus stress test)	—	—	hallazgo
Test de valgo estático (dolor)	1.3	0.71	hallazgo
Test de valgo estático (laxitud)	—	0.81	hallazgo
Dolor a la palpación justo distal al epicóndilo medial	—	—	hallazgo

5 Lesión del Complejo Colateral Lateral / Inestabilidad Rotatoria Posterolateral (IRPL)

Test	LR+	LR−	Papel
Test de cajón posterolateral / Test de pivote lateral	—	—	hallazgo
Dolor lateral a la palpación (complejo colateral lateral)	—	—	hallazgo
Test de flexión en suelo (push-up) con el antebrazo en supinación	—	—	hallazgo
Test de recolocación en la mesa (table-top relocation)	—	—	hallazgo
Dolor y laxitud con estrés en varo	—	—	hallazgo

6 Dolor Radiohumeral / Pinzamiento Posterolateral por Plica Radiocapitelar

Test	LR+	LR−	Papel
Dolor posterolateral en línea articular radiocapitelar a la palpación	—	—	hallazgo
Test de plica radiocapitelar posterolateral	—	—	hallazgo
PEPPER (palpación-extensión de la radiocapitelar)	—	—	hallazgo
SALT (supinación y dolor anterolateral)	—	—	hallazgo
Test de flexión-pronación	—	—	hallazgo
Deslizamientos accesorios de la cabeza del radio	—	—	hallazgo

7 Rotura Distal del Bíceps

Test	LR+	LR−	Papel
Test del Gancho (Hook Test)	16	0.30	puntúa
Pérdida del contorno normal del brazo y tendón distal no palpable	—	—	hallazgo
Pronación pasiva del antebrazo (PFP) / test de pronosupinación pasiva	3.3	0.34	puntúa

8 Neuropatía Cubital (Síndrome del Túnel Cubital)

Test	LR+	LR−	Papel
Test de Tinel en túnel cubital	—	—	hallazgo
Evaluación de subluxación del nervio cubital	—	—	hallazgo
Electrodiagnóstico (velocidad de conducción nerviosa)	—	—	hallazgo
Test de flexión del codo	—	—	hallazgo
Test de rotación interna del hombro con flexión del codo (SIRT)	—	—	hallazgo
Test de rotación interna del hombro con flexión máxima del codo (SIREFT)	—	—	hallazgo

9 Neuropatía Radial en el Codo (Síndrome del Túnel Radial / del Nervio Interóseo Posterior)

Test	LR+	LR−	Papel
Dolor en antebrazo proximal (NO en epicóndilo lateral)	—	—	hallazgo
Dolor con extensión resistida del 3er dedo	—	—	hallazgo
Dolor con supinación resistida con el codo extendido	—	—	hallazgo
Neurodinámica del nervio radial (ULNT radial)	—	—	hallazgo
Debilidad de la extensión de los dedos (síndrome del nervio interóseo posterior)	—	—	hallazgo

10 Tendinopatía o Rotura del Tríceps

Test	LR+	LR−	Papel
Dolor con la extensión activa o resistida del codo	—	—	hallazgo
Dolor a la palpación de la inserción del tríceps	—	—	hallazgo
Defecto palpable e hinchazón (rotura)	—	—	hallazgo
Test de compresión del tríceps (triceps squeeze test)	—	—	hallazgo

11 Pinzamiento Posterior o Posteromedial (Sobrecarga en Extensión-Valgo)

Test	LR+	LR−	Papel
Dolor en la extensión terminal del codo	—	—	hallazgo
Déficit fijo de extensión	—	—	hallazgo
Arm bar test	—	—	hallazgo
Test de sobrecarga en valgo (valgus overload)	—	—	hallazgo

12 Fractura de Estrés del Olécranon

Test	LR+	LR−	Papel
Dolor con la extensión del codo, sin traumatismo	—	—	hallazgo
Pérdida de la extensión terminal	—	—	hallazgo
TC (si la radiografía no es concluyente)	—	—	hallazgo

13 Neuropatía del Mediano en el Codo (Síndrome del Pronador / del Nervio Interóseo Anterior)

Test	LR+	LR−	Papel
Dolor a la palpación del pronador redondo	—	—	hallazgo
Síntomas con la pronación resistida con el codo extendido	—	—	hallazgo
Debilidad del flexor largo del pulgar, del flexor profundo del 2.º y 3.º dedo, del flexor superficial y del pronador redondo	—	—	hallazgo
Neurodinámica del nervio mediano (ULNT mediano)	—	—	hallazgo
Debilidad aislada del flexor profundo del 2.º y 3.º dedo y del flexor largo del pulgar (interóseo anterior)	—	—	hallazgo

14 Pronación Dolorosa (Subluxación de la Cabeza del Radio en el Niño)

Test	LR+	LR−	Papel
Tirón del brazo extendido en un menor de 5 años, sin caída	—	—	hallazgo
Dolor y limitación de la pronación y de la extensión del codo	—	—	hallazgo

15 Codo de la Liga Infantil (Apofisitis o Avulsión del Epicóndilo Medial en el Lanzador Joven)

Test	LR+	LR−	Papel
Dolor medial con el lanzamiento en un deportista con el esqueleto inmaduro	—	—	hallazgo
Dolor y laxitud con el estrés en valgo o el valgo móvil	—	—	hallazgo

16 Enfermedad de Panner / Osteocondritis Disecante del Capítulo

Test	LR+	LR−	Papel
Dolor lateral sordo e hinchazón de inicio insidioso entre los 7 y los 12 años	—	—	hallazgo
Imagen: radiografía o RM	—	—	hallazgo

LR en **verde**: multiplica la puntuación (LR+ ≥ 2 o LR− ≤ 0,5); en gris: no informativa, cuenta como hallazgo. «≈» = calculada de S y E. **puntúa**: puede mover la puntuación · hallazgo: sin LR aplicable · en clúster: solo cuenta con su clúster 🧩 · pronóstico: no entra en la puntuación. Criterio completo de cada test, fuentes y calculadora de la puntuación, en la guía (QR).

PhysiQ-Assessment · fase 4b · Codo. Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

Cribado sistémico · Lumbar

PhysiQ-Assessment · fase 2. Lo que se pregunta siempre en lumbar. Las condiciones especiales, en la página siguiente. El porqué de cada pregunta, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. 061d53f7

URGENCIAS HOY · CAUDA EQUINA
· Urgencia quirúrgica: el tiempo hasta la cirugía pesa más que la duración de los síntomas.
· Dolor o debilidad bilateral grave en MMII · parestesia en silla de montar · retención o incontinencia urinaria · incontinencia fecal · menor tono anal.
· PREGUNTAR SIEMPRE. Signos más específicos que sensibles; RM de elección. En mayores con estenosis el inicio lento se solapa y pasa desapercibido.

Cáncer / Oncológico

1. ¿Tiene antecedentes de cáncer de cualquier tipo?
2. ¿El dolor nocturno lo despierta desde un sueño profundo y le resulta imposible encontrar una posición que lo alivie?

Urogenital / Renal

1. ¿Ha notado cambios en la orina (color rojo, marrón, turbio) o fiebre/escalofríos junto con el dolor de espalda?
2. **¿Presenta incontinencia urinaria o intestinal, o pérdida de sensibilidad en la zona de "silla de montar"?** URGENCIA
3. ¿Tiene desde hace meses dolor en el sacro, el cóccix, el periné o el ano que empeora al estar sentado y se alivia tumbado, junto con molestias de orina, de heces o sexuales que ya tenía? DERIVACIÓN
4. ¿En las últimas 3–4 semanas ha notado ardor o dolor al orinar?
5. ¿Desde hace poco se levanta a orinar más de una vez cada noche, sin que haya cambiado lo que bebe antes de acostarse?
6. ¿Ha tenido un dolor muy intenso en el costado o la zona lumbar, que va y viene a oleadas y baja hacia la ingle o los genitales, con náuseas o vómitos?
7. ¿Tiene desde hace meses un dolor sordo en el costado o la zona lumbar izquierda que empeora de pie y mejora tumbado, y además le han encontrado sangre en la orina (aunque sea solo en un análisis), tiene varices en el lado izquierdo del escroto o, en mujeres, un dolor de pelvis que empeora de pie? DERIVACIÓN

Gastrointestinal

1. ¿El dolor lumbar, sacro o pélvico se alivia o cambia después de tener una evacuación intestinal o al expulsar gases?
2. ¿El dolor está relacionado con su ciclo menstrual, tiene sangrado inusual o dolor que alterna con dolor abdominal?
3. ¿Ha notado heces negras/alquitranadas, sangre en las heces, o dolor que lo despierta entre la medianoche y las 3 am?

Espondiloartropatías / Espondilogénicas / Ginecológico

1. ¿Tiene rigidez matutina prolongada (más de 30 minutos) que mejora con el movimiento?
2. ¿El dolor cambia de un glúteo a otro, unas veces en un lado y otras en el otro?
3. ¿El dolor sigue igual o empeora cuando descansa, en lugar de aliviarse?
4. ¿El dolor sacroilíaco lo despierta en la segunda mitad de la noche (entre las 2 y las 5 am)?
5. ¿El dolor pélvico está claramente relacionado con el ciclo menstrual, o tiene sangrado ginecológico inusual?
6. **(Mujeres en edad fértil) ¿Tiene un dolor de pelvis, abdomen bajo o espalda, nuevo o intenso, junto con un retraso de la regla, un sangrado vaginal inesperado, o mareo o desmayo?** URGENCIA
7. ¿Tiene diagnóstico de osteoporosis, o ha tenido una fractura reciente ante un golpe menor o sin trauma aparente?
8. ¿Ha notado deformidad ósea, engrosamiento de huesos o ha sido diagnosticado de enfermedad de Paget?
9. ¿Hace deporte o actividad vigorosa y repetitiva (p. ej. correr) y el dolor de nalga aparece con ella, con dieta pobre, alteraciones menstruales o fracturas de estrés previas?
10. ¿Ha aparecido de golpe dolor en ambas piernas durante el deporte, tras lesiones repetidas en extensión de la espalda?

Patrón compatible con dolor lumbar inflamatorio: derivación preferente a reumatología. — 2 o más de las preguntas 1, 4, 2, 3 · edad ≤ 45 · evolución: Crónico (>3 meses)

Vascular

1. ¿El dolor de piernas al caminar se le pasa con solo pararse de pie, sin necesidad de sentarse ni inclinarse?
2. ¿Tiene dolor lumbar o abdominal en reposo o por la noche, o le han notado un bulto que late en el abdomen?
3. ¿Nota un pie más frío que el otro, o le han dicho que tiene los pulsos de las piernas débiles?
4. **¿Le ha aparecido hace poco una pantorrilla o toda una pierna hinchada, caliente o dolorosa? (Posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.)** URGENCIA
5. **Si se ha desmayado alguna vez: ¿fue mientras hacía un esfuerzo, estando tumbado, justo después de notar de golpe el corazón muy rápido, o con dolor en el pecho o falta de aire nuevos? ¿O algún familiar suyo murió de forma súbita antes de los 40 años?** URGENCIA

Infección vertebral

1. ¿Ha tenido fiebre o alguna infección en las últimas semanas, le han operado o infiltrado la espalda hace poco, o tiene las defensas bajas (corticoides, inmunosupresores, VIH, diabetes)?

Endocrino / Metabólico

1. ¿Siente fatiga inusual o debilidad muscular, especialmente al subir escaleras o levantarse de una silla?
2. ¿Ha notado aumento anormal de sed, apetito o frecuencia urinaria (incluso despertándose por la noche)?
3. ¿Ha experimentado cambios recientes en su peso o tolerancia a la temperatura (mucho frío o calor cuando otros no)?
4. ¿Nota que sus heridas sanan muy lentamente o le aparecen moretones con excesiva facilidad?
5. (Si tiene diabetes) ¿Suele tener episodios de bajadas de azúcar, o siente ardor, entumecimiento o pérdida de sensibilidad en manos y pies?

Hematológico

1. ¿Sangra o se le forman moretones fácilmente después de un traumatismo menor, cirugía o procedimiento dental?
2. ¿Experimenta falta de aire, palpitaciones o dolor en el pecho con esfuerzos leves (subir escaleras) o en reposo?
3. ¿Padece infecciones recurrentes o fiebre baja frecuente (resfriados, gripe, infecciones respiratorias)?
4. **¿Está recibiendo tratamiento contra el cáncer (quimioterapia o radioterapia) y se encuentra mal o tiene fiebre?** URGENCIA
5. **(Si tiene hemofilia u otro trastorno hereditario de la coagulación) ¿Tiene un dolor nuevo en una articulación o un músculo, con hormigueo o tirantez, hinchazón, calor o dificultad para moverla?** URGENCIA
6. ¿Ha notado heces negras/alquitranadas, sangre en orina, o ha tosido o vomitado sangre?

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Condiciones especiales · Lumbar

Solo se preguntan si el paciente tiene la condición (en la app, su tarjeta de la fase 1 marcada, o el mecanismo «Post-quirúrgico»). La escala de Beighton, la sospecha del subtipo vascular, la prueba de bipedestación, la regla de la tensión en el embarazo y la tensión tumbado y de pie del Parkinson se calculan en la guía (QR).

🏥 Posquirúrgico

Solo con mecanismo «Post-quirúrgico» en la fase 1

1. **¿Desde la operación, la herida está más roja, caliente, hinchada o dolorosa, supura o se ha abierto, o ha tenido fiebre, escalofríos o malestar general?** URGENCIA
2. **¿Desde la operación tiene una pantorrilla o una pierna hinchada, caliente o dolorosa? (Posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.)** URGENCIA
3. **¿Le falta el aire de repente, le duele el pecho al respirar, ha tosido sangre o se ha mareado o desmayado?** URGENCIA
4. **¿Desde la operación de columna nota en los brazos o las piernas un dolor, hormigueo, adormecimiento o pérdida de fuerza nuevos o que van a más, torpeza al caminar, o cambios al orinar o al hacer de vientre?** URGENCIA

🧬 Hipermovilidad

Solo con tarjeta «Hipermovilidad / Ehlers-Danlos» marcada

1. **¿Ha tenido de forma brusca un dolor intenso, que va a más, en el abdomen, el flanco, la espalda, el pecho o un brazo o una pierna?** URGENCIA
   con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida
2. **¿Ha notado de repente un zumbido en la sien, con el ojo rojo, dolorido o más saltón?** URGENCIA
   con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida
3. **¿Le ha faltado el aire de forma brusca, o le duele el pecho al respirar?** URGENCIA
   con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida
4. ¿Algún familiar de primer grado con SED vascular, o con una rotura o disección arterial antes de los 40 años?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
5. ¿Ha tenido una rotura arterial o una rotura de intestino sin causa conocida?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
6. ¿Ha tenido algún neumotórax espontáneo?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
7. ¿Le salen hematomas sin golpes, en sitios poco habituales (mejillas, espalda), o tiene la piel fina y translúcida, con las venas muy visibles?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
8. ¿Tuvo varices antes de los 30 años (y, si es mujer, sin haber estado embarazada)?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)

🫀 Disautonomía

Solo con tarjeta «Disautonomía / POTS» marcada

1. **¿Se ha desmayado alguna vez mientras hacía un esfuerzo (no justo al pararlo)?** URGENCIA
2. **¿Se ha desmayado estando tumbado, o justo después de notar de golpe el corazón muy rápido?** URGENCIA
3. **Si se ha desmayado: ¿tenía a la vez dolor en el pecho o falta de aire nuevos, o le han dicho que tiene un soplo, insuficiencia cardiaca u otra enfermedad del corazón?** URGENCIA
4. **Si se ha desmayado: ¿algún familiar murió de forma súbita antes de los 40 años, o tiene una enfermedad del corazón hereditaria?** URGENCIA
5. ¿Le dan episodios en que el corazón se le dispara de golpe y se le para también de golpe, aunque esté sentado o tumbado, sin llegar a desmayarse? DERIVACIÓN

🦋 Lupus

Solo con tarjeta «Lupus (LES)» marcada · solo «Diagnosticado»

1. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o se encuentra mal en general de una forma nueva? (Con corticoides o inmunosupresores puede haber una infección sin fiebre.)** URGENCIA
2. **¿Tiene una pantorrilla o una pierna (o un brazo) hinchada, caliente o dolorosa de forma nueva? (Posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.)** URGENCIA
3. **¿Le ha faltado el aire de repente o le duele el pecho al respirar? ¿O ha tenido de golpe debilidad o adormecimiento de un lado, dificultad para hablar o pérdida de visión, aunque se le haya pasado?** URGENCIA
4. **¿Tiene un dolor en el pecho punzante que empeora al respirar hondo y mejora inclinándose hacia delante?** URGENCIA
5. **¿Tiene en algún dedo de la mano o del pie una herida o úlcera en la yema, o un dedo que se queda blanco o morado y no recupera el color?** URGENCIA
6. **¿Ha tenido una convulsión o confusión nueva; debilidad u hormigueo en las dos piernas que va a más, con cambios al orinar; de golpe, el pie o la mano caídos; o pérdida de visión?** URGENCIA
7. ¿Tiene un dolor profundo y persistente en la ingle, la rodilla, el hombro o el tobillo, que empeora al cargar o al andar y no se explica por un golpe? DERIVACIÓN
8. ¿Le cuesta cada vez más levantarse de una silla, subir escaleras o levantar los brazos por encima de la cabeza? DERIVACIÓN
9. Desde la última vez que le vio su reumatólogo, ¿tiene articulaciones hinchadas nuevas, una erupción, llagas en la boca o más caída de pelo? DERIVACIÓN
10. ¿Se le hinchan las piernas o los tobillos de forma nueva, le han dicho que tiene la tensión alta desde hace poco, o en un análisis que tiene proteínas o sangre en la orina? DERIVACIÓN

💉 Trastorno mastocitario o anafilaxia

Solo con tarjeta «Trastorno mastocitario o anafilaxia» marcada

1. Desde su última revisión médica, ¿ha tenido episodios bruscos con ronchas, hinchazón, falta de aire, mareo o desmayo que su médico aún no conoce? DERIVACIÓN

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

🦴 Osteoporosis

Solo con tarjeta «Osteoporosis o fragilidad ósea» marcada

1. **¿Tiene un dolor de espalda nuevo con debilidad, hormigueo o torpeza en las piernas que va a más, o cambios al orinar o al hacer de vientre?** URGENCIA
2. ¿Le empezó de golpe un dolor de espalda, sobre todo en la zona dorsal, tras un esfuerzo pequeño (levantar algo agachado, toser, estornudar, resbalar), y no se le ha ido? DERIVACIÓN
3. ¿Ha perdido 4 cm o más de altura respecto a cuando era joven (o 2 cm desde la última vez que se la midieron), o se le ha curvado más la espalda? DERIVACIÓN *sin fractura vertebral conocida*
4. ¿Tiene un dolor de muslo, ingle o cadera sin explicación? DERIVACIÓN *con bifosfonato o denosumab*

🤰 Embarazo y posparto

Solo con tarjeta «Embarazo o posparto» marcada

1. **¿Tiene dolor de cabeza fuerte o que no se le pasa, ve borroso o destellos, dolor fuerte justo debajo de las costillas, vómitos, o se le han hinchado de golpe la cara, las manos o los pies?** URGENCIA *embarazo desde la semana 20 o posparto*
2. **¿Ha tenido un sangrado vaginal que no le han explicado?** URGENCIA *solo embarazo desde la semana 13*
3. **¿Nota que el bebé se mueve menos de lo habitual?** URGENCIA *solo embarazo desde la semana 24*
4. **¿Tiene contracciones regulares y dolorosas, o le sale líquido por la vagina?** URGENCIA *solo embarazo*
5. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o se encuentra muy mal?** URGENCIA *solo embarazo*
6. **¿Tiene un sangrado vaginal brusco o muy abundante, que va a más, o expulsa coágulos o restos? ¿O se le ha hinchado mucho el vientre?** URGENCIA *solo posparto*
7. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o dolor de vientre, pelvis o periné, o un flujo que huele mal?** URGENCIA *solo posparto hasta la semana 8 tras el parto*
8. **¿Tiene dolor e hinchazón nuevos en una pierna, sobre todo en una sola; o dolor de espalda o de nalga con toda la pierna hinchada; o le falta el aire de forma nueva, le duele el pecho o ha tosido sangre?** URGENCIA
9. **¿Tiene dolor en el pecho, palpitaciones, o le falta el aire en reposo o al tumbarse?** URGENCIA
10. **¿Se le ha abierto la herida del periné o la de la cesárea, o tiene más dolor, rojez o supuración en ella?** URGENCIA *solo posparto*
11. **¿Desde el parto se le escapa la orina o las heces de forma continua, sin poder controlarlo nada?** URGENCIA *solo posparto*
12. **(Si hace falta, al acompañante) ¿Ha notado cambios bruscos desde el parto: confusión, ideas extrañas, euforia o mucha agitación?** URGENCIA *solo posparto*
13. **¿Ha pensado en hacerse daño o en quitarse la vida?** URGENCIA
14. ¿Tiene un dolor de espalda intenso y que no se le pasa, dorsal o lumbar, en el embarazo o desde el parto, o ha perdido 3 cm o más de altura? DERIVACIÓN
15. ¿Desde el parto tiene un dolor intenso o que empezó de golpe en la sacroilíaca, la nalga, la zona lumbar o el pubis, le cuesta apoyar o cojea, o se le alivia tumbada? DERIVACIÓN *solo posparto hasta la semana 2 tras el parto*
16. ¿Tiene un pecho rojo e hinchado desde hace más de 24 horas, aunque se lo haya tratado? DERIVACIÓN *solo posparto*

🩸 Anticoagulado o antiagregado

Solo con tarjeta «Paciente anticoagulado o antiagregado» marcada

1. **¿Se ha dado un golpe en la cabeza en los últimos días, aunque pareciera leve?** URGENCIA *no con aspirina sola*
2. **Desde un golpe en la cabeza (de hace días o semanas), ¿tiene un dolor de cabeza fuerte o que va a más, vómitos repetidos, somnolencia, confusión o cambios de conducta, o debilidad, dificultad para hablar o cambios de visión nuevos?** URGENCIA
3. **¿Le ha empezado de golpe un dolor fuerte de cuello o de espalda con debilidad, hormigueo o adormecimiento en brazos o piernas, o cambios al orinar o al hacer de vientre? (Puede empezar por la debilidad, sin dolor fuerte.)** URGENCIA
4. **¿Le ha empezado un dolor fuerte en la ingle, la cadera, el costado o la zona lumbar baja, con el muslo débil o adormecido, o con mareo, palidez o sudor frío? (Con un golpe pequeño o sin golpe.)** URGENCIA *solo con anticoagulante*
5. **¿Le ha salido de golpe, tras toser, un esfuerzo o una inyección de heparina, un dolor fuerte en la pared de la barriga con un bulto, que empeora al moverse o al tensar el abdomen?** URGENCIA *solo con anticoagulante*
6. **¿Tiene un brazo, un antebrazo, una mano, un muslo o una pierna muy hinchados y tensos, con un dolor desproporcionado que va a más y que empeora al estirarle pasivamente los dedos de la mano o del pie? (Tras un golpe pequeño, un esfuerzo o sin causa.)** URGENCIA
7. ¿Tiene un hematoma grande o que va a más, un bulto nuevo en un músculo, o una articulación hinchada tras un golpe pequeño o sin golpe? DERIVACIÓN

🧠 Parkinson

Solo con tarjeta «Parkinson» marcada

1. **En los últimos días, ¿está mucho más rígido o inmóvil que de costumbre y además tiene fiebre, está confuso, suda mucho o le cuesta tragar?** URGENCIA *solo «Diagnosticado»*
2. ¿Ha dejado de tomar su medicación del Parkinson, o no puede tomarla o retenerla (vómitos, diarrea, no puede tragar, una cirugía)? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
3. ¿Han vuelto de golpe el temblor, la rigidez o la lentitud, o tiene movimientos involuntarios fuertes o cambios de conducta nuevos? DERIVACIÓN *con estimulador cerebral profundo*
4. ¿Tiene periodos off que no sabe prever, movimientos involuntarios fuertes o calambres dolorosos cuando está en off? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
5. ¿Ve cosas que no están, o tiene conductas nuevas que no puede controlar (tomar medicación de más, juego, compras, comida)? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
6. ¿Se marea, ve borroso, nota las piernas flojas o le duele el cuello y los hombros al estar de pie, y se le pasa al sentarse o tumbarse? DERIVACIÓN
7. ¿Tose o se atraganta al comer o beber, o ha tenido infecciones respiratorias seguidas? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
8. ¿Se queda dormido de repente durante el día, sin poder evitarlo? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
9. Temblor, rigidez, lentitud, problemas de equilibrio o de la marcha, sin diagnóstico DERIVACIÓN *solo «Sospecha»*

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

Árbol de decisión — Lumbar

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Lumbar. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b. El porqué de cada paso, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. a028246f

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

Desvío desde el paso 1 si «SÍ»

1b ¿El dolor CENTRALIZA con movimientos repetidos (Método McKenzie/MDT)? 📝 R9

- SÍ → 3 Dolor Radicular Lumbar
- NO → 3 Dolor Radicular Lumbar

1c ¿Hay déficit de fuerza, sensibilidad o reflejos en la pierna (comparado con el lado sano)? 📝 R5

- SÍ → 5 Radiculopatía Lumbar (Déficit Neurológico)
- NO → sin hipótesis

SÍ

1 ¿El dolor baja por la pierna (unilateral) y es peor que el dolor de espalda? 📝 R1, R2, R4, R6

NO

2 ¿El paciente es mayor y el dolor mejora al sentarse o inclinarse hacia adelante? 📝 R6, R7, R8

SÍ SLR positivo <60° o Test de Slump positivo	→	→ desvío 1b
NO Sin irradiación predominante a la pierna	→	sin hipótesis

SÍ Dolor bilateral en glúteos/muslos, alivio con "signo del carrito de compras"	→	4 Estenosis Espinal / Claudicación Neurogénica
NO Sin este patrón	→	sin hipótesis
VASCULAR Los síntomas al caminar ceden con solo pararse de pie, sin sentarse ni flexionar: sospecha de claudicación vascular → derivación médica	→	**Derivación médica** Sospecha de claudicación vascular (los síntomas al caminar ceden con solo pararse de pie): derivación médica para valorar la circulación de las piernas.

Todas → sigue en el paso 3 ↓

↓ Paso 3: viene del paso 2

3 ¿Cómo es el patrón de dolor lumbar predominante? 📝 G1, G3, G4

todas

4 ¿Qué patrón encaja mejor? (Revisar siempre cadera y factores contribuyentes.) 📝 R3, R6, R9, R10, R11, R12

Agudo/Rigidez Síntomas <16 días, sin dolor bajo la rodilla y restricción segmentaria hipomóvil	→	1 Disfunción Segmentaria Lumbosacra (Déficit de Movilidad)
Persistente/Inestabilidad Dolor en rangos finales o posturas sostenidas con sensación de "fallo"	→	2 Inestabilidad Espinal Lumbar (Déficit de Coordinación)
Ninguno de los dos Continuar con el patrón de dolor inespecífico	→	sin hipótesis

DISCOGÉNICO Dolor en línea media + preferencia direccional o centralización con movimientos repetidos; puede cambiar de lado	→	6 Dolor Lumbar Discogénico
FACETARIO Paramedial unilateral, dolor en extensión o extensión + rotación, sin pasar de la rodilla; los repetidos no alivian	→	7 Dolor Lumbar Facetario
SACROILÍACA Dolor en zona de Fortin sin dolor en Tuber, no centraliza	→	8 Dolor de la Articulación Sacroilíaca
MIOFASCIAL Banda tensa palpable + punto hipersensible + el paciente reconoce el dolor provocado	→	9 Síndrome de Dolor Miofascial Lumbar
NINGUNO Sin patrón predominante	→	sin hipótesis

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor lumbar inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

Confirmación de hipótesis · Lumbar

PhysiQ-Assessment · fase 4b. Los tests de cada hipótesis, sus LR y si puntúan. El criterio de cada test, por qué se hace, sus fuentes, «Ampliar con IA» y una calculadora que puntúa cada hipótesis con los tests que marques, en la guía de consulta (QR).

Porqués, IA y calculadora
v. 53e2dc69

1 Disfunción Segmentaria Lumbosacra (Déficit de Movilidad)

Test	LR+	LR−	Papel
Regla de Predicción Clínica de Flynn (4/5 criterios)	24	—	pronóstico
Evaluación de hipomovilidad segmentaria lumbar (PAIVM, movimientos intervertebrales accesorios pasivos)	—	—	hallazgo

2 Inestabilidad Espinal Lumbar (Déficit de Coordinación)

Test	LR+	LR−	Papel
Flexión lumbar ≥ 53° o ausencia de hipomovilidad en la exploración segmentaria	**4.3**	**0.22**	**puntúa**
Test de inestabilidad en prono	≈1.4	≈0.68	hallazgo
Movimientos aberrantes en la flexo-extensión	—	—	hallazgo

3 Dolor Radicular Lumbar

Test	LR+	LR−	Papel
Test de Elevación de Pierna Recta (SLR) ipsilateral	1.3	**0.30**	**puntúa**
SLR Contralateral (Lasègue cruzado)	**2.1**	0.86	**puntúa**
Test de Slump	—	—	hallazgo
Criterios RAPIDH (5 criterios)	—	—	hallazgo

4 Estenosis Espinal / Claudicación Neurogénica

Test	LR+	LR−	Papel
🧩 **Cluster de Cook (anamnesis y observación)**: ≥4 de 5 positivos → LR+ 4.6 · ninguno de 5 positivos (todos hechos) → LR− 0.19			
Síntomas bilaterales			en clúster
Dolor de pierna mayor que el dolor lumbar			en clúster
Dolor al caminar o estar de pie			en clúster
Alivio al sentarse			en clúster
Edad > 48 años			en clúster
Marcha con base amplia	**13**	—	**puntúa**
Romberg alterado	**4.1**	0.68	**puntúa**
Déficits sensoriales (L3-S1)	—	—	hallazgo
Test de extensión lumbar de 30 s	≈1.6	≈0.71	hallazgo

5 Radiculopatía Lumbar (Déficit Neurológico)

Test	LR+	LR−	Papel
Fuerza por miotomas L1–S2	—	—	hallazgo
Reflejos rotuliano (L3–L4) y aquíleo (L5–S1)	1.3	≈0.91	hallazgo
Sensibilidad (algodón, diapasón, pinchazo)	1.1	≈1.0	hallazgo

6 Dolor Lumbar Discogénico

Test	LR+	LR−	Papel
Centralización con movimientos repetidos	**3.1**	0.66	**puntúa**
Preferencia direccional	—	—	hallazgo
Observación: espalda plana o shift lateral	—	—	hallazgo

7 Dolor Lumbar Facetario

Test	LR+	LR−	Papel
Dolor en extensión, inclinación o rotación hacia el lado del dolor	1.2	—	hallazgo
PA (posteroanterior) unilateral dolorosa o con menos movilidad	—	—	hallazgo
Sin signos radiculares y sin alivio con repetidos	—	—	hallazgo

8 Dolor de la Articulación Sacroilíaca

Test	LR+	LR−	Papel
🧩 **Tests de provocación SI (3 de 5)**: ≥3 de 5 positivos → LR+ 2.1 · ≤2 de 5 positivos (todos hechos) → LR− 0.33			
Distracción			en clúster
Thrust de muslo			en clúster
Compresión			en clúster
Thrust sacro			en clúster
No centraliza con movimientos repetidos	—	—	hallazgo
Gaenslen			en clúster
Ausencia de dolor lumbar en la línea media	**2.4**	—	**puntúa**

9 Síndrome de Dolor Miofascial Lumbar

Test	LR+	LR−	Papel
Banda tensa palpable	—	—	hallazgo
Punto hipersensible dentro de la banda	—	—	hallazgo
El paciente reconoce el dolor provocado	—	—	hallazgo

LR en **verde**: multiplica la puntuación (LR+ ≥ 2 o LR− ≤ 0,5); en gris: no informativa, cuenta como hallazgo. «≈» = calculada de S y E. **puntúa**: puede mover la puntuación · hallazgo: sin LR aplicable · en clúster: solo cuenta con su clúster 🧩 · pronóstico: no entra en la puntuación. Criterio completo de cada test, fuentes y calculadora de la puntuación, en la guía (QR).

PhysiQ-Assessment · fase 4b · Lumbar. Generado desde los datos de la app el 3/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

Cribado sistémico · Cadera

PhysiQ-Assessment · fase 2. Lo que se pregunta siempre en cadera. Las condiciones especiales, en la página siguiente. El porqué de cada pregunta, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. 4d0aa1b6

DERIVACIÓN URGENTE · FRACTURA DE ESTRÉS DEL CUELLO FEMORAL
· Puede completarse y comprometer la vascularización de la cabeza femoral. Dolor inguinal vago e insidioso que empeora con la actividad; a menudo el único hallazgo es dolor al final del rango, sobre todo en RI. Dolor profundo nocturno o en carga.
· Perfil: corredor de fondo, militar o deportista de alta intensidad; poca forma al empezar, cambio de superficie o calzado; mujer con tríada de la deportista; corticoides prolongados.
· Percusión rotuliano-púbica (estudiada en fractura de cadera o pelvis tras traumatismo, no en la de estrés; S 85 %, E 70 %, LR+ 2,9, LR− 0,2): supino, fonendoscopio sobre el tubérculo púbico homolateral y percusión de la rótula; positivo si el sonido llega disminuido en el lado doloroso. Talón: golpe con el borde cubital del puño; positivo si reproduce el dolor con la carga axial.
· Una radiografía negativa NO descarta, sobre todo en las primeras semanas. · Adenopatía inguinal sin foco séptico: considerar malignidad. · Sospecha de torsión testicular o de artritis séptica: urgencias hoy.

Cáncer / Oncológico

1. ¿Tiene antecedentes de cáncer de cualquier tipo (especialmente próstata, mama, pulmón, riñón)?
2. ¿El dolor en cadera/muslo es constante, nocturno e intenso, sin posición que lo alivie?
3. ¿Ha notado pérdida de peso rápida e inexplicada, o ha descubierto algún bulto nuevo?
4. ¿Ha notado un ganglio o bulto en la ingle sin una herida, infección o rozadura en esa pierna que lo explique?

Vascular

1. ¿El dolor aparece tras 5-10 minutos de caminar y se alivia casi de inmediato al detenerse (claudicación vascular)?
2. **¿Nota hinchazón, enrojecimiento y calor en la pantorrilla o en toda la pierna, o experimenta calambres nocturnos frecuentes?** URGENCIA
3. ¿Experimenta dolor isquémico en la pierna en reposo que mejora al colocarla colgando fuera de la cama?
4. **¿Ha empezado de golpe un dolor intenso en el abdomen, la espalda, la ingle o las nalgas, desgarrador, que no cambia al moverse, o con mareo o desmayo?** URGENCIA
5. **¿Se le ha puesto la pierna de repente fría, pálida, muy dolorosa, con hormigueo o debilidad, o le ha empeorado de golpe el dolor al caminar?** URGENCIA
6. **Si se ha desmayado alguna vez: ¿fue mientras hacía un esfuerzo, estando tumbado, justo después de notar de golpe el corazón muy rápido, o con dolor en el pecho o falta de aire nuevos? ¿O algún familiar suyo murió de forma súbita antes de los 40 años?** URGENCIA

Urogenital / Renal

1. ¿Ha notado sangre en la orina, ardor o dolor al orinar, o fiebre/escalofríos?
2. (Hombres) ¿Ha notado dolor testicular, secreciones inusuales o dificultad al orinar?
3. **(Hombres) ¿Ha empezado de golpe un dolor intenso en un testículo, con hinchazón, náuseas o vómitos?** URGENCIA
4. (Mujeres) ¿El dolor de ingle o pelvis se relaciona con la regla, con las relaciones sexuales, o tiene flujo o sangrado inusual?
5. (Mujeres) ¿Tiene desde hace meses un dolor sordo o de peso en la pelvis, la ingle o la cadera que empeora al estar mucho rato de pie o al final del día y mejora tumbada, y además tiene varices en la vulva, el periné, la cara interna o de detrás del muslo o la nalga, o un dolor que le dura horas después de las relaciones sexuales? DERIVACIÓN
6. **(Mujeres en edad fértil) ¿Tiene un dolor de ingle, pelvis o abdomen bajo, nuevo o intenso, junto con un retraso de la regla, un sangrado vaginal inesperado, o mareo o desmayo?** URGENCIA

Gastrointestinal

1. ¿El dolor en la ingle o cadera se acompaña de molestias, distensión abdominal o se alivia al defecar/pasar gases?
2. ¿Ha notado heces negras/alquitranadas, sangre en las heces o dificultad para limpiarse?
3. ¿Nota un bulto en la ingle, con sensación de peso o de que algo tira, que aumenta al toser o al hacer fuerza?

Óseo / Desarrollo

1. **¿Hace deporte de resistencia o de alta intensidad (o es militar), y el dolor de ingle empezó poco a poco, empeora al cargar peso o al hacer actividad y le duele también de noche?** URGENCIA
2. ¿Toma o ha tomado corticoides durante mucho tiempo, bebe alcohol a diario, o tiene lupus u otra enfermedad del tejido conectivo?
3. (Menores de 18 años) ¿Cojea, o el dolor empezó durante el estirón o tras un tirón brusco al chutar, esprintar o saltar?
4. ¿De niño o adolescente tuvo algún problema en las caderas (displasia, Perthes, epifisiolisis)?

Inflamatoria / Infecciosa

1. **¿Tiene fiebre o se encuentra mal en general, con la cadera muy dolorosa o hinchada, hasta el punto de no poder apoyar la pierna?** URGENCIA
2. ¿Le duelen o se le hinchan otras articulaciones, o tiene diagnóstico de artritis reumatoide o espondilitis anquilosante?
3. ¿Le han operado de la cadera o la ingle (prótesis, artroscopia, hernia) o le han infiltrado la cadera, y el dolor es nuevo, no cede en reposo o ha tenido una infección reciente?

Endocrino / Metabólico

1. ¿Siente fatiga inusual o debilidad muscular, especialmente al subir escaleras o levantarse de una silla?
2. ¿Ha notado aumento anormal de sed, apetito o frecuencia urinaria (incluso despertándose por la noche)?
3. ¿Ha experimentado cambios recientes en su peso o tolerancia a la temperatura (mucho frío o calor cuando otros no)?
4. ¿Nota que sus heridas sanan muy lentamente o le aparecen moretones con excesiva facilidad?
5. (Si tiene diabetes) ¿Suele tener episodios de bajadas de azúcar, o siente ardor, entumecimiento o pérdida de sensibilidad en manos y pies?

Hematológico

1. ¿Sangra o se le forman moretones fácilmente después de un traumatismo menor, cirugía o procedimiento dental?
2. ¿Experimenta falta de aire, palpitaciones o dolor en el pecho con esfuerzos leves (subir escaleras) o en reposo?
3. ¿Padece infecciones recurrentes o fiebre baja frecuente (resfriados, gripe, infecciones respiratorias)?
4. **¿Está recibiendo tratamiento contra el cáncer (quimioterapia o radioterapia) y se encuentra mal o tiene fiebre?** URGENCIA
5. **(Si tiene hemofilia u otro trastorno hereditario de la coagulación) ¿Tiene un dolor nuevo en una articulación o un músculo, con hormigueo o tirantez, hinchazón, calor o dificultad para moverla?** URGENCIA
6. ¿Ha notado heces negras/alquitranadas, sangre en orina, o ha tosido o vomitado sangre?

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Condiciones especiales · Cadera

Solo se preguntan si el paciente tiene la condición (en la app, su tarjeta de la fase 1 marcada, o el mecanismo «Post-quirúrgico»). La escala de Beighton, la sospecha del subtipo vascular, la prueba de bipedestación, la regla de la tensión en el embarazo y la tensión tumbado y de pie del Parkinson se calculan en la guía (QR).

🏥 Posquirúrgico

Solo con mecanismo «Post-quirúrgico» en la fase 1

1. **¿Desde la operación, la herida está más roja, caliente, hinchada o dolorosa, supura o se ha abierto, o ha tenido fiebre, escalofríos o malestar general?** URGENCIA
2. **¿Desde la operación tiene una pantorrilla o una pierna hinchada, caliente o dolorosa? (Posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.)** URGENCIA
3. **¿Le falta el aire de repente, le duele el pecho al respirar, ha tosido sangre o se ha mareado o desmayado?** URGENCIA
4. ¿Tiene un dolor continuo y desproporcionado para la operación, con cambios de color, temperatura, sudoración o hinchazón en la zona, o le duele incluso el roce de la ropa?
5. **¿Desde la operación nota un dolor quemante, hormigueo, adormecimiento o pérdida de fuerza nuevos en la zona de un nervio (por ejemplo, en la mano o el pie del lado operado)?** URGENCIA

🧬 Hipermovilidad

Solo con tarjeta «Hipermovilidad / Ehlers-Danlos» marcada

1. **¿Ha tenido de forma brusca un dolor intenso, que va a más, en el abdomen, el flanco, la espalda, el pecho o un brazo o una pierna?** URGENCIA
   con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida
2. **¿Ha notado de repente un zumbido en la sien, con el ojo rojo, dolorido o más saltón?** URGENCIA
   con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida
3. **¿Le ha faltado el aire de forma brusca, o le duele el pecho al respirar?** URGENCIA
   con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida
4. ¿Algún familiar de primer grado con SED vascular, o con una rotura o disección arterial antes de los 40 años?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
5. ¿Ha tenido una rotura arterial o una rotura de intestino sin causa conocida?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
6. ¿Ha tenido algún neumotórax espontáneo?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
7. ¿Le salen hematomas sin golpes, en sitios poco habituales (mejillas, espalda), o tiene la piel fina y translúcida, con las venas muy visibles?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
8. ¿Tuvo varices antes de los 30 años (y, si es mujer, sin haber estado embarazada)?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)

🫀 Disautonomía

Solo con tarjeta «Disautonomía / POTS» marcada

1. **¿Se ha desmayado alguna vez mientras hacía un esfuerzo (no justo al pararlo)?** URGENCIA
2. **¿Se ha desmayado estando tumbado, o justo después de notar de golpe el corazón muy rápido?** URGENCIA
3. **Si se ha desmayado: ¿tenía a la vez dolor en el pecho o falta de aire nuevos, o le han dicho que tiene un soplo, insuficiencia cardiaca u otra enfermedad del corazón?** URGENCIA
4. **Si se ha desmayado: ¿algún familiar murió de forma súbita antes de los 40 años, o tiene una enfermedad del corazón hereditaria?** URGENCIA
5. ¿Le dan episodios en que el corazón se le dispara de golpe y se le para también de golpe, aunque esté sentado o tumbado, sin llegar a desmayarse? DERIVACIÓN

🦋 Lupus

Solo con tarjeta «Lupus (LES)» marcada · solo «Diagnosticado»

1. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o se encuentra mal en general de una forma nueva? (Con corticoides o inmunosupresores puede haber una infección sin fiebre.)** URGENCIA
2. **¿Tiene una pantorrilla o una pierna (o un brazo) hinchada, caliente o dolorosa de forma nueva? (Posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.)** URGENCIA
3. **¿Le ha faltado el aire de repente o le duele el pecho al respirar? ¿O ha tenido de golpe debilidad o adormecimiento de un lado, dificultad para hablar o pérdida de visión, aunque se le haya pasado?** URGENCIA
4. **¿Tiene un dolor en el pecho punzante que empeora al respirar hondo y mejora inclinándose hacia delante?** URGENCIA
5. **¿Tiene en algún dedo de la mano o del pie una herida o úlcera en la yema, o un dedo que se queda blanco o morado y no recupera el color?** URGENCIA
6. **¿Ha tenido una convulsión o confusión nueva; debilidad u hormigueo en las dos piernas que va a más, con cambios al orinar; de golpe, el pie o la mano caídos; o pérdida de visión?** URGENCIA
7. ¿Tiene un dolor profundo y persistente en la ingle, la rodilla, el hombro o el tobillo, que empeora al cargar o al andar y no se explica por un golpe? DERIVACIÓN
8. ¿Le cuesta cada vez más levantarse de una silla, subir escaleras o levantar los brazos por encima de la cabeza? DERIVACIÓN
9. Desde la última vez que le vio su reumatólogo, ¿tiene articulaciones hinchadas nuevas, una erupción, llagas en la boca o más caída de pelo? DERIVACIÓN
10. ¿Se le hinchan las piernas o los tobillos de forma nueva, le han dicho que tiene la tensión alta desde hace poco, o en un análisis que tiene proteínas o sangre en la orina? DERIVACIÓN

💉 Trastorno mastocitario o anafilaxia

Solo con tarjeta «Trastorno mastocitario o anafilaxia» marcada

1. Desde su última revisión médica, ¿ha tenido episodios bruscos con ronchas, hinchazón, falta de aire, mareo o desmayo que su médico aún no conoce? DERIVACIÓN

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

🦴 Osteoporosis

Solo con tarjeta «Osteoporosis o fragilidad ósea» marcada

1. **¿Tiene un dolor de espalda nuevo con debilidad, hormigueo o torpeza en las piernas que va a más, o cambios al orinar o al hacer de vientre?** URGENCIA
2. ¿Le empezó de golpe un dolor de espalda, sobre todo en la zona dorsal, tras un esfuerzo pequeño (levantar algo agachado, toser, estornudar, resbalar), y no se le ha ido? DERIVACIÓN
3. ¿Ha perdido 4 cm o más de altura respecto a cuando era joven (o 2 cm desde la última vez que se la midieron), o se le ha curvado más la espalda? DERIVACIÓN *sin fractura vertebral conocida*
4. ¿Tiene un dolor de muslo, ingle o cadera sin explicación? DERIVACIÓN *con bifosfonato o denosumab*

🤰 Embarazo y posparto

Solo con tarjeta «Embarazo o posparto» marcada

1. **¿Tiene dolor de cabeza fuerte o que no se le pasa, ve borroso o destellos, dolor fuerte justo debajo de las costillas, vómitos, o se le han hinchado de golpe la cara, las manos o los pies?** URGENCIA *embarazo desde la semana 20 o posparto*
2. **¿Ha tenido un sangrado vaginal que no le han explicado?** URGENCIA *solo embarazo desde la semana 13*
3. **¿Nota que el bebé se mueve menos de lo habitual?** URGENCIA *solo embarazo desde la semana 24*
4. **¿Tiene contracciones regulares y dolorosas, o le sale líquido por la vagina?** URGENCIA *solo embarazo*
5. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o se encuentra muy mal?** URGENCIA *solo embarazo*
6. **¿Tiene un sangrado vaginal brusco o muy abundante, que va a más, o expulsa coágulos o restos? ¿O se le ha hinchado mucho el vientre?** URGENCIA *solo posparto*
7. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o dolor de vientre, pelvis o periné, o un flujo que huele mal?** URGENCIA *solo posparto hasta la semana 8 tras el parto*
8. **¿Tiene dolor e hinchazón nuevos en una pierna, sobre todo en una sola; o dolor de espalda o de nalga con toda la pierna hinchada; o le falta el aire de forma nueva, le duele el pecho o ha tosido sangre?** URGENCIA
9. **¿Tiene dolor en el pecho, palpitaciones, o le falta el aire en reposo o al tumbarse?** URGENCIA
10. **¿Se le ha abierto la herida del periné o la de la cesárea, o tiene más dolor, rojez o supuración en ella?** URGENCIA *solo posparto*
11. **¿Desde el parto se le escapa la orina o las heces de forma continua, sin poder controlarlo nada?** URGENCIA *solo posparto*
12. **(Si hace falta, al acompañante) ¿Ha notado cambios bruscos desde el parto: confusión, ideas extrañas, euforia o mucha agitación?** URGENCIA *solo posparto*
13. **¿Ha pensado en hacerse daño o en quitarse la vida?** URGENCIA
14. ¿Tiene un dolor de espalda intenso y que no se le pasa, dorsal o lumbar, en el embarazo o desde el parto, o ha perdido 3 cm o más de altura? DERIVACIÓN
15. ¿Desde el parto tiene un dolor intenso o que empezó de golpe en la sacroilíaca, la nalga, la zona lumbar o el pubis, le cuesta apoyar o cojea, o se le alivia tumbada? DERIVACIÓN *solo posparto hasta la semana 2 tras el parto*
16. ¿Tiene un pecho rojo e hinchado desde hace más de 24 horas, aunque se lo haya tratado? DERIVACIÓN *solo posparto*

🩸 Anticoagulado o antiagregado

Solo con tarjeta «Paciente anticoagulado o antiagregado» marcada

1. **¿Se ha dado un golpe en la cabeza en los últimos días, aunque pareciera leve?** URGENCIA *no con aspirina sola*
2. **Desde un golpe en la cabeza (de hace días o semanas), ¿tiene un dolor de cabeza fuerte o que va a más, vómitos repetidos, somnolencia, confusión o cambios de conducta, o debilidad, dificultad para hablar o cambios de visión nuevos?** URGENCIA
3. **¿Le ha empezado de golpe un dolor fuerte de cuello o de espalda con debilidad, hormigueo o adormecimiento en brazos o piernas, o cambios al orinar o al hacer de vientre? (Puede empezar por la debilidad, sin dolor fuerte.)** URGENCIA
4. **¿Le ha empezado un dolor fuerte en la ingle, la cadera, el costado o la zona lumbar baja, con el muslo débil o adormecido, o con mareo, palidez o sudor frío? (Con un golpe pequeño o sin golpe.)** URGENCIA *solo con anticoagulante*
5. **¿Le ha salido de golpe, tras toser, un esfuerzo o una inyección de heparina, un dolor fuerte en la pared de la barriga con un bulto, que empeora al moverse o al tensar el abdomen?** URGENCIA *solo con anticoagulante*
6. **¿Tiene un brazo, un antebrazo, una mano, un muslo o una pierna muy hinchados y tensos, con un dolor desproporcionado que va a más y que empeora al estirarle pasivamente los dedos de la mano o del pie? (Tras un golpe pequeño, un esfuerzo o sin causa.)** URGENCIA
7. ¿Tiene un hematoma grande o que va a más, un bulto nuevo en un músculo, o una articulación hinchada tras un golpe pequeño o sin golpe? DERIVACIÓN

🧠 Parkinson

Solo con tarjeta «Parkinson» marcada

1. **En los últimos días, ¿está mucho más rígido o inmóvil que de costumbre y además tiene fiebre, está confuso, suda mucho o le cuesta tragar?** URGENCIA *solo «Diagnosticado»*
2. ¿Ha dejado de tomar su medicación del Parkinson, o no puede tomarla o retenerla (vómitos, diarrea, no puede tragar, una cirugía)? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
3. ¿Han vuelto de golpe el temblor, la rigidez o la lentitud, o tiene movimientos involuntarios fuertes o cambios de conducta nuevos? DERIVACIÓN *con estimulador cerebral profundo*
4. ¿Tiene periodos off que no sabe prever, movimientos involuntarios fuertes o calambres dolorosos cuando está en off? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
5. ¿Ve cosas que no están, o tiene conductas nuevas que no puede controlar (tomar medicación de más, juego, compras, comida)? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
6. ¿Se marea, ve borroso, nota las piernas flojas o le duele el cuello y los hombros al estar de pie, y se le pasa al sentarse o tumbarse? DERIVACIÓN
7. ¿Tose o se atraganta al comer o beber, o ha tenido infecciones respiratorias seguidas? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
8. ¿Se queda dormido de repente durante el día, sin poder evitarlo? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
9. Temblor, rigidez, lentitud, problemas de equilibrio o de la marcha, sin diagnóstico DERIVACIÓN *solo «Sospecha»*

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

Árbol de decisión — Cadera

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Cadera. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b. El porqué de cada paso, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. b835303d

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

1 ¿El dolor podría ser referido desde la columna lumbar o la articulación sacroilíaca?

SÍ
SACROILÍACA: señala con el dedo el dolor inferomedial a la EIPS (no solo en la línea media ni por encima de L5) y 3 o más de 5 tests de provocación positivos
→ 10 Dolor Articular Sacroilíaco

SÍ
LUMBAR: el dolor cambia con movimientos repetidos de la espalda, o la elevación de la pierna recta o el slump reproducen su dolor
→ sin hipótesis

NO
Origen coxofemoral: la cojera (unas 7 veces) y la rotación interna limitada (unas 14 veces) orientan más a la cadera que a la columna
→ sin hipótesis

todas

1b ¿Hay un evento desencadenante concreto y reciente (chut, sprint, cambio de dirección, estiramiento)?

📝 G2, G3 · R7

SÍ
LESIÓN AGUDA: palpar primero; luego resistencia y estiramiento
→ 11 Lesión Aguda de Ingle

NO
Sin evento desencadenante concreto
→ sin hipótesis

Todas → sigue en el paso 2 ↓

↓ Paso 2: viene del paso 1b

2 ¿El perfil es degenerativo (edad ≥45 años, rigidez matutina breve)?

📝 R1, R2

SÍ
Edad ≥45 años, rigidez matutina <1 hora, rotación interna <24°
→ 1 Artrosis de Cadera

NO
Paciente joven/activo con síntomas mecánicos
→ sin hipótesis

todas

3 ¿Sospecha de origen intraarticular: dolor inguinal ligado al movimiento con FADDIR o flexión-RI positivos? Estos tests descartan; positivos no confirman.

📝 R1, R2

SÍ
Compatible con pinzamiento femoroacetabular (SIFA), sin confirmar: seguir con Thomas
→ 2 Síndrome de Pinzamiento Femoroacetabular (SIFA)
→ desvío 3b

SÍ, con chasquido doloroso, bloqueo o fallo
Posible desgarro labral
→ 2 Síndrome de Pinzamiento Femoroacetabular (SIFA)
→ 3 Desgarro del Labrum Acetabular
→ desvío 3b

NO
FADDIR y flexión-RI negativos: origen intraarticular improbable
→ sin hipótesis

NO EXPLORADO
FADDIR y flexión-RI no realizados (contraindicados o no tolerados): origen intraarticular sin valorar
→ sin hipótesis

NO / NO EXPLORADO → sigue en el paso 4, en la página siguiente →

Desvío desde el paso 3 si «SÍ» o «SÍ, con chasquido doloroso, bloqueo o fallo»

SÍ / SÍ, con chasquido doloroso, bloqueo o fallo

3b ¿Thomas positivo con historia compatible (signo de la «C», síntomas mecánicos)? Identificar la entidad; pueden coexistir.

📝 G8 · R1, R2, R3

INESTABILIDAD / LIGAMENTO REDONDO → 12 Ligamento Redondo e Inestabilidad

CONDROPATÍA → 13 Condropatía de Cadera

ARTROSIS → 1 Artrosis de Cadera

FAIS / LABRUM → sin hipótesis

NO CONCLUYENTE → sin hipótesis

→ sigue en el paso 4

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor de cadera inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

↓ Paso 4: viene del paso 3 o del 3b

4 ¿El dolor se localiza en la CARA EXTERNA de la cadera (trocánter mayor)? 📝 R1

SÍ Sensibilidad en trocánter mayor y dolor en apoyo monopodal <30s	→ 4 Síndrome de Dolor Trocantérico Mayor (Tendinopatía Glútea)
SÍ Con marcha de Trendelenburg o debilidad medida en abductores	→ 5 Debilidad de Abductores de Cadera
SÍ Calidad deficiente en sentadilla monopodal o step-down	→ 6 Disfunción de Control Neuromuscular de Cadera
NO Sin dolor lateral	→ sin hipótesis

todas →

5 ¿El dolor se localiza en el GLÚTEO o zona isquiática?

Dolor profundo en glúteo que empeora al sentarse (ciática) posible Síndrome Piriforme	→ 7 Síndrome Glúteo Profundo (Síndrome Piriforme)
Dolor que empeora con zancada larga al caminar posible Pinzamiento Isquiofemoral	→ 8 Pinzamiento Isquiofemoral
Sensibilidad sobre tuberosidad isquiática posible Tendinopatía Proximal Isquiotibiales	→ 9 Tendinopatía Proximal de Isquiotibiales
Sin localización clara posterior	→ sin hipótesis

Todas → sigue en el paso 6 ↓

↓ Paso 6: viene del paso 5

6 ¿Qué reproduce su dolor conocido en la INGLE? Palpar primero y con precisión: las estructuras se solapan.

📝 R1, R4, R5, R6, R8

ADUCTOR Palpación dolorosa de aductores + squeeze doloroso	→ 16 Dolor Inguinal Relacionado con el Aductor
PSOAS ILÍACO Palpación dolorosa supra o infrainguinal	→ 17 Dolor Inguinal Relacionado con el Psoas Ilíaco
INGUINAL Palpación dolorosa del canal sin hernia palpable (de pie y con tos)	→ 18 Dolor Inguinal Relacionado con el Canal Inguinal
PÚBICO Palpación dolorosa de la sínfisis y el hueso adyacente	→ 19 Dolor Inguinal Relacionado con el Pubis
NINGUNO Sin dolor inguinal o nada lo reproduce	→ sin hipótesis

todas →

7 ¿Hay un patrón neuropático, o nada encaja y el dolor es extenso? 📝 R2

MERALGIA Tinel bajo la EIAS, parestesias anterolaterales del muslo	→ 14 Neuropatías de Cadera e Ingle
OBTURADOR Dolor en ingle y muslo medial con el ejercicio	→ 14 Neuropatías de Cadera e Ingle
ILIOINGUINAL, ILIOHIPOGÁSTRICO O GENITOFEMORAL Arch and twist de pie	→ 14 Neuropatías de Cadera e Ingle
PUDENDO Dolor perineal al sentarse o en bici, sin déficit sensitivo objetivo	→ 14 Neuropatías de Cadera e Ingle
SENSIBILIZACIÓN CENTRAL Nada encaja o dolor extenso (revisar banderas rojas)	→ 15 Sensibilización Central
NINGUNO Sin patrón neuropático ni dolor extenso	→ sin hipótesis

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor de cadera inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Confirmación de hipótesis · Cadera

PhysiQ-Assessment · fase 4b. Los tests de cada hipótesis, sus LR y si puntúan. El criterio de cada test, por qué se hace, sus fuentes, «Ampliar con IA» y una calculadora que puntúa cada hipótesis con los tests que marques, en la guía de consulta (QR).

Porqués, IA y calculadora
v. 868c847b

1 Artrosis de Cadera

Test	LR+	LR−	Papel
Criterio clínico combinado: Edad ≥45 + dolor en actividad + rigidez <1h	—	—	hallazgo
Aducción de cadera disminuida	**4.2**	**0.25**	**puntúa**
Rotación Interna disminuida (<24°)	**3.2**	**0.43**	**puntúa**
Dolor posterior con sentadilla profunda	**6.1**	0.79	**puntúa**
Debilidad de abductores	**4.5**	0.62	**puntúa**
Criterios clínicos ACR (árbol de clasificación)	—	—	hallazgo
Apoyo monopodal (30 s)	1.8	0.82	hallazgo

2 Síndrome de Pinzamiento Femoroacetabular (SIFA)

Test	LR+	LR−	Papel
Test FADDIR (Flexión-Aducción-Rotación Interna)	≈1.1	≈0.83	hallazgo
Test FABER (Flexión-Abducción-Rotación Externa)	—	—	hallazgo
Rotación Interna de cadera en posición neutra <24°	**≈4.8**	≈0.76	**puntúa**
Dolor inguinal	—	—	hallazgo
Test de flexión-rotación interna	1.3	—	hallazgo
Test de Thomas	—	—	hallazgo

3 Desgarro del Labrum Acetabular

Test	LR+	LR−	Papel
Test de Arlington	—	—	hallazgo
Test de Torsión/Twist	—	—	hallazgo
Combinación FADDIR + FABER + Elevación pierna recta resistida	—	—	hallazgo
Chasquido doloroso	—	—	hallazgo
Test de flexión-rotación interna	1.3	—	hallazgo
FADDIR (valor agrupado)	—	—	hallazgo
Test de Thomas	—	—	hallazgo
Longitud de paso	—	—	hallazgo

4 Síndrome de Dolor Trocantérico Mayor (Tendinopatía Glútea)

Test	LR+	LR−	Papel
Palpación del trocánter mayor / tendón glúteo	**2.4**	**0.25**	**puntúa**
Apoyo Monopodal <30 segundos (Single-Leg Stance)	—	0.62	hallazgo
Test de Abducción Resistida de Cadera	**6.1**	**0.45**	**puntúa**
Marcha de Trendelenburg	—	—	hallazgo
Derotación externa resistida	—	—	hallazgo

5 Debilidad de Abductores de Cadera

Test	LR+	LR−	Papel
Test de Trendelenburg	—	—	hallazgo
Dinamometría manual (HHD) de abductores	—	—	hallazgo
Test de paso lateral + marcha en tándem combinados	—	—	hallazgo

6 Disfunción de Control Neuromuscular de Cadera

Test	LR+	LR−	Papel
Test de Sentadilla Monopodal (Single-Leg Squat)	—	—	hallazgo
Test de Step-Down	—	—	hallazgo
Marcha de Trendelenburg (observación)	—	—	hallazgo

7 Síndrome Glúteo Profundo (Síndrome Piriforme)

Test	LR+	LR−	Papel
Test de estiramiento del piriforme en sedestación	—	—	hallazgo
Dolor con sedestación prolongada (>20 min)	—	—	hallazgo

8 Pinzamiento Isquiofemoral

Test	LR+	LR−	Papel
Test de marcha con zancada larga (Long-Stride Walking Test)	—	—	hallazgo

9 Tendinopatía Proximal de Isquiotibiales

Test	LR+	LR−	Papel
Sensibilidad a la palpación sobre tuberosidad isquiática	—	—	hallazgo
Dolor con test de fuerza de isquiotibiales	—	—	hallazgo

10 Dolor Articular Sacroilíaco

Test	LR+	LR−	Papel
Test de Compresión Pélvica	—	—	hallazgo
Test de Patrick (FABER)	—	—	hallazgo
Dolor no limitado a la línea media ni por encima de L5	—	—	hallazgo
Cluster de Laslett: 3 o más de 5 tests de provocación positivos	**2.1**	**0.33**	**puntúa**
Thigh thrust	—	—	hallazgo
Prueba del dedo (Fortin)	—	—	hallazgo

11 Lesión Aguda de Ingle

Test	LR+	LR−	Papel
Palpación del grupo sospechoso (primero)	—	—	hallazgo
Resistencia del grupo sospechoso	—	—	hallazgo
Estiramiento del grupo sospechoso	—	—	hallazgo

12 Ligamento Redondo e Inestabilidad

Test	LR+	LR−	Papel
Log roll	—	—	hallazgo
Movilidad aumentada	—	—	hallazgo
Episodio de fallo	—	—	hallazgo

13 Condropatía de Cadera

Test	LR+	LR−	Papel
Cribado intraarticular y Thomas positivos	—	—	hallazgo
Dolor en reposo y nocturno con síntomas mecánicos	—	—	hallazgo
Rigidez	—	—	hallazgo
IMC >25	—	—	hallazgo

14 Neuropatías de Cadera e Ingle

Test	LR+	LR−	Papel
Tinel del femorocutáneo (meralgia)	—	—	hallazgo
Neurodinámico del femorocutáneo	—	—	hallazgo
Obturador: neurodinámico, sensibilidad del muslo medial y fuerza de aductores	—	—	hallazgo
Arch and twist de pie	—	—	hallazgo
Pudendo: dolor perineal al sentarse o en bici	—	—	hallazgo

15 Sensibilización Central

Test	LR+	LR−	Papel
Dolor multifocal, referido y extenso	—	—	hallazgo
Dolor en las AVD	—	—	hallazgo
Fatiga y mal sueño	—	—	hallazgo
Dificultades de memoria	—	—	hallazgo
Más comorbilidad; intolerancia al estrés, ansiedad o depresión	—	—	hallazgo

16 Dolor Inguinal Relacionado con el Aductor

Test	LR+	LR−	Papel
Palpación dolorosa de aductores + squeeze doloroso	—	—	hallazgo
Estiramiento pasivo de aductores	—	—	hallazgo

17 Dolor Inguinal Relacionado con el Psoas Ilíaco

Test	LR+	LR−	Papel
Palpación dolorosa supra o infrainguinal	—	—	hallazgo
Flexión resistida con cadera y rodilla a 90°	—	—	hallazgo
Flexión resistida o extensión pasiva en Thomas modificado	—	—	hallazgo

18 Dolor Inguinal Relacionado con el Canal Inguinal

Test	LR+	LR−	Papel
Dolor en la región del canal + palpación dolorosa del canal, sin hernia palpable	—	—	hallazgo
Sit-up recto u oblicuo resistido	—	—	hallazgo
Valsalva, tos o estornudo	—	—	hallazgo
Flexión resistida en Thomas modificado	—	—	hallazgo

19 Dolor Inguinal Relacionado con el Pubis

Test	LR+	LR−	Papel
Palpación dolorosa de la sínfisis y el hueso adyacente	—	—	hallazgo
Resistencia abdominal y squeeze	—	—	hallazgo

LR en **verde**: multiplica la puntuación (LR+ ≥ 2 o LR− ≤ 0,5); en gris: no informativa, cuenta como hallazgo. «≈» = calculada de S y E. **puntúa**: puede mover la puntuación · hallazgo: sin LR aplicable · en clúster: solo cuenta con su clúster 🧩 · pronóstico: no entra en la puntuación. Criterio completo de cada test, fuentes y calculadora de la puntuación, en la guía (QR).

PhysiQ-Assessment · fase 4b · Cadera. Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

Cribado sistémico · Rodilla

PhysiQ-Assessment · fase 2. Lo que se pregunta siempre en rodilla. Las condiciones especiales, en la página siguiente. El porqué de cada pregunta, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. c26ecbfc

URGENCIAS · TVP · ARTRITIS SÉPTICA · APARATO EXTENSOR · BURSA CON FIEBRE · NEUROVASCULAR

· TVP: no identificarla puede llevar a embolia pulmonar, que ocurre en más de un tercio de los casos. Dolor intenso e inexplicado, calambre en el hueco poplíteo, calor o hinchazón. Derivar a quien pueda excluirla.

· ARTRITIS SÉPTICA: rodilla caliente, roja y con derrame a tensión. Dolor intenso en todo el arco, incluso en recorridos mínimos. Fiebre, malestar general, incapacidad para cargar. Factores: infiltración o cirugía articular reciente, prótesis, inmunodepresión, diabetes, AR, infección cutánea, drogas parenterales. Puede coexistir con artrosis o gota y despistar. Ningún signo aislado es bastante sensible para descartarla → URGENCIA HOSPITALARIA HOY.

· ROTURA DEL APARATO EXTENSOR: la regla de Ottawa NO lo detecta. Carga excéntrica brusca sobre la rodilla flexionada o caída, con chasquido y caída inmediata. NO puede elevar la pierna extendida ni mantener la rodilla extendida contra gravedad. Escalón palpable por encima de la rótula (cuádriceps) o por debajo (rotuliano); hemartrosis; rótula alta o baja. La elevación de la pierna extendida es prueba aparte y obligatoria en toda rodilla traumática con dolor anterior. Reparación precoz (2 primeras semanas) → mejores resultados.

· Bursitis prerrotuliana séptica: la FIEBRE >37,7 °C solo se ha descrito en la séptica. Derivación el mismo día. · Compromiso neurovascular tras traumatismo: cambios de temperatura, adormecimiento, parestesias o debilidad tras fractura de meseta o luxación → pulsos distales, cribado neurológico e índice tobillo-brazo.

· REGLA DE OTTAWA, antes de explorar cualquier rodilla con traumatismo agudo → radiografía si hay ALGUNO de los cinco, por separado: ≥55 años · dolor a la palpación de la cabeza del peroné · dolor aislado a la palpación de la rótula · no flexiona hasta 90° · no carga cuatro pasos, ni justo tras la lesión ni ahora, aunque sea cojeando. S 98–100 %, E ≈50 %: sirve para descartar, no para confirmar. Excluida si la lesión tiene más de 7 días.

🩸 Vascular

1. ¿El dolor aparece tras caminar unos minutos y cede casi de inmediato al parar (claudicación)?
2. **¿Tiene la pantorrilla o toda la pierna hinchada, caliente y más rojiza que la otra (posible TVP)?** URGENCIA
3. ¿Tiene un bulto detrás de la rodilla (quiste poplíteo) y además dolor o hinchazón en la pantorrilla? Clínicamente no se distingue de una tromboflebitis: derivar (ecografía).
4. **¿Se le ha puesto la pierna de repente fría, pálida, muy dolorosa, con hormigueo o debilidad, o le ha empeorado de golpe el dolor al caminar?** URGENCIA
5. **Si se ha desmayado alguna vez: ¿fue mientras hacía un esfuerzo, estando tumbado, justo después de notar de golpe el corazón muy rápido, o con dolor en el pecho o falta de aire nuevos? ¿O algún familiar suyo murió de forma súbita antes de los 40 años?** URGENCIA

🦠 Infecciosa / Inflamatoria

1. **¿Hay fiebre, enrojecimiento intenso y calor local junto con la tumefacción de la rodilla (artritis séptica)?** URGENCIA
2. ¿Ha tenido alguna infección reciente (urinaria, respiratoria, cutánea) antes de que apareciera el dolor articular?
3. **¿Tiene hinchada, caliente y roja la bolsa de delante de la rótula, y fiebre de más de 37,7 °C?** URGENCIA

🔬 Oncológico / Hematológico

1. ¿El dolor es constante, nocturno, intenso y no se alivia con ninguna posición ni reposo?
2. ¿Tiene antecedentes de cáncer o ha notado algún bulto en la zona de la rodilla o muslo?
3. ¿Ha tenido episodios de hinchazón articular después de un traumatismo menor?

🦴 Traumático / Mecánico

1. ¿Tras un golpe directo, una caída sobre la rodilla o un mal aterrizaje, se le hinchó enseguida y no puede cargar el peso sobre esa pierna? (Aplicar la regla de Ottawa en el árbol: radiografía si hay algún criterio.)
2. **¿Tras una caída o un frenazo con la rodilla doblada, notó un chasquido y ahora no puede levantar la pierna estirada ni mantener la rodilla estirada?** URGENCIA
3. **¿Fue un traumatismo de alta energía (accidente, golpe contra el salpicadero o en la parte delantera e interna de la rodilla, o la rodilla se le fue hacia atrás) con la rodilla muy hinchada de inmediato?** URGENCIA
4. **¿Desde el traumatismo nota el pie o la pierna más fríos o más calientes, dormidos, con hormigueo o con menos fuerza?** URGENCIA
5. ¿Arrastra la punta del pie o tropieza con ella, o tiene hormigueo o menos fuerza por fuera de la pierna y en el dorso del pie (nervio peroneo común)?
6. ¿La rodilla se le bloquea y no puede estirarla o doblarla, con mucho dolor, derrame y pérdida de movilidad (posible fragmento osteocondral inestable → imagen y derivación)?

🧒 Niño o Adolescente

1. ¿Es un niño o adolescente con dolor de rodilla sin ningún golpe ni gesto que lo explique? (Explorar primero la cadera: epifisiólisis, Perthes.)

⚗️ Endocrino / Metabólico

1. ¿Siente fatiga inusual o debilidad muscular, especialmente al subir escaleras o levantarse de una silla?
2. ¿Ha notado aumento anormal de sed, apetito o frecuencia urinaria (incluso despertándose por la noche)?
3. ¿Ha experimentado cambios recientes en su peso o tolerancia a la temperatura (mucho frío o calor cuando otros no)?
4. ¿Nota que sus heridas sanan muy lentamente o le aparecen moretones con excesiva facilidad?
5. (Si tiene diabetes) ¿Suele tener episodios de bajadas de azúcar, o siente ardor, entumecimiento o pérdida de sensibilidad en manos y pies?

🩸 Hematológico

1. ¿Sangra o se le forman moretones fácilmente después de un traumatismo menor, cirugía o procedimiento dental?
2. ¿Experimenta falta de aire, palpitaciones o dolor en el pecho con esfuerzos leves (subir escaleras) o en reposo?
3. ¿Padece infecciones recurrentes o fiebre baja frecuente (resfriados, gripe, infecciones respiratorias)?
4. **¿Está recibiendo tratamiento contra el cáncer (quimioterapia o radioterapia) y se encuentra mal o tiene fiebre?** URGENCIA
5. **(Si tiene hemofilia u otro trastorno hereditario de la coagulación) ¿Tiene un dolor nuevo en una articulación o un músculo, con hormigueo o tirantez, hinchazón, calor o dificultad para moverla?** URGENCIA
6. ¿Ha notado heces negras/alquitranadas, sangre en orina, o ha tosido o vomitado sangre?

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Solo se preguntan si el paciente tiene la condición (en la app, su tarjeta de la fase 1 marcada, o el mecanismo «Post-quirúrgico»). La escala de Beighton, la sospecha del subtipo vascular, la prueba de bipedestación, la regla de la tensión en el embarazo y la tensión tumbado y de pie del Parkinson se calculan en la guía (QR).

🏥 Posquirúrgico

Solo con mecanismo «Post-quirúrgico» en la fase 1

1. **¿Desde la operación, la herida está más roja, caliente, hinchada o dolorosa, supura o se ha abierto, o ha tenido fiebre, escalofríos o malestar general?** URGENCIA
2. **¿Desde la operación tiene una pantorrilla o una pierna hinchada, caliente o dolorosa? (Posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.)** URGENCIA
3. **¿Le falta el aire de repente, le duele el pecho al respirar, ha tosido sangre o se ha mareado o desmayado?** URGENCIA
4. **¿Desde la operación, o desde que le pusieron un yeso, una férula o un vendaje, tiene un dolor intenso y desproporcionado que va a más, sobre todo al estirar los dedos, con la zona muy tensa, hormigueo o adormecimiento?** URGENCIA
5. ¿Tiene un dolor continuo y desproporcionado para la operación, con cambios de color, temperatura, sudoración o hinchazón en la zona, o le duele incluso el roce de la ropa?
6. **¿Desde la operación nota un dolor quemante, hormigueo, adormecimiento o pérdida de fuerza nuevos en la zona de un nervio (por ejemplo, en la mano o el pie del lado operado)?** URGENCIA

🧬 Hipermovilidad

Solo con tarjeta «Hipermovilidad / Ehlers-Danlos» marcada

1. **¿Ha tenido de forma brusca un dolor intenso, que va a más, en el abdomen, el flanco, la espalda, el pecho o un brazo o una pierna?** URGENCIA
   con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida
2. **¿Ha notado de repente un zumbido en la sien, con el ojo rojo, dolorido o más saltón?** URGENCIA *con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida*
3. **¿Le ha faltado el aire de forma brusca, o le duele el pecho al respirar?** URGENCIA
   con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida
4. ¿Algún familiar de primer grado con SED vascular, o con una rotura o disección arterial antes de los 40 años? *con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)*
5. ¿Ha tenido una rotura arterial o una rotura de intestino sin causa conocida?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
6. ¿Ha tenido algún neumotórax espontáneo?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
7. ¿Le salen hematomas sin golpes, en sitios poco habituales (mejillas, espalda), o tiene la piel fina y translúcida, con las venas muy visibles?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
8. ¿Tuvo varices antes de los 30 años (y, si es mujer, sin haber estado embarazada)?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)

🫀 Disautonomía

Solo con tarjeta «Disautonomía / POTS» marcada

1. **¿Se ha desmayado alguna vez mientras hacía un esfuerzo (no justo al pararlo)?** URGENCIA
2. **¿Se ha desmayado estando tumbado, o justo después de notar de golpe el corazón muy rápido?** URGENCIA
3. **Si se ha desmayado: ¿tenía a la vez dolor en el pecho o falta de aire nuevos, o le han dicho que tiene un soplo, insuficiencia cardiaca u otra enfermedad del corazón?** URGENCIA
4. **Si se ha desmayado: ¿algún familiar murió de forma súbita antes de los 40 años, o tiene una enfermedad del corazón hereditaria?** URGENCIA
5. ¿Le dan episodios en que el corazón se le dispara de golpe y se le para también de golpe, aunque esté sentado o tumbado, sin llegar a desmayarse? DERIVACIÓN

🦋 Lupus

Solo con tarjeta «Lupus (LES)» marcada · solo «Diagnosticado»

1. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o se encuentra mal en general de una forma nueva? (Con corticoides o inmunosupresores puede haber una infección sin fiebre.)** URGENCIA
2. **¿Tiene una pantorrilla o una pierna (o un brazo) hinchada, caliente o dolorosa de forma nueva? (Posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.)** URGENCIA
3. **¿Le ha faltado el aire de repente o le duele el pecho al respirar? ¿O ha tenido de golpe debilidad o adormecimiento de un lado, dificultad para hablar o pérdida de visión, aunque se le haya pasado?** URGENCIA
4. **¿Tiene un dolor en el pecho punzante que empeora al respirar hondo y mejora inclinándose hacia delante?** URGENCIA
5. **¿Tiene en algún dedo de la mano o del pie una herida o úlcera en la yema, o un dedo que se queda blanco o morado y no recupera el color?** URGENCIA
6. **¿Ha tenido una convulsión o confusión nueva; debilidad u hormigueo en las dos piernas que va a más, con cambios al orinar; de golpe, el pie o la mano caídos; o pérdida de visión?** URGENCIA
7. ¿Tiene un dolor profundo y persistente en la ingle, la rodilla, el hombro o el tobillo, que empeora al cargar o al andar y no se explica por un golpe? DERIVACIÓN
8. ¿Le cuesta cada vez más levantarse de una silla, subir escaleras o levantar los brazos por encima de la cabeza? DERIVACIÓN
9. Desde la última vez que le vio su reumatólogo, ¿tiene articulaciones hinchadas nuevas, una erupción, llagas en la boca o más caída de pelo? DERIVACIÓN
10. ¿Se le hinchan las piernas o los tobillos de forma nueva, le han dicho que tiene la tensión alta desde hace poco, o en un análisis que tiene proteínas o sangre en la orina? DERIVACIÓN

💉 Trastorno mastocitario o anafilaxia

Solo con tarjeta «Trastorno mastocitario o anafilaxia» marcada

1. Desde su última revisión médica, ¿ha tenido episodios bruscos con ronchas, hinchazón, falta de aire, mareo o desmayo que su médico aún no conoce? DERIVACIÓN

🦴 Osteoporosis

Solo con tarjeta «Osteoporosis o fragilidad ósea» marcada

1. **¿Tiene un dolor de espalda nuevo con debilidad, hormigueo o torpeza en las piernas que va a más, o cambios al orinar o al hacer de vientre?** URGENCIA
2. ¿Le empezó de golpe un dolor de espalda, sobre todo en la zona dorsal, tras un esfuerzo pequeño (levantar algo agachado, toser, estornudar, resbalar), y no se le ha ido? DERIVACIÓN
3. ¿Ha perdido 4 cm o más de altura respecto a cuando era joven (o 2 cm desde la última vez que se la midieron), o se le ha curvado más la espalda? DERIVACIÓN
   sin fractura vertebral conocida
4. ¿Tiene un dolor de muslo, ingle o cadera sin explicación? DERIVACIÓN
   con bifosfonato o denosumab

🤰 Embarazo y posparto

Solo con tarjeta «Embarazo o posparto» marcada

1. **¿Tiene dolor de cabeza fuerte o que no se le pasa, ve borroso o destellos, dolor fuerte justo debajo de las costillas, vómitos, o se le han hinchado de golpe la cara, las manos o los pies?** URGENCIA *embarazo desde la semana 20 o posparto*
2. **¿Ha tenido un sangrado vaginal que no le han explicado?** URGENCIA
   solo embarazo desde la semana 13
3. **¿Nota que el bebé se mueve menos de lo habitual?** URGENCIA
   solo embarazo desde la semana 24
4. **¿Tiene contracciones regulares y dolorosas, o le sale líquido por la vagina?** URGENCIA *solo embarazo*
5. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o se encuentra muy mal?** URGENCIA *solo embarazo*
6. **¿Tiene un sangrado vaginal brusco o muy abundante, que va a más, o expulsa coágulos o restos? ¿O se le ha hinchado mucho el vientre?** URGENCIA *solo posparto*
7. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o dolor de vientre, pelvis o periné, o un flujo que huele mal?** URGENCIA *solo posparto hasta la semana 8 tras el parto*
8. **¿Tiene dolor e hinchazón nuevos en una pierna, sobre todo en una sola; o dolor de espalda o de nalga con toda la pierna hinchada; o le falta el aire de forma nueva, le duele el pecho o ha tosido sangre?** URGENCIA
9. **¿Tiene dolor en el pecho, palpitaciones, o le falta el aire en reposo o al tumbarse?** URGENCIA
10. **¿Se le ha abierto la herida del periné o la de la cesárea, o tiene más dolor, rojez o supuración en ella?** URGENCIA *solo posparto*
11. **¿Desde el parto se le escapa la orina o las heces de forma continua, sin poder controlarlo nada?** URGENCIA *solo posparto*
12. **(Si hace falta, al acompañante) ¿Ha notado cambios bruscos desde el parto: confusión, ideas extrañas, euforia o mucha agitación?** URGENCIA *solo posparto*
13. **¿Ha pensado en hacerse daño o en quitarse la vida?** URGENCIA
14. ¿Tiene un dolor de espalda intenso y que no se le pasa, dorsal o lumbar, en el embarazo o desde el parto, o ha perdido 3 cm o más de altura? DERIVACIÓN
15. ¿Desde el parto tiene un dolor intenso o que empezó de golpe en la sacroilíaca, la nalga, la zona lumbar o el pubis, le cuesta apoyar o cojea, o se le alivia tumbada? DERIVACIÓN
    solo posparto hasta la semana 2 tras el parto
16. ¿Tiene un pecho rojo e hinchado desde hace más de 24 horas, aunque se lo haya tratado? DERIVACIÓN *solo posparto*

🩸 Anticoagulado o antiagregado

Solo con tarjeta «Paciente anticoagulado o antiagregado» marcada

1. **¿Se ha dado un golpe en la cabeza en los últimos días, aunque pareciera leve?** URGENCIA *no con aspirina sola*
2. **Desde un golpe en la cabeza (de hace días o semanas), ¿tiene un dolor de cabeza fuerte o que va a más, vómitos repetidos, somnolencia, confusión o cambios de conducta, o debilidad, dificultad para hablar o cambios de visión nuevos?** URGENCIA
3. **¿Le ha empezado de golpe un dolor fuerte de cuello o de espalda con debilidad, hormigueo o adormecimiento en brazos o piernas, o cambios al orinar o al hacer de vientre? (Puede empezar por la debilidad, sin dolor fuerte.)** URGENCIA
4. **¿Le ha empezado un dolor fuerte en la ingle, la cadera, el costado o la zona lumbar baja, con el muslo débil o adormecido, o con mareo, palidez o sudor frío? (Con un golpe pequeño o sin golpe.)** URGENCIA *solo con anticoagulante*
5. **¿Le ha salido de golpe, tras toser, un esfuerzo o una inyección de heparina, un dolor fuerte en la pared de la barriga con un bulto, que empeora al moverse o al tensar el abdomen?** URGENCIA *solo con anticoagulante*
6. **¿Tiene un brazo, un antebrazo, una mano, un muslo o una pierna muy hinchados y tensos, con un dolor desproporcionado que va a más y que empeora al estirarle pasivamente los dedos de la mano o del pie? (Tras un golpe pequeño, un esfuerzo o sin causa.)** URGENCIA
7. ¿Tiene un hematoma grande o que va a más, un bulto nuevo en un músculo, o una articulación hinchada tras un golpe pequeño o sin golpe? DERIVACIÓN

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

🧠 Parkinson

Solo con tarjeta «Parkinson» marcada

1. **En los últimos días, ¿está mucho más rígido o inmóvil que de costumbre y además tiene fiebre, está confuso, suda mucho o le cuesta tragar?** URGENCIA
   solo «Diagnosticado»
2. ¿Ha dejado de tomar su medicación del Parkinson, o no puede tomarla o retenerla (vómitos, diarrea, no puede tragar, una cirugía)? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
3. ¿Han vuelto de golpe el temblor, la rigidez o la lentitud, o tiene movimientos involuntarios fuertes o cambios de conducta nuevos? DERIVACIÓN *con estimulador cerebral profundo*
4. ¿Tiene periodos off que no sabe prever, movimientos involuntarios fuertes o calambres dolorosos cuando está en off? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
5. ¿Ve cosas que no están, o tiene conductas nuevas que no puede controlar (tomar medicación de más, juego, compras, comida)? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
6. ¿Se marea, ve borroso, nota las piernas flojas o le duele el cuello y los hombros al estar de pie, y se le pasa al sentarse o tumbarse? DERIVACIÓN
7. ¿Tose o se atraganta al comer o beber, o ha tenido infecciones respiratorias seguidas? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
8. ¿Se queda dormido de repente durante el día, sin poder evitarlo? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
9. Temblor, rigidez, lentitud, problemas de equilibrio o de la marcha, sin diagnóstico DERIVACIÓN *solo «Sospecha»*

URGENCIA derivar hoy DERIVACIÓN valoración médica, no urgente *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

Árbol de decisión — Rodilla

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Rodilla. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b. El porqué de cada paso, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. 8d812e7c

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

Desvío desde el paso 1 si «SÍ»

1b ¿Algún criterio de Ottawa (≥55 años · cabeza del peroné · rótula aislada · no flexiona 90° · no cargó cuatro pasos ni tras la lesión ni en la consulta)? Y en toda rodilla traumática con dolor anterior, elevación de la pierna extendida. Alternativa a Ottawa: Pittsburgh — contusión o caída MÁS (<12 o >50 años, o no puede caminar); S ≈99 % con E ≈60 %, pide menos radiografías (Seaberg y Jackson 1994; Seaberg 1998). R1, R3

- **OTTAWA POSITIVO →** 11 Fracturas (Rótula o Meseta Tibial)
- **NO ELEVA LA PIERNA EXTENDIDA →** sin hipótesis
- **NINGUNO →** sin hipótesis

SÍ

1 ¿Hubo un evento lesivo reciente con inflamación inmediata? Rodilla aguda traumática: ¿qué mecanismo cuenta? G2, G3 · R1, R2, R3, R4

NO

2 ¿El paciente es mayor de 45 años con rigidez matutina breve (<30 min)? R5, R8

todas

2b ¿Niño o adolescente con dolor de rodilla sin mecanismo conocido? → EXPLORAR PRIMERO LA CADERA (epifisiólisis, Perthes). Solo si el cribado es normal, seguir en la rodilla. G2

SÍ Sensación de "pop", derrame articular rápido e inestabilidad (posible LCA) → 4 Lesión del Ligamento Cruzado Anterior (LCA) → desvío 1b

SÍ Trauma rotacional con síntomas de bloqueo o chasquidos (posible Menisco) → 2 Lesión Meniscal → desvío 1b

SÍ Valgo con el pie fijo → LCM (mirar LCA y menisco medial) → 8 Lesión del Ligamento Colateral Medial (LCM) → desvío 1b

SÍ Golpe en tibia anterior con rodilla flexionada (salpicadero) → LCP y EPL → 9 Lesión del Ligamento Cruzado Posterior (LCP) → desvío 1b

SÍ Golpe anteromedial o varo cerca de la extensión → LLE y EPL → 10 Lesión del Ligamento Lateral Externo y Esquina Posterolateral (LLE y EPL) → desvío 1b

SÍ La rótula «se salió», aprensión al trasladarla lateralmente → INESTABILIDAD ROTULIANA → 12 Inestabilidad Rotuliana → desvío 1b

SÍ Golpe directo anterior, dolor con extensión resistida, escalón palpable → FRACTURA → 11 Fracturas (Rótula o Meseta Tibial) → desvío 1b

NO Dolor de inicio insidioso o crónico → sin hipótesis

SÍ Edad ≥45 años, dolor relacionado con actividad, rigidez <30 minutos → 1 Artrosis de Rodilla

NO Perfil más joven o sin patrón degenerativo → sin hipótesis

SÍ Cribado de cadera alterado: derivar (epifisiólisis, Perthes) → sin hipótesis

SÍ Cribado de cadera normal: seguir en la rodilla → sin hipótesis

NO Adulto, o hay mecanismo conocido → sin hipótesis

Todas → sigue en el paso 2c, en la página siguiente →

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor de rodilla inespecífico; revisar psicosociales y respuestas.
Fase 4b: confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

↓ Paso 2c: viene del paso 2b

2c ¿Reproduce el dolor de rodilla la exploración de la cadera o de la columna lumbar? 📝 R7

- **CADERA (artrosis)** — Tratar el origen: valorar en la región Cadera → sin hipótesis
- **COLUMNA LUMBAR (radiculopatía o pseudorradiculopatía)** — Tratar el origen: valorar en la región Lumbar → sin hipótesis
- **NO** — Ninguna de las dos reproduce el dolor de rodilla → sin hipótesis

todas →

3 ¿En qué zona se concentra el dolor de rodilla? 📝 R5, R6, R10, R11, R12

- **Anterior/Retrorrotuliano** — Dolor al cargar en flexión (escaleras, sentadilla) en <40 años → 3 Dolor Patelofemoral (Síndrome)
- **Anterior/Polo inferior rótula** — Dolor exacto en polo inferior, vinculado a saltos o frenadas → 5 Tendinopatía Rotuliana
- **Lateral** — Dolor en cóndilo femoral lateral que empeora al correr → 6 Síndrome de la Banda Iliotibial
- **Medial/Distal** — Dolor 2 cm distal a meseta tibial medial, empeora al subir escaleras → 7 Bursitis de la Pata de Ganso
- **NINGUNA de estas** — Seguir por zona → sin hipótesis

todas →

4 Dolor persistente o sin traumatismo, ANTERIOR: ¿qué lo explica? 📝 R5, R7, R10

- **HOFFA** — Recurvatum, test de Hoffa → 13 Síndrome de la Grasa de Hoffa
- **BURSITIS PRERROTULIANA** — Superficial, arrodillarse → 14 Bursitis Pre e Infrarrotuliana
- **INESTABILIDAD ROTULIANA** — Fallo, aprensión → 12 Inestabilidad Rotuliana
- **LESIÓN OSTEOCONDRAL** — Bloqueo → 16 Lesión Osteocondral
- **APOFISITIS POR TRACCIÓN** — En menores → 15 Apofisitis del Adolescente (Osgood-Schlatter, Sinding-Larsen-Johansson)
- **NINGUNO** — Sin dolor anterior o nada de esto lo explica → sin hipótesis

Todas → sigue en el paso 5 ↓

↓ Paso 5: viene del paso 4

5 Dolor persistente o sin traumatismo, MEDIAL: ¿qué lo explica? 📝 R5, R7, R8

- **MENISCO MEDIAL** → 2 Lesión Meniscal
- **ARTROSIS** — Criterios ACR → 1 Artrosis de Rodilla
- **PLICA MEDIAL** → 17 Plica Sinovial Medial
- **NINGUNO** — Sin dolor medial o nada de esto lo explica → sin hipótesis

todas →

6 Dolor persistente o sin traumatismo, LATERAL: ¿qué lo explica? 📝 R7, R9

- **TIBIOPERONEA PROXIMAL** → 18 Disfunción de la Articulación Tibioperonea Proximal
- **MENISCO LATERAL** → 2 Lesión Meniscal
- **NERVIO PERONEO COMÚN** → 19 Neuropatía del Nervio Peroneo Común
- **NINGUNO** — Sin dolor lateral o nada de esto lo explica → sin hipótesis

todas →

7 Dolor persistente o sin traumatismo, POSTERIOR: ¿qué lo explica? Descartada siempre la TVP. 📝 R5, R7

- **QUISTE POPLÍTEO** — Signo de Foucher → 20 Quiste Poplíteo (Baker)
- **LCP CRÓNICO** → 9 Lesión del Ligamento Cruzado Posterior (LCP)
- **COLUMNA LUMBAR** — Tratar el origen: valorar en la región Lumbar → sin hipótesis
- **NINGUNO** — Sin dolor posterior o nada de esto lo explica → sin hipótesis

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor de rodilla inespecífico; revisar psicosociales y respuestas.
Fase 4b: confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Confirmación de hipótesis · Rodilla

PhysiQ-Assessment · fase 4b. Los tests de cada hipótesis, sus LR y si puntúan. El criterio de cada test, por qué se hace, sus fuentes, «Ampliar con IA» y una calculadora que puntúa cada hipótesis con los tests que marques, en la guía de consulta (QR).

Porqués, IA y calculadora
v. a235a5fc

1 Artrosis de Rodilla

Test	LR+	LR−	Papel
Criterio combinado: Edad ≥45 + dolor en actividad + rigidez <30 min	—	—	hallazgo
Crepitación articular	**2.2**	**≈0.18**	**puntúa**
Agrandamiento óseo	**12**	**≈0.47**	**puntúa**
Restricción de ROM	**4.4**	≈0.86	**puntúa**
Criterios clínicos del ACR	1.6	0.80	hallazgo
Rango disminuido, hinchazón persistente, debilidad de cuádriceps	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

2 Lesión Meniscal

Test	LR+	LR−	Papel
Test de McMurray	**3.2**	0.52	**puntúa**
Sensibilidad a la palpación de la línea articular	**4.0**	**0.23**	**puntúa**
Combinación de tests clínicos	**2.7**	**0.40**	**puntúa**
Combinación traumática: traumatismo + dolor medial o difuso + palpación de la interlínea medial	**8.9**	**0.10**	**puntúa**
Combinación degenerativa: inicio progresivo + dolor medial aislado + uno de tres	**6.4**	—	**puntúa**
Test de Thessaly	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

3 Dolor Patelofemoral (Síndrome)

Test	LR+	LR−	Papel
Dolor anterior durante sentadilla	1.8	**0.20**	**puntúa**
Confirmar: grupos de Décary (edad, localización del dolor, escaleras, faceta medial, extensión pasiva)	**8.7**	—	**puntúa**
Descartar: grupos de Décary (si se cumple alguno, marcar «Negativo»)	—	**0.12**	**puntúa**
Palpación alrededor de la FR, sobre todo de las facetas	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

4 Lesión del Ligamento Cruzado Anterior (LCA)

Test	LR+	LR−	Papel
Test de Lachman	**5.7**	**0.24**	**puntúa**
Test de Cajón Anterior	**6.3**	**0.20**	**puntúa**
Test de Pivot Shift	**11**	0.56	**puntúa**
Lever Sign Test	**9.7**	**0.18**	**puntúa**
Confirmar: mecanismo de pivote + derrame inmediato + Lachman positivo	**18**	—	**puntúa**
Descartar: sin mecanismo de pivote ni chasquido + Lachman o pivot shift negativos (si se cumple, marcar «Negativo»)	—	**0.08**	**puntúa**
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

5 Tendinopatía Rotuliana

Test	LR+	LR−	Papel
Dolor localizado en polo inferior de rótula + palpación del tendón	—	—	hallazgo
Dolor durante sentadilla en tabla inclinada (decline squat)	—	—	hallazgo
Ecografía o RM (si se dispone de informe)	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

6 Síndrome de la Banda Iliotibial

Test	LR+	LR−	Papel
Test de Ober	—	—	hallazgo
Test de Compresión de Noble	—	—	hallazgo
Palpación a lo largo de la cintilla	—	—	hallazgo
Step-down lateral	—	—	hallazgo
Test de Thomas	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

7 Bursitis de la Pata de Ganso

Test	LR+	LR−	Papel
Dolor y tumefacción en cara medial de rodilla (inserción pata de ganso)	—	—	hallazgo
Ecografía o RMN confirmatoria	—	—	hallazgo
Flexión de rodilla en carga y palpación de la pata de ganso	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

8 Lesión del Ligamento Colateral Medial (LCM)

Test	LR+	LR−	Papel
Valgo forzado a 30° de flexión + mecanismo de la entrevista	**6.4**	**0.50**	**puntúa**
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

9 Lesión del Ligamento Cruzado Posterior (LCP)

Test	LR+	LR−	Papel
Cajón posterior a 90° de flexión	—	—	hallazgo
Signo del sag posterior	—	—	hallazgo
Test activo del cuádriceps	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

10 Lesión del Ligamento Lateral Externo y Esquina Posterolateral (LLE y EPL)

Test	LR+	LR−	Papel
Hinchazón y equimosis laterales; palpación dolorosa del ligamento	—	—	hallazgo
Varo forzado a unos 30° de flexión	—	—	hallazgo
Marcha con empuje en varo	—	—	hallazgo
Test del dial (esquina posterolateral)	—	—	hallazgo
Cajón posterolateral	—	—	hallazgo
Test de recurvatum	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

11 Fracturas (Rótula o Meseta Tibial)

Test	LR+	LR−	Papel
Regla de Ottawa antes de nada	≈1.7	**0.12**	**puntúa**
Rótula: dolor localizado, escalón, dolor con extensión resistida	—	—	hallazgo
Meseta: dolor exquisito sobre el foco y función neurovascular	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

12 Inestabilidad Rotuliana

Test	LR+	LR−	Papel
Tests de estrés tibiofemoral normales	—	—	hallazgo
Movilidad rotuliana excesiva	—	—	hallazgo
Test de aprensión	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

13 Síndrome de la Grasa de Hoffa

Test	LR+	LR−	Papel
Observación: genu recurvatum	—	—	hallazgo
Test de Hoffa	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

14 Bursitis Pre e Infrarrotuliana

Test	LR+	LR−	Papel
Fiebre >37,7 °C (séptica → urgencia)	—	—	hallazgo
Hinchazón en la propia bursa y arrodillarse intolerable	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

LR en **verde**: multiplica la puntuación (LR+ ≥ 2 o LR− ≤ 0,5); en gris: no informativa, cuenta como hallazgo. «≈» = calculada de S y E. **puntúa**: puede mover la puntuación · hallazgo: sin LR aplicable · en clúster: solo cuenta con su clúster 🧩 · pronóstico: no entra en la puntuación. Criterio completo de cada test, fuentes y calculadora de la puntuación, en la guía (QR).

PhysiQ-Assessment · fase 4b · Rodilla. Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Confirmación de hipótesis · Rodilla (continuación)

15 Apofisitis del Adolescente (Osgood-Schlatter, Sinding-Larsen-Johansson)

Test	LR+	LR−	Papel
Cadera primero	—	—	hallazgo
Palpación de la tuberosidad tibial o del polo inferior de la rótula	—	—	hallazgo
Sentadillas, escaleras, step-down, saltos y extensión resistida	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

16 Lesión Osteocondral

Test	LR+	LR−	Papel
Palpación de la zona afectada	—	—	hallazgo
Marcha antiálgica	—	—	hallazgo
Signos de inestabilidad: derrame y bloqueo	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

17 Plica Sinovial Medial

Test	LR+	LR−	Papel
Test de provocación de la plica rotuliana medial	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

18 Disfunción de la Articulación Tibioperonea Proximal

Test	LR+	LR−	Papel
Presión directa sobre la cabeza del peroné y movilidad accesoria	—	—	hallazgo
Movimiento de rodilla con isquiotibiales en tensión y movimiento de tobillo	—	—	hallazgo
Cabeza del peroné prominente, hipermovilidad o luxación	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

19 Neuropatía del Nervio Peroneo Común

Test	LR+	LR−	Papel
Marcha en steppage	—	—	hallazgo
Sensibilidad en la cara lateral inferior de la pierna y el dorso del pie	—	—	hallazgo
Fuerza de eversión y de flexión dorsal de tobillo y dedos	—	—	hallazgo
Tinel cerca de la cabeza del peroné	—	—	hallazgo
Prueba neurodinámica con sesgo peroneo	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

20 Quiste Poplíteo (Baker)

Test	LR+	LR−	Papel
Signos de patología meniscal o condral	—	—	hallazgo
Signo de Foucher	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

LR en **verde**: multiplica la puntuación (LR+ ≥ 2 o LR− ≤ 0,5); en gris: no informativa, cuenta como hallazgo. «≈» = calculada de S y E. **puntúa**: puede mover la puntuación · hallazgo: sin LR aplicable · en clúster: solo cuenta con su clúster 🧩 · pronóstico: no entra en la puntuación. Criterio completo de cada test, fuentes y calculadora de la puntuación, en la guía (QR).

PhysiQ-Assessment · fase 4b · Rodilla. Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Cribado sistémico · Tobillo y pie

PhysiQ-Assessment · fase 2. Lo que se pregunta siempre en tobillo y pie. Las condiciones especiales, en la página siguiente. El porqué de cada pregunta, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. e7880e01

URGENCIAS · COMPARTIMENTAL Y NEUROVASCULAR · ARTRITIS INFECCIOSA · ROTURA DEL AQUILES · OTTAWA

· SÍNDROME COMPARTIMENTAL Y COMPROMISO NEUROVASCULAR tras lesión grave del mediopié (Lisfranc): el flujo puede caer tras luxarse el 2.º MT → cirugía urgente. Cinco P: palidez · dolor desproporcionado · parestesias · sin pulso · frialdad.

· ARTRITIS INFECCIOSA: monoartritis aguda con MALESTAR SISTÉMICO Y FIEBRE ALTA → URGENCIA HOY. En la gota suele estar sistémicamente bien, aunque un brote agudo puede dar fiebre y leucocitosis: solo el análisis del líquido articular las separa.

· ROTURA AGUDA DEL AQUILES: golpe o patada detrás de la pierna en un gesto explosivo, a veces chasquido; camina sorprendentemente bien, con cojera. Thompson: prono, pie fuera de la camilla; al comprimir la pantorrilla el tobillo no se mueve → S 96 % · E 93 % → derivación preferente.

· REGLAS DE OTTAWA, antes de explorar cualquier traumatismo agudo. TOBILLO → radiografía si dolor en la zona maleolar Y alguno: dolor óseo en los 6 cm distales del borde posterior de la tibia o punta del maléolo medial · ídem del peroné o punta del maléolo lateral · no carga cuatro pasos, ni justo tras la lesión ni en consulta. PIE → radiografía si dolor en el mediopié Y alguno: dolor óseo en la base del 5.º MT · en el navicular · no carga cuatro pasos. Muy sensible y poco específica (Beckenkamp 2017): S 99,4 % y E 35,3 % la de tobillo, S 99,2 % y E 42,3 % la de mediopié; una regla negativa descarta fractura (LR− 0,018 tobillo, 0,020 mediopié), algo menos en niños (S 97,9 %, LR− 0,10). Excluidas embarazadas y personas que no pueden seguir la prueba (p. ej., traumatismo craneal). ≈10 % de las inversiones acaban en fractura.

🦴 Traumático / Mecánico

1. **¿Tras una lesión grave del mediopié, tiene el pie pálido o frío, dormido u hormigueante, sin pulso, o un dolor desproporcionado (cinco P)?** URGENCIA
2. ¿Tras el traumatismo no pudo dar cuatro pasos apoyando el pie, ni justo tras la lesión ni ahora en consulta? (Aplicar las reglas de Ottawa en el árbol: radiografía si hay algún criterio.)
3. ¿Notó un golpe o una patada detrás de la pierna en un gesto explosivo, a veces con chasquido, y desde entonces cojea? (Thompson en el árbol: derivación preferente.)
4. ¿Se cayó hacia delante sobre el pie en punta (fallar un escalón) o desde altura sobre el talón, y no puede apoyar? (Lisfranc o calcáneo: derivación preferente.)
5. ¿Se le ha aplanado el arco del pie, o no puede doblar la punta del dedo gordo, tras un impulso, un aterrizaje forzado o una tendinopatía que va a más (rotura del tibial posterior o del FHL)?

🦴 Fractura de Estrés

1. ¿El dolor apareció poco a poco tras un cambio de carga (más entrenamiento, otro calzado, otra superficie), no mejora al calentar y le molesta por la noche?
2. ¿Ha tenido más de dos fracturas de estrés en huesos distintos? (Derivar: densidad ósea, RED-S, endocrino, nutricional.)

🦠 Infecciosa / Inflamatoria

1. **¿Tiene una articulación del tobillo o del pie hinchada y muy dolorosa, con fiebre alta y malestar general?** URGENCIA
2. ¿Tiene rigidez por la mañana de más de 60 minutos que mejora al moverse, o hinchazón caliente en varias articulaciones, algún dedo hinchado entero o cambios en las uñas?

🔬 Oncológico / Sistémico

1. ¿Tiene fiebre, sudores nocturnos o ha perdido peso sin explicación, o el dolor le despierta por la noche?
2. (Niño o joven) ¿Tiene un dolor sordo que empeora por la noche, sin relación con la actividad, y que se le alivia en menos de 20 minutos con un antiinflamatorio? (Osteoma osteoide: derivar.)

🩸 Vascular

1. ¿Le aparece dolor o calambre siempre tras la misma distancia o el mismo tiempo de esfuerzo?
2. **¿Tras una inmovilización, una férula, estar encamado o una cirugía reciente, tiene la pantorrilla o toda la pierna hinchada, caliente o dolorosa? (Posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.)** URGENCIA
3. **Si se ha desmayado alguna vez: ¿fue mientras hacía un esfuerzo, estando tumbado, justo después de notar de golpe el corazón muy rápido, o con dolor en el pecho o falta de aire nuevos? ¿O algún familiar suyo murió de forma súbita antes de los 40 años?** URGENCIA

🧠 Neurológico

1. **¿Tiene debilidad en las dos piernas que va a más en días o pocas semanas? (Explorar reflejos: con arreflexia, derivación el mismo día.)** URGENCIA
2. ¿Tiene ardor, hormigueo o pérdida de sensibilidad en los dos pies (p. ej., con diabetes), o se le cae el pie al caminar?
3. Desde una lesión, ¿tiene el pie enrojecido, con cambios de temperatura o sudoración, hinchado más allá de la fase aguda, o le duele al mínimo roce?

⚗️ Endocrino / Metabólico

1. ¿Siente fatiga inusual o debilidad muscular, especialmente al subir escaleras o levantarse de una silla?
2. ¿Ha notado aumento anormal de sed, apetito o frecuencia urinaria (incluso despertándose por la noche)?
3. ¿Ha experimentado cambios recientes en su peso o tolerancia a la temperatura (mucho frío o calor cuando otros no)?
4. ¿Nota que sus heridas sanan muy lentamente o le aparecen moretones con excesiva facilidad?
5. (Si tiene diabetes) ¿Suele tener episodios de bajadas de azúcar, o siente ardor, entumecimiento o pérdida de sensibilidad en manos y pies?

🩸 Hematológico

1. ¿Sangra o se le forman moretones fácilmente después de un traumatismo menor, cirugía o procedimiento dental?
2. ¿Experimenta falta de aire, palpitaciones o dolor en el pecho con esfuerzos leves (subir escaleras) o en reposo?
3. ¿Padece infecciones recurrentes o fiebre baja frecuente (resfriados, gripe, infecciones respiratorias)?
4. **¿Está recibiendo tratamiento contra el cáncer (quimioterapia o radioterapia) y se encuentra mal o tiene fiebre?** URGENCIA
5. **(Si tiene hemofilia u otro trastorno hereditario de la coagulación) ¿Tiene un dolor nuevo en una articulación o un músculo, con hormigueo o tirantez, hinchazón, calor o dificultad para moverla?** URGENCIA
6. ¿Ha notado heces negras/alquitranadas, sangre en orina, o ha tosido o vomitado sangre?

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Condiciones especiales · Tobillo y pie

Solo se preguntan si el paciente tiene la condición (en la app, su tarjeta de la fase 1 marcada, o el mecanismo «Post-quirúrgico»). La escala de Beighton, la sospecha del subtipo vascular, la prueba de bipedestación, la regla de la tensión en el embarazo y la tensión tumbado y de pie del Parkinson se calculan en la guía (QR).

🏥 Posquirúrgico

Solo con mecanismo «Post-quirúrgico» en la fase 1

1. **¿Desde la operación, la herida está más roja, caliente, hinchada o dolorosa, supura o se ha abierto, o ha tenido fiebre, escalofríos o malestar general?** URGENCIA
2. **¿Desde la operación tiene una pantorrilla o una pierna hinchada, caliente o dolorosa? (Posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.)** URGENCIA
3. **¿Le falta el aire de repente, le duele el pecho al respirar, ha tosido sangre o se ha mareado o desmayado?** URGENCIA
4. **¿Desde la operación, o desde que le pusieron un yeso, una férula o un vendaje, tiene un dolor intenso y desproporcionado que va a más, sobre todo al estirar los dedos, con la zona muy tensa, hormigueo o adormecimiento?** URGENCIA
5. ¿Tiene un dolor continuo y desproporcionado para la operación, con cambios de color, temperatura, sudoración o hinchazón en la zona, o le duele incluso el roce de la ropa?
6. **¿Desde la operación nota un dolor quemante, hormigueo, adormecimiento o pérdida de fuerza nuevos en la zona de un nervio (por ejemplo, en la mano o el pie del lado operado)?** URGENCIA

🧬 Hipermovilidad

Solo con tarjeta «Hipermovilidad / Ehlers-Danlos» marcada

1. **¿Ha tenido de forma brusca un dolor intenso, que va a más, en el abdomen, el flanco, la espalda, el pecho o un brazo o una pierna?** URGENCIA
   con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida
2. **¿Ha notado de repente un zumbido en la sien, con el ojo rojo, dolorido o más saltón?** URGENCIA
   con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida
3. **¿Le ha faltado el aire de forma brusca, o le duele el pecho al respirar?** URGENCIA
   con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida
4. ¿Algún familiar de primer grado con SED vascular, o con una rotura o disección arterial antes de los 40 años? *con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)*
5. ¿Ha tenido una rotura arterial o una rotura de intestino sin causa conocida?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
6. ¿Ha tenido algún neumotórax espontáneo?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
7. ¿Le salen hematomas sin golpes, en sitios poco habituales (mejillas, espalda), o tiene la piel fina y translúcida, con las venas muy visibles?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
8. ¿Tuvo varices antes de los 30 años (y, si es mujer, sin haber estado embarazada)?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)

🫀 Disautonomía

Solo con tarjeta «Disautonomía / POTS» marcada

1. **¿Se ha desmayado alguna vez mientras hacía un esfuerzo (no justo al pararlo)?** URGENCIA
2. **¿Se ha desmayado estando tumbado, o justo después de notar de golpe el corazón muy rápido?** URGENCIA
3. **Si se ha desmayado: ¿tenía a la vez dolor en el pecho o falta de aire nuevos, o le han dicho que tiene un soplo, insuficiencia cardiaca u otra enfermedad del corazón?** URGENCIA
4. **Si se ha desmayado: ¿algún familiar murió de forma súbita antes de los 40 años, o tiene una enfermedad del corazón hereditaria?** URGENCIA
5. ¿Le dan episodios en que el corazón se le dispara de golpe y se le para también de golpe, aunque esté sentado o tumbado, sin llegar a desmayarse? DERIVACIÓN

🦋 Lupus

Solo con tarjeta «Lupus (LES)» marcada · solo «Diagnosticado»

1. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o se encuentra mal en general de una forma nueva? (Con corticoides o inmunosupresores puede haber una infección sin fiebre.)** URGENCIA
2. **¿Tiene una pantorrilla o una pierna (o un brazo) hinchada, caliente o dolorosa de forma nueva? (Posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.)** URGENCIA
3. **¿Le ha faltado el aire de repente o le duele el pecho al respirar? ¿O ha tenido de golpe debilidad o adormecimiento de un lado, dificultad para hablar o pérdida de visión, aunque se le haya pasado?** URGENCIA
4. **¿Tiene un dolor en el pecho punzante que empeora al respirar hondo y mejora inclinándose hacia delante?** URGENCIA
5. **¿Tiene en algún dedo de la mano o del pie una herida o úlcera en la yema, o un dedo que se queda blanco o morado y no recupera el color?** URGENCIA
6. **¿Ha tenido una convulsión o confusión nueva; debilidad u hormigueo en las dos piernas que va a más, con cambios al orinar; de golpe, el pie o la mano caídos; o pérdida de visión?** URGENCIA
7. ¿Tiene un dolor profundo y persistente en la ingle, la rodilla, el hombro o el tobillo, que empeora al cargar o al andar y no se explica por un golpe? DERIVACIÓN
8. ¿Le cuesta cada vez más levantarse de una silla, subir escaleras o levantar los brazos por encima de la cabeza? DERIVACIÓN
9. Desde la última vez que le vio su reumatólogo, ¿tiene articulaciones hinchadas nuevas, una erupción, llagas en la boca o más caída de pelo? DERIVACIÓN
10. ¿Se le hinchan las piernas o los tobillos de forma nueva, le han dicho que tiene la tensión alta desde hace poco, o en un análisis que tiene proteínas o sangre en la orina? DERIVACIÓN

💉 Trastorno mastocitario o anafilaxia

Solo con tarjeta «Trastorno mastocitario o anafilaxia» marcada

1. Desde su última revisión médica, ¿ha tenido episodios bruscos con ronchas, hinchazón, falta de aire, mareo o desmayo que su médico aún no conoce? DERIVACIÓN

🦴 Osteoporosis

Solo con tarjeta «Osteoporosis o fragilidad ósea» marcada

1. **¿Tiene un dolor de espalda nuevo con debilidad, hormigueo o torpeza en las piernas que va a más, o cambios al orinar o al hacer de vientre?** URGENCIA
2. ¿Le empezó de golpe un dolor de espalda, sobre todo en la zona dorsal, tras un esfuerzo pequeño (levantar algo agachado, toser, estornudar, resbalar), y no se le ha ido? DERIVACIÓN
3. ¿Ha perdido 4 cm o más de altura respecto a cuando era joven (o 2 cm desde la última vez que se la midieron), o se le ha curvado más la espalda? DERIVACIÓN
   sin fractura vertebral conocida
4. ¿Tiene un dolor de muslo, ingle o cadera sin explicación? DERIVACIÓN
   con bifosfonato o denosumab

🤰 Embarazo y posparto

Solo con tarjeta «Embarazo o posparto» marcada

1. **¿Tiene dolor de cabeza fuerte o que no se le pasa, ve borroso o destellos, dolor fuerte justo debajo de las costillas, vómitos, o se le han hinchado de golpe la cara, las manos o los pies?** URGENCIA *embarazo desde la semana 20 o posparto*
2. **¿Ha tenido un sangrado vaginal que no le han explicado?** URGENCIA
   solo embarazo desde la semana 13
3. **¿Nota que el bebé se mueve menos de lo habitual?** URGENCIA
   solo embarazo desde la semana 24
4. **¿Tiene contracciones regulares y dolorosas, o le sale líquido por la vagina?** URGENCIA *solo embarazo*
5. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o se encuentra muy mal?** URGENCIA *solo embarazo*
6. **¿Tiene un sangrado vaginal brusco o muy abundante, que va a más, o expulsa coágulos o restos? ¿O se le ha hinchado mucho el vientre?** URGENCIA *solo posparto*
7. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o dolor de vientre, pelvis o periné, o un flujo que huele mal?** URGENCIA *solo posparto hasta la semana 8 tras el parto*
8. **¿Tiene dolor e hinchazón nuevos en una pierna, sobre todo en una sola; o dolor de espalda o de nalga con toda la pierna hinchada; o le falta el aire de forma nueva, le duele el pecho o ha tosido sangre?** URGENCIA
9. **¿Tiene dolor en el pecho, palpitaciones, o le falta el aire en reposo o al tumbarse?** URGENCIA
10. **¿Se le ha abierto la herida del periné o la de la cesárea, o tiene más dolor, rojez o supuración en ella?** URGENCIA *solo posparto*
11. **¿Desde el parto se le escapa la orina o las heces de forma continua, sin poder controlarlo nada?** URGENCIA *solo posparto*
12. **(Si hace falta, al acompañante) ¿Ha notado cambios bruscos desde el parto: confusión, ideas extrañas, euforia o mucha agitación?** URGENCIA *solo posparto*
13. **¿Ha pensado en hacerse daño o en quitarse la vida?** URGENCIA
14. ¿Tiene un dolor de espalda intenso y que no se le pasa, dorsal o lumbar, en el embarazo o desde el parto, o ha perdido 3 cm o más de altura? DERIVACIÓN
15. ¿Desde el parto tiene un dolor intenso o que empezó de golpe en la sacroilíaca, la nalga, la zona lumbar o el pubis, le cuesta apoyar o cojea, o se le alivia tumbada? DERIVACIÓN
    solo posparto hasta la semana 2 tras el parto
16. ¿Tiene un pecho rojo e hinchado desde hace más de 24 horas, aunque se lo haya tratado? DERIVACIÓN *solo posparto*

🩸 Anticoagulado o antiagregado

Solo con tarjeta «Paciente anticoagulado o antiagregado» marcada

1. **¿Se ha dado un golpe en la cabeza en los últimos días, aunque pareciera leve?** URGENCIA *no con aspirina sola*
2. **Desde un golpe en la cabeza (de hace días o semanas), ¿tiene un dolor de cabeza fuerte o que va a más, vómitos repetidos, somnolencia, confusión o cambios de conducta, o debilidad, dificultad para hablar o cambios de visión nuevos?** URGENCIA
3. **¿Le ha empezado de golpe un dolor fuerte de cuello o de espalda con debilidad, hormigueo o adormecimiento en brazos o piernas, o cambios al orinar o al hacer de vientre? (Puede empezar por la debilidad, sin dolor fuerte.)** URGENCIA
4. **¿Le ha empezado un dolor fuerte en la ingle, la cadera, el costado o la zona lumbar baja, con el muslo débil o adormecido, o con mareo, palidez o sudor frío? (Con un golpe pequeño o sin golpe.)** URGENCIA *solo con anticoagulante*
5. **¿Le ha salido de golpe, tras toser, un esfuerzo o una inyección de heparina, un dolor fuerte en la pared de la barriga con un bulto, que empeora al moverse o al tensar el abdomen?** URGENCIA *solo con anticoagulante*
6. **¿Tiene un brazo, un antebrazo, una mano, un muslo o una pierna muy hinchados y tensos, con un dolor desproporcionado que va a más y que empeora al estirarle pasivamente los dedos de la mano o del pie? (Tras un golpe pequeño, un esfuerzo o sin causa.)** URGENCIA
7. ¿Tiene un hematoma grande o que va a más, un bulto nuevo en un músculo, o una articulación hinchada tras un golpe pequeño o sin golpe? DERIVACIÓN

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

🧠 Parkinson

Solo con tarjeta «Parkinson» marcada

1. **En los últimos días, ¿está mucho más rígido o inmóvil que de costumbre y además tiene fiebre, está confuso, suda mucho o le cuesta tragar?** URGENCIA
   solo «Diagnosticado»
2. ¿Ha dejado de tomar su medicación del Parkinson, o no puede tomarla o retenerla (vómitos, diarrea, no puede tragar, una cirugía)? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
3. ¿Han vuelto de golpe el temblor, la rigidez o la lentitud, o tiene movimientos involuntarios fuertes o cambios de conducta nuevos? DERIVACIÓN *con estimulador cerebral profundo*
4. ¿Tiene periodos off que no sabe prever, movimientos involuntarios fuertes o calambres dolorosos cuando está en off? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
5. ¿Ve cosas que no están, o tiene conductas nuevas que no puede controlar (tomar medicación de más, juego, compras, comida)? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
6. ¿Se marea, ve borroso, nota las piernas flojas o le duele el cuello y los hombros al estar de pie, y se le pasa al sentarse o tumbarse? DERIVACIÓN
7. ¿Tose o se atraganta al comer o beber, o ha tenido infecciones respiratorias seguidas? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
8. ¿Se queda dormido de repente durante el día, sin poder evitarlo? DERIVACIÓN
   solo «Diagnosticado»
9. Temblor, rigidez, lentitud, problemas de equilibrio o de la marcha, sin diagnóstico DERIVACIÓN *solo «Sospecha»*

URGENCIA derivar hoy DERIVACIÓN valoración médica, no urgente *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

Árbol de decisión — Tobillo y Pie

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Tobillo y pie. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b. El porqué de cada paso, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. 0bb9973b

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

Desvío desde el paso 1 si «SÍ»

2 ¿Algún criterio de Ottawa de tobillo o de pie, Thompson positivo, o mecanismo de Lisfranc o de caída sobre el talón? → DERIVAR para radiografía (Ottawa) o derivación preferente (Aquiles, Lisfranc, calcáneo) antes de seguir explorando. 📝 R1, R2, R3

- OTTAWA DE TOBILLO POSITIVO → 37 Fractura de Tobillo (Maleolar)
- OTTAWA DE PIE POSITIVO → 5 Fracturas del Pie (5.º MT, Calcáneo)
- THOMPSON POSITIVO → 3 Rotura del Aquiles
- MECANISMO DE LISFRANC → 4 Lesión de Lisfranc
- CAÍDA SOBRE EL TALÓN → 5 Fracturas del Pie (5.º MT, Calcáneo)
- NINGUNO → sin hipótesis

3 Tobillo agudo traumático, ¿qué mecanismo cuenta? 📝 R1, R4

- ESGUINCE LATERAL → 1 Esguince Lateral Agudo (LPAA y LPC)
- SINDESMOSIS → 2 Lesión de la Sindesmosis
- CALCANEOCUBOIDEA → 29 Lesión Calcaneocuboidea y Cubometatarsiana
- LUXACIÓN DEL TIBIAL POSTERIOR → 6 Luxación del Tibial Posterior
- NINGUNO → sin hipótesis

SÍ

1 ¿Traumatismo agudo? 📝 G2, G3 · R1, R2, R3

- **SÍ** — Traumatismo agudo: Ottawa primero, después por mecanismo → → desvío 2
- **NO** — Sin traumatismo: por edad y localización → sin hipótesis

NO

4 ¿Niño o adolescente con dolor bien localizado o sin mecanismo claro? 📝 G2 · R9

- **SEVER** — Inserción del Aquiles (8–12 años) → 36 Apofisitis y Osteocondrosis Pediátricas (Sever, Iselin, Köhler, Freiberg)
- **ISELIN** — Base del 5.º MT (8–13 años) → 36 Apofisitis y Osteocondrosis Pediátricas (Sever, Iselin, Köhler, Freiberg)
- **APOFISITIS DEL TIBIAL POSTERIOR o KÖHLER** — Navicular (menores de 10, cojera) → 36 Apofisitis y Osteocondrosis Pediátricas (Sever, Iselin, Köhler, Freiberg)
- **FREIBERG** — Cabeza del 2.º–4.º MT (14–18 años) → 36 Apofisitis y Osteocondrosis Pediátricas (Sever, Iselin, Köhler, Freiberg)
- **OSTEOCONDRITIS DISECANTE** — Esguince que no se resuelve, bloqueo → 25 Osteocondritis Disecante del Astrágalo
- **OSTEOMA OSTEOIDE** — Dolor nocturno con alivio rápido por AINE: derivar → sin hipótesis
- **NO** — Adulto, o hay mecanismo claro → sin hipótesis

todas

5 ¿La exploración local no reproduce el dolor conocido? → COLUMNA LUMBAR u origen proximal: slump con flexión plantar e inversión. Si persiste la duda, replantear (malignidad). 📝 R9

- **COLUMNA LUMBAR u origen proximal** — El slump con flexión plantar e inversión reproduce: valorar en la región Lumbar → sin hipótesis
- **NO REPRODUCE NADA** — Persiste la duda: replantear (malignidad) → sin hipótesis
- **NO** — La exploración local sí reproduce el dolor conocido → sin hipótesis

todas

6 Dolor sin traumatismo en el tobillo, POSTERIOR: ¿qué lo explica? 📝 R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12

- **PINZAMIENTO POSTERIOR** — Flexión plantar máxima → 7 Pinzamiento Posterior del Tobillo
- **AQUILES PORCIÓN MEDIA** — Pinza, 2–6 cm → 8 Tendinopatía del Aquiles, Porción Media
- **AQUILES INSERCIONAL** — Un dedo, flexión dorsal → 9 Tendinopatía Insercional del Aquiles
- **VAINA DEL AQUILES** — Crepitación, rango amplio → 10 Afectación de la Vaina del Aquiles
- **PLANTAR DELGADO** — Medial y proximal → 11 Tendinopatía del Plantar Delgado
- **NERVIO SURAL** — Lateral, neuropático → 12 Neuropatía del Nervio Sural
- **BURSA SUPERFICIAL** — Roce del zapato → 13 Bursitis Calcánea Superficial
- **NINGUNO** — Sin dolor posterior o nada de esto lo explica → sin hipótesis

Todas → sigue en el paso 7, en la página siguiente →

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor de tobillo y pie inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

↓ Paso 7: viene del paso 6

7 Dolor sin traumatismo en el tobillo, MEDIAL: ¿qué lo explica? 📝 R5, R9, R11, R12

- **TIBIAL POSTERIOR** — Retromaleolar, ETM sin varo del retropié → **14 Tendinopatía del Tibial Posterior**
- **FHL** — Transición de flexión dorsal a plantar → **15 Tendinopatía del Flexor Largo del Primer Dedo (FHL)**
- **TÚNEL DEL TARSO** — Tinel → **16 Síndrome del Túnel del Tarso**
- **FRACTURA DE ESTRÉS** — Maléolo medial → **17 Fractura de Estrés del Tobillo (Maléolo Medial, Astrágalo, Calcáneo)**
- **NINGUNO** — Sin dolor medial o nada de esto lo explica → sin hipótesis

todas →

8 Dolor sin traumatismo en el tobillo, LATERAL: ¿qué lo explica? 📝 R5, R9, R10

- **SENO DEL TARSO** → **18 Síndrome del Seno del Tarso**
- **PERONEOS** → **19 Tendinopatía de los Peroneos**
- **ESTRÉS DEL ASTRÁGALO** → **17 Fractura de Estrés del Tobillo (Maléolo Medial, Astrágalo, Calcáneo)**
- **REFERIDO** — Valorar en la región Lumbar → sin hipótesis
- **NINGUNO** — Sin dolor lateral o nada de esto lo explica → sin hipótesis

todas →

9 Dolor sin traumatismo en el tobillo, ANTERIOR: ¿qué lo explica? 📝 R5, R9, R10

- **PINZAMIENTO ANTERIOR** — KTW (rodilla a la pared) → **20 Pinzamiento Anterior del Tobillo**
- **NINGUNO** — Sin dolor anterior o no lo explica → sin hipótesis

todas →

10 Dolor en el pie, TALÓN PLANTAR: ¿qué lo explica? 📝 R5, R8, R9, R11, R12

- **DOLOR PLANTAR CRÓNICO** — Tuberosidad medial → **26 Dolor Plantar Crónico del Talón**
- **ALMOHADILLA GRASA** — Posterolateral → **27 Síndrome de la Almohadilla Grasa del Talón**
- **ATRAPAMIENTO NERVIOSO** — Tinel → **28 Atrapamiento Nervioso del Talón**
- **ESTRÉS DEL CALCÁNEO** → **17 Fractura de Estrés del Tobillo (Maléolo Medial, Astrágalo, Calcáneo)**
- **NINGUNO** — Sin dolor en el talón plantar o nada de esto lo explica → sin hipótesis

Todas → sigue en el paso 11 ↓

↓ Paso 11: viene del paso 10

11 Dolor en el pie, MEDIOPIÉ: ¿qué lo explica? 📝 R4, R5, R11, R12

- **CALCANEOCUBOIDEA** → **29 Lesión Calcaneocuboidea y Cubometatarsiana**
- **NAVICULAR (punto N), CUBOIDES O CUÑAS** — Fractura de estrés → **30 Fractura de Estrés del Mediopié (Navicular, Cuboides, Cuñas)**
- **LISFRANC** → **4 Lesión de Lisfranc**
- **COALICIÓN** → **23 Coalición Tarsiana**
- **NINGUNO** — Sin dolor en el mediopié o nada de esto lo explica → sin hipótesis

todas →

12 Dolor en el pie, ANTEPIÉ: ¿qué lo explica? 📝 R1, R5, R9, R10, R11

- **1.ª MTF** → **31 Lesión de la 1.ª Metatarsofalángica**
- **BASE DEL 2.º MT** → **32 Dolor en la Base del 2.º Metatarsiano**
- **CUELLO DE MT** — Fractura de marcha → **33 Fractura de Estrés del Cuello de un Metatarsiano (Fractura de Marcha)**
- **5.º MT** — Fractura → **5 Fracturas del Pie (5.º MT, Calcáneo)**
- **MORTON** — O bursitis intermetatarsiana → **34 Neuroma de Morton o Bursitis Intermetatarsiana**
- **GOTA** — Derivar para confirmar (con fiebre y malestar → artritis infecciosa: urgencia) → **35 Gota**
- **NINGUNO** — Sin dolor en el antepié o nada de esto lo explica → sin hipótesis

todas →

13 DOLOR VAGO DEL TOBILLO o que no se resuelve tras un esguince: ¿qué lo explica? 📝 R4, R7, R9, R10

- **INESTABILIDAD CRÓNICA** → **21 Inestabilidad Crónica del Tobillo**
- **SINDESMOSIS** → **2 Lesión de la Sindesmosis**
- **SINOVITIS POSTRAUMÁTICA** → **22 Sinovitis Postraumática**
- **COALICIÓN TARSIANA** → **23 Coalición Tarsiana**
- **ARTROSIS** → **24 Artrosis de Tobillo o Pie**
- **OSTEOCONDRITIS DISECANTE** → **25 Osteocondritis Disecante del Astrágalo**
- **NINGUNO** — Sin dolor vago o nada de esto lo explica → sin hipótesis

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor de tobillo y pie inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Confirmación de hipótesis · Tobillo y pie

PhysiQ-Assessment · fase 4b. Los tests de cada hipótesis, sus LR y si puntúan. El criterio de cada test, por qué se hace, sus fuentes, «Ampliar con IA» y una calculadora que puntúa cada hipótesis con los tests que marques, en la guía de consulta (QR).

Porqués, IA y calculadora
v. 7beddce2

1 Esguince Lateral Agudo (LPAA y LPC)

Test	LR+	LR−	Papel
Reglas de Ottawa (si no carga)	—	—	hallazgo
LPAA: palpar y estirar	—	—	hallazgo
LPC: palpar y estirar	—	—	hallazgo
Cajón anterior (a los 4–6 días)	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

2 Lesión de la Sindesmosis

Test	LR+	LR−	Papel
Palpación del LTPAI	—	—	hallazgo
Squeeze test	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

3 Rotura del Aquiles

Test	LR+	LR−	Papel
Thompson (Simmonds)	14	0.04	puntúa
Hueco palpable	6.6	0.30	puntúa
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

4 Lesión de Lisfranc

Test	LR+	LR−	Papel
Neurovascular y cinco P	—	—	hallazgo
Equimosis plantar	—	—	hallazgo
Dolor en todo el ancho del mediopié	—	—	hallazgo
1.º y 2.º MT en direcciones opuestas	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

5 Fracturas del Pie (5.º MT, Calcáneo)

Test	LR+	LR−	Papel
Reglas de Ottawa de tobillo y de pie	—	0.08	puntúa
5.º MT: dolor en la base	—	—	hallazgo
Calcáneo: talón doloroso con equimosis	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

6 Luxación del Tibial Posterior

Test	LR+	LR−	Papel
Hinchazón y equimosis perimaleolar medial	—	—	hallazgo
Resalte con la flexión dorsal y plantar	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

7 Pinzamiento Posterior del Tobillo

Test	LR+	LR−	Papel
Test de pinzamiento posterior	—	—	hallazgo
Hinchazón y dolor por detrás del astrágalo	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

8 Tendinopatía del Aquiles, Porción Media

Test	LR+	LR−	Papel
Batería progresiva de carga	—	—	hallazgo
Descarga en el salto	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

9 Tendinopatía Insercional del Aquiles

Test	LR+	LR−	Papel
Dolor con carga y flexión dorsal	—	—	hallazgo
Salto con el talón elevado frente a aterrizaje	—	—	hallazgo
ETM monopodal sobre plano inclinado	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

10 Afectación de la Vaina del Aquiles

Test	LR+	LR−	Papel
Crepitación en flexión plantar y dorsal	—	—	hallazgo
ETM en rango amplio	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

11 Tendinopatía del Plantar Delgado

Test	LR+	LR−	Papel
ETM sobre un step en todo el rango	—	—	hallazgo
Marcha descalzo	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

12 Neuropatía del Nervio Sural

Test	LR+	LR−	Papel
Tinel a lo largo del sural	—	—	hallazgo
Palpación en prono con flexión dorsal pasiva	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

13 Bursitis Calcánea Superficial

Test	LR+	LR−	Papel
Dolor superficial e hinchazón a la presión	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

14 Tendinopatía del Tibial Posterior

Test	LR+	LR−	Papel
Dolor retromaleolar medial	—	—	hallazgo
Inversión resistida	—	—	hallazgo
ETM: el retropié no va a varo	—	—	hallazgo
«Demasiados dedos»	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

15 Tendinopatía del Flexor Largo del Primer Dedo (FHL)

Test	LR+	LR−	Papel
Flexoextensión del primer dedo en flexión plantar completa	—	—	hallazgo
Crepitación e hinchazón en la vaina	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

16 Síndrome del Túnel del Tarso

Test	LR+	LR−	Papel
Tinel a lo largo del túnel	—	—	hallazgo
Hinchazón en el túnel o la subastragalina posterior	—	—	hallazgo
Explorar el FHL	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

17 Fractura de Estrés del Tobillo (Maléolo Medial, Astrágalo, Calcáneo)

Test	LR+	LR−	Papel
Dolor óseo a la palpación	—	—	hallazgo
Calcáneo: compresión medial y lateral a la vez	—	—	hallazgo
Astrágalo: hinchazón en el seno del tarso o posterior	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

LR en **verde**: multiplica la puntuación (LR+ ≥ 2 o LR− ≤ 0,5); en gris: no informativa, cuenta como hallazgo. «≈» = calculada de S y E. **puntúa**: puede mover la puntuación · hallazgo: sin LR aplicable · en clúster: solo cuenta con su clúster 🧩 · pronóstico: no entra en la puntuación. Criterio completo de cada test, fuentes y calculadora de la puntuación, en la guía (QR).

PhysiQ-Assessment · fase 4b · Tobillo y pie. Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Confirmación de hipótesis · Tobillo y pie (continuación)

18 Síndrome del Seno del Tarso

Test	LR+	LR−	Papel
Palpación del seno del tarso	—	—	hallazgo
Estrés en inversión de la subastragalina o KTW (rodilla a la pared) con pronación	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

19 Tendinopatía de los Peroneos

Test	LR+	LR−	Papel
Dolor retromaleolar lateral	—	—	hallazgo
Subluxación de los peroneos	—	—	hallazgo
Crepitación e hinchazón	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

20 Pinzamiento Anterior del Tobillo

Test	LR+	LR−	Papel
KTW (rodilla a la pared)	—	—	hallazgo
Palpación anterior	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo
Signo de pinzamiento de Molloy	≈7.9	≈0.06	puntúa

21 Inestabilidad Crónica del Tobillo

Test	LR+	LR−	Papel
Hinchazón articular	—	—	hallazgo
Cajón anterior: signo del surco	—	—	hallazgo
Laxitud subastragalina	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

22 Sinovitis Postraumática

Test	LR+	LR−	Papel
Hinchazón y dolor a la palpación	—	—	hallazgo
Laxitud del LPAA y del LPC	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

23 Coalición Tarsiana

Test	LR+	LR−	Papel
Movilidad subastragalina y mediotarsiana	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

24 Artrosis de Tobillo o Pie

Test	LR+	LR−	Papel
Perfil clínico	—	—	hallazgo
Palpación de la interlínea	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

25 Osteocondritis Disecante del Astrágalo

Test	LR+	LR−	Papel
Palpación de la cúpula astragalina en flexión plantar	—	—	hallazgo
Hinchazón, derrame, crepitación	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

26 Dolor Plantar Crónico del Talón

Test	LR+	LR−	Papel
Palpación de la tuberosidad medial del calcáneo	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

27 Síndrome de la Almohadilla Grasa del Talón

Test	LR+	LR−	Papel
Palpación posterolateral del talón	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

28 Atrapamiento Nervioso del Talón

Test	LR+	LR−	Papel
Tinel sobre el nervio calcáneo medial	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

29 Lesión Calcaneocuboidea y Cubometatarsiana

Test	LR+	LR−	Papel
Aguda: palpación calcaneocuboidea	—	—	hallazgo
Gradual: interlíneas del cuboides	—	—	hallazgo
Carga del antepié e inicio de la ETM	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

30 Fractura de Estrés del Mediopié (Navicular, Cuboides, Cuñas)

Test	LR+	LR−	Papel
Punto N	—	—	hallazgo
Dolor puntual sobre cuboides o cuñas	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

31 Lesión de la 1.ª Metatarsofalángica

Test	LR+	LR−	Papel
Equimosis e hinchazón en la interlínea	—	—	hallazgo
Rango de la 1.ª MTF frente al lado sano	—	—	hallazgo
Dolor sobre los sesamoideos	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

32 Dolor en la Base del 2.º Metatarsiano

Test	LR+	LR−	Papel
Palpación de la base del 2.º MT y de Lisfranc	—	—	hallazgo
Estrés frente a sinovitis	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

33 Fractura de Estrés del Cuello de un Metatarsiano (Fractura de Marcha)

Test	LR+	LR−	Papel
Dolor puntual sobre el cuello	—	—	hallazgo
Carga axial del MT	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

34 Neuroma de Morton o Bursitis Intermetatarsiana

Test	LR+	LR−	Papel
Palpación del espacio con compresión de los metatarsianos	—	—	hallazgo
Diferencial del antepié	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

35 Gota

Test	LR+	LR−	Papel
Articulación roja, hinchada y muy dolorosa	—	—	hallazgo
Suele estar sistémicamente bien	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

36 Apofisitis y Osteocondrosis Pediátricas (Sever, Iselin, Köhler, Freiberg)

Test	LR+	LR−	Papel
Sever: inserción del Aquiles (8–12 años)	—	—	hallazgo
Iselin: base del 5.º MT (8–13 años)	—	—	hallazgo
Navicular: apofisitis del tibial posterior o Köhler	—	—	hallazgo
Freiberg: cabeza del 2.º–4.º MT (14–18 años)	—	—	hallazgo

37 Fractura de Tobillo (Maleolar)

Test	LR+	LR−	Papel
Regla de Ottawa de tobillo	—	0.03	puntúa
No carga cuatro pasos	—	—	hallazgo
Palpar el peroné hasta la rodilla	—	—	hallazgo
Estado neurovascular	—	—	hallazgo

LR en **verde**: multiplica la puntuación (LR+ ≥ 2 o LR− ≤ 0,5); en gris: no informativa, cuenta como hallazgo. «≈» = calculada de S y E. **puntúa**: puede mover la puntuación · hallazgo: sin LR aplicable · en clúster: solo cuenta con su clúster 🧩 · pronóstico: no entra en la puntuación. Criterio completo de cada test, fuentes y calculadora de la puntuación, en la guía (QR).

PhysiQ-Assessment · fase 4b · Tobillo y pie. Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0